

Bunga Rampai **PENDAMPINGAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA PUTRI**

Vivin Indrianita • Lusiana Ambarsari • Meriem Meisyaroh Syamson
Dita Humaeroh • Amrina Nur Rohmah
Cynthia Puspariny • Hasnah

Editor: Nurna Ningsih



BUNGA RAMPAI: PENDAMPINGAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA PUTRI

Penulis:

Vivin Indrianita, S.ST., M.Psi.

Lusiana Ambarsari, S.Tr.Keb., M.Keb.

Ns. Meriem Meisyaroh Syamson, S.Kep., M.Kes.

Dr. Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., M.K.M.

Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Cynthia Puspariny, S.S.T., Bdn., M.Kes.

Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:

Nurna Ningsih, S.Kp., M.Kes.

Bunga Rampai : Pendampingan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putri

Penulis:

Vivin Indrianita, S.ST., M.Psi.
Lusiana Ambarsari, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ns. Meriem Meisyaroh Syamson, S.Kep., M.Kes.
Dr. Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., M.K.M.
Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Cynthia Puspariny, S.S.T., Bdn., M.Kes.
Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor: Nurna Ningsih, S.Kp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-23-7

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai “Pendampingan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri” ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya memperkaya referensi sekaligus memperkuat praktik pendampingan kesehatan reproduksi bagi remaja putri yang semakin membutuhkan pendekatan edukatif, empatik, dan berbasis bukti.

Masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada fase ini, remaja putri perlu mendapatkan informasi yang benar, ruang dialog yang aman, serta dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan sekolah agar mampu menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendampingan yang tepat diharapkan dapat membantu remaja memahami tubuhnya, mengelola kesehatan menstruasi, mencegah anemia dan malnutrisi, serta menghindari perilaku berisiko.

Bunga rampai ini disusun secara sistematis melalui tujuh chapter. Chapter 1 membahas konsep dasar kesehatan reproduksi remaja putri sebagai fondasi pemahaman. Chapter 2 menguraikan perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja sebagai konteks pendampingan. Chapter 3 menitikberatkan pada menstruasi sehat serta penanganan masalah menstruasi yang sering dialami remaja. Chapter 4 membahas pencegahan anemia, malnutrisi, dan perilaku berisiko yang berdampak pada kesehatan remaja. Chapter 5 menyajikan edukasi personal hygiene dan praktik sehat yang relevan dalam keseharian. Chapter 6 menegaskan peran bidan, keluarga, dan sekolah sebagai jejaring pendamping utama remaja putri. Terakhir, Chapter 7 menguraikan evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai langkah menjaga mutu dan keberlanjutan program.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, mitra penelaah, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga bunga rampai ini bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan (khususnya bidan), pendidik, orang tua, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pendampingan remaja putri. Kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan; oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Juni, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CHAPTER 1 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Prinsip Dasar Kesehatan Reproduksi	2
C. Definisi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	2
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Remaja	3
E. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	6
F. Pendidikan KRR Berbasis Sekolah.....	7
G. Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Berdasarkan Konvensi Internasional, Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Indonesia.....	9
H. PENANGANAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA.....	10
Referensi	11
CHAPTER 2 PERUBAHAN BIOLOGIS, PSIKOLOGIS, DAN SOSIAL PADA MASA REMAJA.....	12
A. Pendahuluan.....	12
B. Pengertian Masa Remaja.....	13
C. Perubahan Biologis pada Remaja Putri.....	15
D. Perubahan Psikologis pada Remaja	20
E. Perubahan Sosial pada Remaja.....	30
F. Simpulan	39
Referensi	41
Glosarium.....	49
CHAPTER 3 MENSTRUASI SEHAT DAN PENANGANAN MASALAH MENSTRUASI REMAJA.....	52
A. Definisi dan Konsep Menstruasi Sehat.....	52
B. Variasi Normal pada Remaja Awal.....	54
C. Perkembangan Remaja dan Menarche.....	56
D. Menstruasi Sehat pada Remaja	57
E. Nutrisi dan Gaya Hidup	58
F. Kesehatan Mental dan Menstruasi	60

G. Masalah Menstruasi pada Remaja	61
H. Gangguan Siklus Menstruasi pada Remaja	63
I. Penatalaksanaan Masalah Menstruasi.....	65
Referensi	67

CHAPTER 4 PENCEGAHAN ANEMIA, MALNUTRISI, DAN PERILAKU BERISIKO PADA REMAJA..... 69

A. Pendahuluan.....	69
B. Anemia dan Malnutrisi pada Remaja.....	72
C. Dampak Anemia dan Malnutrisi terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja	78
D. Strategi Pencegahan Anemia dan Malnutrisi pada Remaja	79
E. Deteksi Dini dan Penanganan Anemia serta Malnutrisi.....	83
F. Perilaku Berisiko Pada Remaja	84
G. Simpulan	87
Referensi	89

CHAPTER 5 EDUKASI PERSONAL HYGINE DAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA..... 91

A. Konsep Dasar Remaja.....	91
B. Konsep Personal hygiene pada Remaja.....	92
C. Komponen Utama Personal Hygiene pada Remaja.....	95
D. Personal hygiene Organ Reproduksi Remaja	96
E. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja.....	101
F. Organ Reproduksi Remaja.....	104
G. Pubertas pada Remaja	107
H. Masalah Kesehatan Reproduksi pada Remaja.....	110
Referensi	114
Glosarium.....	117

CHAPTER 6 PERAN BIDAN, KELUARGA, DAN SEKOLAH DALAM PENDAMPINGAN REMAJA PUTRI..... 120

A. Pendahuluan.....	120
B. Konsep Pendampingan Remaja Putri.....	121
C. Peran Bidan dalam Pendampingan Remaja Putri	124
D. Peran Keluarga dalam Pendampingan Remaja Putri	128
E. Peran Sekolah dalam Pendampingan Remaja Putri.....	132

F. Kolaborasi Bidan, Keluarga, dan Sekolah dalam Pendampingan Remaja Putri	135
G. Simpulan	139
Referensi	140
Glosarium	143

CHAPTER 7 EVALUASI PROGRAM EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

A. Pendahuluan.....	144
B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja	145
C. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	148
D. Konsep Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	151
E. Desain dan Implementasi Program Edukasi.....	155
F. Model dan Pendekatan Evaluasi Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	160
G. Kesimpulan.....	162
Referensi	164
PROFIL PENULIS	167



CHAPTER 1



KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Vivin Indrianita, S.ST., M.Psi.

A. Pendahuluan

1. Kesehatan reproduksi remaja merujuk pada kondisi yang sehat dalam hal sistem, fungsi, dan proses reproduksi, yang juga mencakup kesehatan mental, sosial, serta budaya. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 menyatakan bahwa remaja perlu memahami kesehatan reproduksi dan seksual. Selain itu, remaja dianggap sebagai aset negara yang memerlukan perhatian khusus. Menurut Jarssa, Lodebo, dan Suloro, sekitar 16,8% populasi dunia adalah remaja, dengan 80% di antaranya berada di negara berkembang. Berdasarkan data Sakernas, 62,89% remaja Indonesia berusia 15-19 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar. Proyeksi populasi menunjukkan adanya lonjakan pada tahun 2030, di mana sebagian besar remaja akan berada dalam usia reproduksi. (Mareti and Nurasa, 2022).
2. Remaja berusia 15-19 tahun termasuk dalam kelompok usia yang berisiko, dengan 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki diperkirakan berada pada risiko tersebut. Data dari Puslitbang pada tahun 2015 mencatat bahwa 8,26% remaja laki-laki dan 4,17% remaja perempuan telah melakukan hubungan seksual pranikah, yang meningkatkan risiko remaja terkena penyakit menular seksual. (surawan, 2022).
3. Kesehatan reproduksi remaja merupakan topik penting yang sering kali diabaikan atau dihindari dalam percakapan sehari-hari. Namun, memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi remaja sangatlah penting untuk membangun masa depan yang sehat dan bahagia bagi generasi muda. Bab ini akan membahas secara komprehensif tentang kesehatan reproduksi remaja, mulai dari definisi hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja.
4. Beberapa poin penting dalam kesehatan reproduksi remaja, yakni meliputi:
 - a. Perubahan Fisiologis Pada masa remaja, tubuh mengalami berbagai perubahan hormon yang mempengaruhi perkembangan seksual, seperti menstruasi pada remaja putri dan perkembangan alat kelamin pada remaja putra.

- b. Pendidikan Seksual Pengetahuan tentang seksualitas, kontrasepsi, dan pencegahan infeksi menular seksual sangat penting untuk membantu remaja membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab.
- c. Kesehatan Mental dan Emosional Mengatasi stres dan tekanan emosional yang mungkin terkait dengan perubahan tubuh dan hubungan sosial juga merupakan bagian penting dari kesehatan reproduksi.
- d. Peran Keluarga dan Pendidikan Keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar dan mendukung remaja dalam mengelola kesehatan reproduksi mereka.

B. Prinsip Dasar Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi pada prinsipnya merupakan kesejahteraan fisik, psikologis maupun sosial yang menyeluruh dan tidak terlepas oleh penyakit yang meliputi segala yang berhubungan dengan fisiologis dan proses reproduksi (Dian Permatasari, 2021).

Kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk perencanaan kehamilan dan persalinan yang aman secara medis juga merupakan prinsip dasar yang harus diperhatikan, namun bukan hanya kaum perempuan, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi lansia, kesehatan ibu dan anak serta permasalahan-permasalahan lain juga sangat berkaitan dengan prinsip dasar kesehatan reproduksi. Hal tersebut dikarena akan berdampak luas dan menyangkut berbagai aspek kehidupan sehingga akan menjadi tolok ukur dalam pelayanan kesehatan. Problem lain tentang pemahaman mengenai kesehatan reproduksi juga dialami para remaja saat ini (Hasanah, 2017).

C. Definisi Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Kesehatan reproduksi remaja mengacu pada kondisi fisik, mental, dan sosial remaja terkait dengan fungsi seksual dan reproduksinya. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan seksual, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS), serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjamin (Mareti and Nurasa, 2022).
2. Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan kesehatan baik secara fisik, mental maupun sosial yang terkait dengan system reproduksi pada remaja, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan (Mahmud and Darmawan, 2023).
3. Kesehatan reproduksi remaja adalah salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup generasi muda. Kesehatan reproduksi tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial, dan

budaya. Mengingat pentingnya masa remaja sebagai periode transisi dalam kehidupan, memahami isu-isu kesehatan reproduksi di kalangan remaja menjadi hal yang krusial untuk memastikan perkembangan yang sehat secara holistik. (Saputro, 2018).

4. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan sehat jasmani, psikologis, dan sosial yang berhubungan dengan fungsi dan proses system reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan factor penting yang harus mendapat perhatian masyarakat sehat untuk (Djama, mewujudkan 2017). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai individu berusia 10-24 tahun yang belum menikah (BKKBN, 2019).

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi fisik, psikologis, social, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesehatan reproduksi :

1. Faktor Fisik dan Biologis

- a. Perubahan Hormonal

Pada masa pubertas, hormon seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki mengalami peningkatan signifikan, yang memicu perkembangan organ reproduksi serta dorongan seksual. Ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi siklus menstruasi atau kesehatan seksual secara keseluruhan.

- b. Perkembangan Organ Reproduksi

Remaja perempuan mulai mengalami menstruasi, sementara remaja laki-laki mengalami produksi sperma pertama kali. Setiap masalah fisik pada organ reproduksi, seperti gangguan siklus menstruasi atau ejakulasi dini, bias mengindikasikan masalah kesehatan reproduksi.

- c. Gizi dan Nutrisi

Kekurangan nutrisi atau gizi buruk dapat memperlambat perkembangan seksual dan organ reproduksi. Sebaliknya nutrisi yang baik diperlakukan untuk mendukung perkembangan organ reproduksi dan sistem hormon yang sehat.

- d. Kesehatan Fisik dan Penyakit

Penyakit Menular Seksual (PMS), infeksi saluran reproduksi atau penyakit kronis seperti diabetes bisa berdampak serius pada kesehatan reproduksi remaja. Misalnya PMS seperti gonore, klamidia atau HIV/AIDS bias menyebabkan infertilitas bila tidak ditangani dengan baik.

2. Faktor Psikologis dan Mental

a. Pendidikan Seksual

Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menyebabkan remaja lebih rentan melakukan perilaku berisiko, seperti hubungan seksual tanpa perlindungan. Pendidikan yang baik bias membantu remaja membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi.

b. Pengaruh Stress dan Tekanan Psikologis

Remaja sering menghadapi tekanan akademis, social atau emosional yang bisa mempengaruhi perilaku seksual mereka. Kesehatan mental yang buruk, seperti depresi atau kecemasan dapat menyebabkan perilaku seksual impulsive atau berisiko.

c. Kepercayaan Diri dan Citra Tubuh

Remaja dengan citra tubuh yang negatif atau rendahnya kepercayaan diri mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh pasangan atau teman sebaya dalam mengambil keputusan yang tidak sehat terkait seksualitas.

3. Faktor Sosial dan Budaya

a. Norma Sosial dan Nilai Budaya

Norma masyarakat dan nilai-nilai agama dapat mempengaruhi bagaimana remaja memandang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Di beberapa masyarakat, diskusi terbuka tentang seksualitas dianggap tabu, sehingga remaja kesulitan mendapatkan informasi yang tepat.

b. Tekanan dari teman Sebaya (Peer Pressure)

Remaja sering kali merasa terdorong untuk meniru perilaku teman sebaya, termasuk dalam hal aktivitas seksual. Tekanan ini dapat membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual berisiko sebelum mereka siap secara emosional dan fisik.

c. Peran Keluarga

Pola asuh orang tua, komunikasi terbuka mengenai pendidikan seksual, dan dukungan emosional dari keluarga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Keluarga yang mendukung dapat membantu remaja membuat keputusan yang baik.

d. Peran Gender dan Ketidaksetaraan

Di beberapa budaya, ketidaksetaraan gender membuat remaja perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan dini atau pernikahan dini. Perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi atau layanan kesehatan reproduksi dibandingkan laki laki.

4. Faktor Ekonomi

a. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan akses

Remaja yang tinggal di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi yang memadai, seperti klinik kesehatan, kontrasepsi atau informasi yang akurat tentang kesehatan seksual. Hal ini meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Biaya Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan rutin, pengobatan PMS atau kontrasepsi kadang-kadang tidak terjangkau bagi remaja dengan latar belakang ekonomi yang kurang baik.

5. Faktor Lingkungan

a. Paparan Media

Media, terutama media social, sangat mempengaruhi pandangan dan perilaku remaja tentang seksualitas. Akses yang tidak terbatas ke konten pornografi atau informasi yang salah memberikan pandangan yang keliru tentang seks dan kesehatan reproduksi.

b. Pendidikan Sekolah

Kurikulum pendidikan kesehatan di sekolah memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang benar kepada remaja tentang kesehatan reproduksi. Sekolah yang memberikan pendidikan kesehatan seksual secara holistik dapat membantu mencegah perilaku seksual berisiko.

c. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan sosial tempat remaja berinteraksi sehari-hari, seperti komunitas, sekolah dan tempat tinggal, dapat mempengaruhi pemikiran dan keputusan mereka tentang kesehatan reproduksi. Lingkungan yang mendukung akan memfasilitasi remaja untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi dengan lebih mudah.

6. Faktor Teknologi dan Informasi

a. Kemudahan Akses Informasi

Dengan kemajuan teknologi, remaja memiliki akses mudah ke berbagai informasi, termasuk tentang seksualitas. Namun, akses yang tidak terfilter dan tidak akurat bias mengarahkan mereka pada informasi yang salah.

b. Peran Internet dan Teknologi

Selain membantu memberikan informasi yang berguna, internet juga bias menjadi tempat remaja terpapar konten negatif seperti pornografi, yang dapat merusak pandangan mereka tentang seks dan hubungan.

7. Faktor Kebijakan dan Layanan Kesehatan

a. Akses ke Layanan Kesehatan Reproduksi

Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi, seperti klinik yang menyediakan kontrasepsi, konseling dan pengobatan penyakit menular seksual, sangat penting untuk mendukung kesehatan reproduksi remaja.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang mendukung program kesehatan reproduksi remaja, termasuk pendidikan seksual di sekolah, pelayanan kesehatan yang ramah remaja, dan akses kontrasepsi, sangat mempengaruhi bagaimana remaja mendapatkan layanan yang mereka butuhkan (Wawan, 2023).

E. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program kesehatan reproduksi remaja adalah salah satu program kesehatan reproduksi. Hal ini menyebabkan pelayanan dan perawatan kesehatan reproduksi bagi remaja memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan remaja yang sehat dan berdaya saing sehingga mampu menjadi komponen unggul dalam pembangunan bangsa. Peningkatan status kesehatan reproduksi merupakan salah satu program dari SDGs atau Sustainable Development Goals yaitu memastikan akses universal terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana telah disetujui oleh program aksi ICPD dan Beijing platform for action.

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab mengenai triad kesehatan reproduksi remaja yaitu mengenai seksualitas, PMS dan HIV/AIDS dan NAPZA. Situasi kesehatan reproduksi remaja di Indonesia saat ini menurut survei demografi dan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi remaja, sekitar 35% remaja mulai berpacaran pada usia 15-19 tahun. Presentasi remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mengaku pernah melakukan seks pranikah mengalami peningkatan dari tahun 2007 yaitu 3.7% menjadi 4.5% pada tahun 2012 dan 57.8% alasannya dikarenakan ingin tahu atau penasaran.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disahkan melalui Peraturan Presiden no. 7 tahun 2005, maka program KRR merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional. Tujuan dari program kesehatan reproduksi remaja secara eksplisit dinyatakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan

kualitas generasi mendatang (Depkes RI, 2003). Beberapa fakta menunjukkan bahwa permasalahan pada remaja perlu mendapat perhatian, misalnya tingkat pengetahuan remaja di Indonesia tentang kesehatan reproduksi masih rendah, khususnya dalam hal cara-cara melindungi diri terhadap risiko kesehatan reproduksi, seperti pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan, Infeksi Menular Seksual, serta HIV dan AIDS. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja (SKRRI) tahun 2002-2003 yang dilakukan oleh BPS memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan dasar penduduk usia 15-24 tahun tentang ciri-ciri pubertas sudah cukup baik, namun dalam hal pengetahuan tentang masa subur, risiko kehamilan, dan anemia relatif masih rendah.

F. Pendidikan KRR Berbasis Sekolah

Pendidikan KRR berbasis sekolah merupakan salah satu alternatif strategi yang tepat karena dapat mencakup semua tantangan permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Pendidikan KRR yang dilakukan oleh sekolah merupakan salah satu upaya untuk membimbing remaja mengatasi konflik seksualnya. Oleh berbagai pihak, sekolah dan guru dianggap sebagai pihak yang layak memberikan pendidikan KRR ini (Depkes RI, 2003). Pendidikan KRR untuk memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan, PMS, HIV/AIDS, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan dampaknya, serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yg sehat (fisik, mental, ekonomi, spiritual). Pendidikan KRR dapat diwujudkan dalam penyuluhan, bimbingan dan konseling, pencegahan, penanganan masalah yang berkaitan dengan KRR termasuk upaya mencegah masalah perinatal yang dapat dialami oleh ibu dan anak yang dapat berdampak pada anggota keluarga lainnya (Depkes RI, 2005).

Sasaran KRR adalah sebagai berikut :

1. Sasaran utama: kelompok remaja berusia 10–19 tahun di sekolah maupun di luar sekolah,
2. Sasaran sekunder: orang tua, keluarga yang mempunyai anak remaja, guru/pamong belajar, organisasi pemuda, pemimpin agama,
3. Sasaran tersier: petugas kesehatan, petugas lintas sektoral, LSM, organisasi masyarakat.
4. KRR memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum: Meningkatkan kualitas remaja melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Tujuan Khusus a) Meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah dan non pemerintah, b) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi remaja melalui peningkatan fungsi, peran dan mekanisme kerja di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, c) Meningkatnya keterpaduan dan kemitraan pelaksanaan program KRR bagi seluruh sektor terkait, di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun kebijakan dan Strategi KRR adalah mewujudkan TEGAR REMAJA, dalam rangka Tegar Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera sebagai misi Keluarga Berencana Nasional. Kehidupan remaja adalah tahap transisi kehidupan yang memiliki 5 masa transisi kehidupan (five life transitions of youth) pada saat remaja dihadapkan untuk mengambil keputusan dalam lima bidang kehidupan yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, dan mempraktekkan hidup sehat. Dalam mengambil keputusan di setiap bidang tersebut ternyata sangat tergantung pada cara remaja mengambil keputusan untuk bisa mempraktekkan hidup sehat. Keputusan apakah remaja mempraktekkan atau tidak mempraktekkan hidup sehat akan mewarnai kualitas kehidupan pada 4 bidang kehidupan yang lain. Mempraktekkan pola hidup sehat pada masa transisi kehidupan remaja adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan TEGAR REMAJA. Adapun ciri TEGAR REMAJA adalah menunda usia pernikahan, berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD-KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, dan napza), bercita-cita mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Ruang Lingkup Program KRR Secara garis besar ruang lingkup program KRR meliputi perkembangan seksualitas dan resiko (termasuk pubertas, anatomi dan fisiologi organ reproduksi dan kehamilan tidak diinginkan) dan penundaan usia kawin, kedua adalah pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS, ketiga adalah pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), dan terakhir adalah masalah masalah remaja yang terkait dengan dampak dari resiko TRIAD KRR seperti: kenakalan remaja, perkalahian antar remaja dan lain-lain.

G. Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Berdasarkan Konvensi Internasional, Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Indonesia

Hak reproduksi sebagai bagian dari hak sasi manusia dijamin dalam beberapa perjanjian internasional seperti The Convention On The Eliminationall From Of Discrimination Again Woment (CEDAW) ICPD ke 4 di Kairo dan konfensi yang ke 4 tentang perempuan di Beijing (1995), hak-hak tersebut meliputi :

1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, hak tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan Kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun keluarga.
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan Kesehatan reproduksi, meliputi hak atas informasi keterjangkauan, pilihan, keamanan kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat diri, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat.
3. Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi, artinya setiap orang mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar menetapkan masalah hak dan kesehatan reproduksi sebagai prioritas dalam kebijakan politik negara.
4. Hak untuk bebas dari segala bentuk deskriminasi dan kesehatan reproduksi.
5. Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengakuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
6. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi.
7. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak.
8. Hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan.
9. Hak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kesehatan reproduksinya.
10. Hak untuk bebas dari segala penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi, termasuk hak anak anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual
11. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksi.
12. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

H. PENANGANAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Ruang lingkup masalah kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut :

1. Gizi seimbang.
2. Informasi tentang kesehatan reproduksi.
3. Pencegahan kekerasan, termasuk seksual.
4. Pencegahan terhadap ketergantungan NAPZA.
5. Pernikahan pada usia wajar.
6. Pendidikan dan peningkatan ketrampilan.
7. Peningkatan penghargaan diri.
8. Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman.

Referensi

- Dian Permatasari, E.S. (2021) 'Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja', Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM CSR), 5(1), pp. 1–10. Available <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1461>.
- Hasanah, H. (2017) 'PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja', Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), p. 229. Available at: <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>.
- Mansyur, A.R. (2020) 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', Education and Learning Journal, Vol. 1, No, pp. 113–123.
- Rohan, hasdianah hasan and Siyoto, S. (2020) Buku Ajar Kesehatan Reproduksi.
- World Health Organization, 2008. The Top Ten Causes of Death. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310_2008.pdf.
- BKKBN, (2017), Pedoman pelaksanaan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. (2017). Jakarta: BKKBN.
- Mega, Wijayanegara H. (2017). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Amanda, T. A., & Tama, M. M. L. (2022). PSIKOEDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PERILAKUSEKS BEBAS PADA REMAJA DI DESA TANGSI AGUNG. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 02 (02), 1125 –1130



CHAPTER 2



PERUBAHAN BIOLOGIS, PSIKOLOGIS, DAN SOSIAL PADA MASA REMAJA

Lusiana Ambarsari, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan karena berkaitan erat dengan kualitas kesehatan individu pada masa dewasa (Zenebe et al., 2023). Masa remaja merupakan periode perkembangan yang sangat dinamis, ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara cepat serta saling memengaruhi (Lirios et al., 2024). Pada fase ini, remaja mulai mengalami pematangan organ reproduksi, perubahan hormonal, perkembangan kemampuan berpikir yang lebih kompleks, serta perubahan dalam pola hubungan sosial dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan yang lebih luas (Argente et al., 2023). Berbagai perubahan tersebut merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang, namun juga dapat menjadi periode yang rentan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan pendampingan yang tepat (Bennett et al., 2023).

Pada remaja putri, perubahan yang terjadi sering kali memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan langsung dengan perkembangan sistem reproduksi (Argente et al., 2023). Pubertas, menstruasi, perubahan bentuk tubuh, serta fluktuasi hormonal tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi emosional, citra tubuh, kepercayaan diri, serta cara remaja berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Rodgers et al., 2023). Pada saat yang sama, remaja juga mulai menghadapi pengaruh teman sebaya yang semakin kuat, dinamika hubungan dengan keluarga, serta paparan media digital yang dapat membentuk nilai, perilaku, dan pengambilan keputusan terkait kesehatan (Bennett et al., 2023). Tanpa pendampingan yang memadai, berbagai perubahan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, hingga meningkatkan kerentanan terhadap perilaku yang berisiko (van Duijvenvoorde et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pola perilaku kesehatan mulai terbentuk pada masa remaja dan dapat berlanjut hingga dewasa (Allen et al., 2022; Argente et al., 2023; Bennett et al., 2023). Pengetahuan yang terbatas mengenai perubahan tubuh, kesehatan reproduksi, maupun hubungan interpersonal dapat

menyebabkan remaja memperoleh informasi dari sumber yang kurang akurat, termasuk lingkungan pertemanan atau media digital. Selain itu, keterbatasan komunikasi dalam keluarga, kurangnya edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja, serta pengaruh lingkungan sosial juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan reproduksi (Bennett et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi remaja tidak hanya dipengaruhi oleh aspek biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor psikologis dan sosial yang saling berinteraksi (Bennett et al., 2023; van Duijvenvoorde et al., 2022).

Pendampingan kesehatan reproduksi pada remaja putri memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh dinamika perkembangan yang terjadi (Bennett et al., 2023). Pemahaman terhadap perubahan biologis penting untuk membantu remaja mengenali pubertas dan fungsi reproduksinya secara sehat, sedangkan pemahaman terhadap perubahan psikologis dan sosial diperlukan untuk mendukung kesehatan mental, pembentukan identitas diri, hubungan interpersonal yang sehat, serta kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Argente et al., 2023; van Duijvenvoorde et al., 2022). Oleh karena itu, pembahasan mengenai perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja menjadi landasan penting dalam upaya pendampingan kesehatan reproduksi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan remaja putri (Bennett et al., 2023).

B. Pengertian Masa Remaja

Masa remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung secara cepat, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Secara umum, World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa remaja berada pada rentang usia 10–19 tahun (World Health Organization (WHO), 2020). Namun, batasan usia ini tidak selalu bersifat kaku karena perkembangan remaja juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Dengan demikian, pemahaman tentang remaja perlu ditinjau secara lebih komprehensif, tidak hanya dari usia kronologis tetapi juga dari proses perkembangan yang dialami individu.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mendefinisikan remaja sebagai individu berusia 10 tahun hingga sebelum 18 tahun (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan rentang usia yang lebih luas, yaitu 10–24 tahun dengan status belum menikah (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023). Perbedaan definisi ini menunjukkan bahwa masa remaja tidak hanya berkaitan

dengan penambahan usia, tetapi juga dengan kesiapan individu dalam menghadapi peran dewasa. Oleh karena itu, pendekatan dalam memahami remaja perlu mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, dan sosial.

Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Perubahan fisik ditandai dengan dimulainya pubertas dan kematangan organ reproduksi, sedangkan dari sisi psikologis remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Selain itu, remaja juga mulai membentuk identitas diri dan nilai-nilai yang akan dipegang dalam kehidupan. Perubahan sosial turut terjadi, di mana remaja mulai memperluas hubungan dengan teman sebaya dan lingkungan di luar keluarga (Orben et al., 2020; Zanolie et al., 2022).

Masa remaja juga merupakan periode penting dalam pembentukan dasar kesehatan jangka panjang. Pada fase ini, individu mulai membentuk berbagai kebiasaan yang akan berpengaruh hingga dewasa, seperti pola makan, aktivitas fisik, serta perilaku kesehatan reproduksi. Kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, masa remaja sering disebut sebagai periode yang strategis sekaligus rentan apabila tidak disertai dengan pendampingan yang tepat (Guthold et al., 2023; Ross et al., 2020).

Dari sisi kesehatan, remaja sering dianggap sebagai kelompok yang relatif sehat. Namun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa risiko masalah kesehatan, baik yang berkaitan dengan perilaku maupun lingkungan, tetap cukup tinggi pada kelompok usia ini. Banyak masalah tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi dan intervensi yang tepat (World Health Organization (WHO), 2020). Hal ini menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif pada remaja memiliki peran yang sangat penting.

Kementerian Kesehatan RI menekankan bahwa kesehatan remaja tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh pola hidup sehari-hari. Pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan remaja. Remaja dengan status gizi yang baik umumnya memiliki indikator pertumbuhan yang sesuai, seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT) yang seimbang dengan usianya. Selain itu, pemenuhan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Remaja diharapkan mampu mengelola emosi, mengambil keputusan secara bijak, serta bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Kemampuan ini menjadi dasar dalam mencegah berbagai perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan. Dukungan dari lingkungan, baik

keluarga maupun sekolah, sangat berperan dalam membantu remaja mencapai kondisi kesehatan mental yang baik (World Health Organization (WHO), 2022).

Upaya kesehatan remaja perlu diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan potensi diri, pencegahan kekerasan dan kecelakaan, peningkatan kesehatan reproduksi, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pemenuhan gizi, aktivitas fisik, serta kesehatan jiwa remaja (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Sementara Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar upaya tersebut dapat berjalan secara efektif.

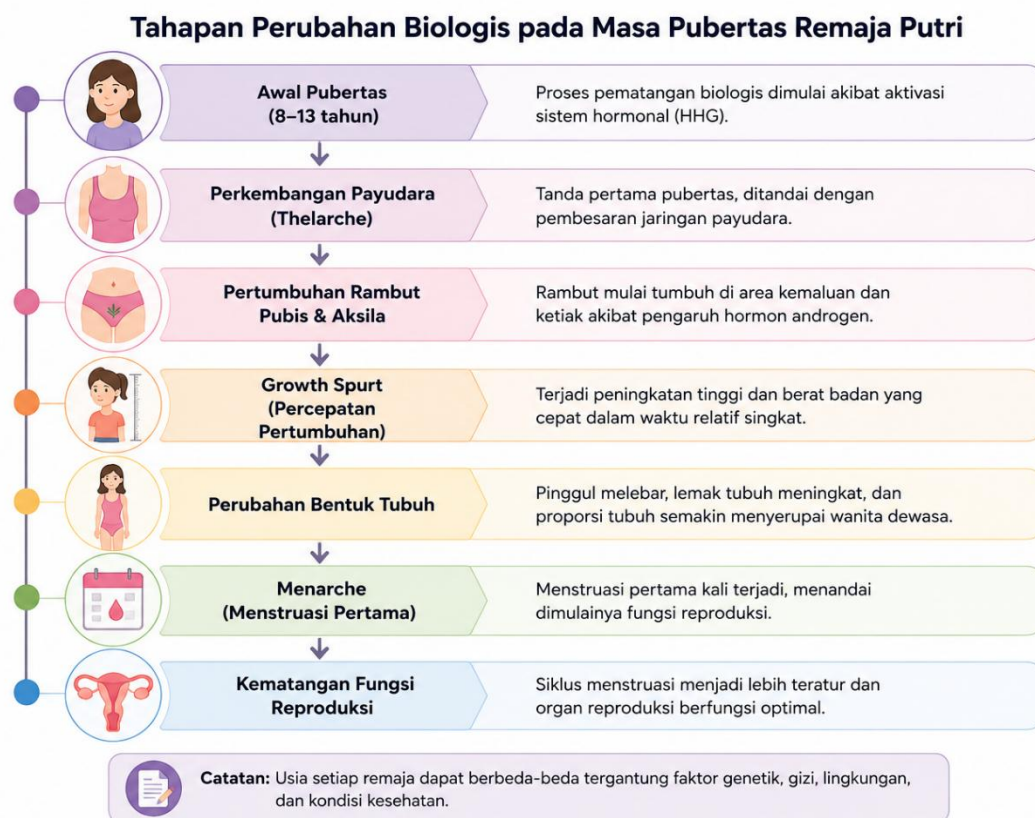
Masa remaja umumnya dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Setiap tahapan memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023). Pembagian ini penting untuk memahami kebutuhan remaja secara lebih spesifik. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tahap perkembangannya.

Masa remaja merupakan fase yang krusial dalam siklus kehidupan manusia. Periode ini tidak hanya ditandai oleh perubahan fisik, tetapi juga oleh perkembangan mental dan sosial yang kompleks. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik remaja menjadi dasar penting dalam memberikan pendampingan yang tepat. Hal ini sangat relevan terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi remaja putri.

C. Perubahan Biologis pada Remaja Putri

Perubahan biologis merupakan aspek perkembangan yang paling nyata selama masa remaja dan menjadi penanda utama dimulainya pubertas. Proses ini terjadi akibat aktivasi sistem hormonal melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (*hypothalamic–pituitary–gonadal axis/HPG axis*), yang berperan dalam mengatur pelepasan hormon reproduksi (Anderson et al., 2024). Hormon utama yang berperan dalam proses ini adalah estrogen dan progesteron, yang berfungsi dalam pematangan organ reproduksi serta munculnya karakteristik seksual sekunder pada remaja putri (Calcaterra et al., 2022). Aktivasi hormonal tersebut tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan fisik, perubahan fisiologis, serta aspek emosional remaja. Dengan demikian, perubahan biologis pada masa remaja merupakan proses perkembangan yang kompleks dan saling berkaitan.

Proses perubahan biologis berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, status gizi, kondisi kesehatan, serta lingkungan sosial (Anderson et al., 2024; Faienza et al., 2022). Oleh karena itu, setiap remaja dapat mengalami waktu dan pola perkembangan yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari variasi normal perkembangan manusia, meskipun dalam beberapa kondisi dapat menimbulkan kebingungan atau kekhawatiran apabila remaja tidak memiliki pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, edukasi yang tepat sangat penting agar remaja mampu memahami perubahan biologis sebagai bagian alami dari proses tumbuh kembang.



Gambar 2. 1 Tahapan Perubahan Biologis pada Masa Pubertas Remaja Putri

1. Pubertas pada Remaja Putri

Pubertas merupakan tahap perkembangan biologis yang menandai dimulainya kematangan seksual dan reproduksi. Pada remaja putri, pubertas umumnya dimulai pada usia 8–13 tahun, meskipun waktu kemunculannya dapat berbeda pada setiap individu (Eckert-Lind et al., 2020). Proses ini diawali dengan aktivasi hormon melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (*hypothalamic–pituitary–gonadal axis*), yang merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen, kemudian memicu perkembangan organ reproduksi dan perubahan fisik khas pada perempuan (Anderson et al., 2024). Pubertas berlangsung secara bertahap

selama beberapa tahun hingga tercapai kematangan reproduksi. Selama periode ini, tubuh mengalami berbagai perubahan sebagai respons terhadap peningkatan aktivitas hormonal (Rosenfield, 2021).

Pubertas pada remaja putri ditandai oleh serangkaian perubahan fisik yang umumnya muncul dalam urutan tertentu, meskipun waktu kemunculannya dapat bervariasi (Rosenfield, 2021). Tanda-tanda tersebut meliputi:

- a. Pertumbuhan payudara (*thelarche*), yang umumnya menjadi tanda awal pubertas.
- b. Pertumbuhan rambut pubis dan aksila, sebagai respons terhadap peningkatan hormon androgen adrenal.
- c. Percepatan pertumbuhan tinggi badan (*growth spurt*), yang terjadi akibat peningkatan hormon pertumbuhan dan hormon seks.
- d. Perubahan distribusi lemak tubuh, terutama pada area pinggul dan paha, sehingga membentuk kontur tubuh yang lebih feminin. (Rosenfield, 2021).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami proses pematangan biologis menuju fase dewasa. Selain perubahan fisik yang tampak, pubertas juga menuntut kesiapan remaja dalam memahami perubahan yang terjadi pada dirinya. Tanpa informasi yang memadai, remaja dapat mengalami rasa malu, cemas, atau salah persepsi terhadap perubahan tubuhnya (Lee et al., 2023). Oleh karena itu, pemberian edukasi sejak awal pubertas menjadi langkah penting dalam mendukung adaptasi remaja terhadap perubahan tersebut.

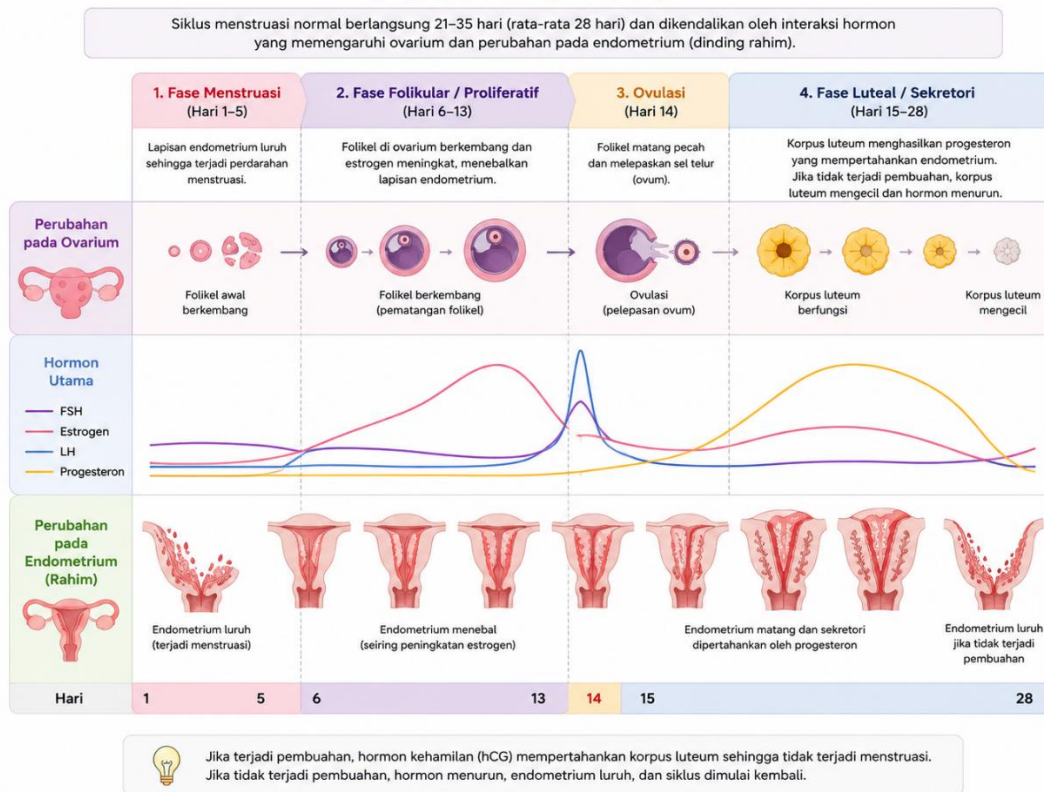
2. Menstruasi (*Menarche*)

Menarche merupakan menstruasi pertama yang menandai mulai berfungsinya sistem reproduksi secara biologis pada remaja perempuan. Menarche merupakan salah satu tahapan penting dalam perkembangan pubertas yang menunjukkan terjadinya kematangan sistem reproduksi. Usia terjadinya menarche dapat bervariasi pada setiap individu, namun umumnya terjadi pada masa remaja awal hingga pertengahan. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, status gizi, pola makan, lingkungan, dan kondisi kesehatan individu (Du et al., 2024; Mozafarian et al., 2025).

Menstruasi terjadi akibat peluruhan lapisan endometrium ketika tidak terjadi pembuahan sebagai bagian dari proses fisiologis normal sistem reproduksi perempuan. Pada masa awal setelah menarche, siklus menstruasi sering kali belum teratur karena sistem hormonal reproduksi masih dalam tahap pematangan, sehingga proses ovulasi belum berlangsung secara konsisten. Ketidakteraturan ini merupakan kondisi fisiologis yang umum terjadi pada remaja dan akan menjadi lebih stabil seiring bertambahnya kematangan hormonal.

Faktor lingkungan juga diketahui dapat berkontribusi terhadap variasi waktu maturasi reproduksi, termasuk waktu terjadinya menarche (Li et al., 2024).

Siklus Menstruasi



Gambar 2. 2 Siklus Menstruasi

Pemahaman yang baik mengenai menstruasi penting dimiliki oleh remaja agar mampu mengenali perubahan normal pada tubuhnya, mengurangi kecemasan, serta membentuk perilaku perawatan diri yang tepat. Selain itu, penerapan kebersihan menstruasi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan kenyamanan selama menstruasi, dan membantu mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada area reproduksi (Majeed et al., 2022).

3. Perubahan Hormonal

Perubahan biologis pada remaja putri sangat dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang terjadi selama masa pubertas. Masa pubertas dimulai dengan aktivasi sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (*hypothalamic-pituitary-gonadal axis/HPG axis*), yaitu sistem hormonal yang mengatur proses pematangan reproduksi. Aktivasi sistem ini menyebabkan pelepasan hormon *gonadotropin-releasing hormone* (GnRH) dari hipotalamus, yang kemudian merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan *Follicle-Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH). Kedua hormon ini berperan penting dalam memulai dan mengatur perkembangan sistem reproduksi perempuan selama masa remaja

(Street et al., 2023). Hormon estrogen memiliki peran utama dalam perkembangan organ reproduksi perempuan, pertumbuhan payudara, pembentukan distribusi lemak tubuh khas perempuan, serta pengaturan siklus menstruasi. Sementara itu, hormon progesteron berfungsi dalam mempersiapkan lapisan rahim untuk kemungkinan implantasi apabila terjadi pembuahan serta membantu menjaga keseimbangan siklus menstruasi. Kedua hormon tersebut bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung fungsi reproduksi yang normal (Grant & Kriegsfeld, 2023).

Selain itu, FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium, sedangkan LH berfungsi memicu ovulasi serta mendukung produksi hormon reproduksi. Interaksi antar hormon tersebut berlangsung secara kompleks dan saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan sistem reproduksi perempuan. Selama masa pubertas, perubahan kadar hormon ini merupakan bagian dari proses perkembangan biologis yang normal (Grant & Kriegsfeld, 2023; Street et al., 2023). Perubahan hormonal pada masa remaja tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional dan perilaku remaja. Fluktuasi hormon dapat berhubungan dengan perubahan suasana hati (*mood swings*), meningkatnya sensitivitas emosional, dan perubahan respons terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat diperlukan agar remaja mampu memahami perubahan yang terjadi serta mengelolanya secara sehat dan adaptif (Hantsoo et al., 2023).

4. Status Gizi dan Kesehatan Reproduksi

Status gizi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan biologis remaja putri. Masa remaja merupakan periode pertumbuhan yang pesat sehingga kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral meningkat untuk menunjang perkembangan fisik, keseimbangan hormonal, serta fungsi reproduksi yang optimal. Pemenuhan gizi yang adekuat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, mendukung aktivitas sehari-hari, dan menunjang perkembangan reproduksi yang normal (Rimbawan et al., 2023).

Kekurangan gizi, khususnya kekurangan zat besi, merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada remaja putri. Kondisi ini dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan, kelemahan, penurunan konsentrasi, serta menurunnya kemampuan belajar dan produktivitas sehari-hari. Selain itu, status gizi yang kurang juga dapat mengganggu keseimbangan hormonal, memperlambat pertumbuhan, serta memengaruhi proses pubertas dan kesehatan reproduksi (Adokorach et al., 2024; Du et al., 2024).

Sebaliknya, kelebihan asupan energi yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup dapat menyebabkan peningkatan berat badan berlebih. Kondisi ini dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi, meningkatkan risiko pubertas dini, serta berkontribusi terhadap gangguan metabolik di masa mendatang (Fang et al., 2022).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga status gizi dan kesehatan reproduksi antara lain:

- a. Mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati, kacang-kacangan, dan sayuran hijau
- b. Mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan
- c. Menjaga kebersihan diri, terutama selama menstruasi, untuk mendukung kesehatan reproduksi dan mencegah infeksi (Majeed et al., 2022).
- d. Menerapkan pola makan seimbang dan melakukan aktivitas fisik secara teratur

Dengan pemenuhan gizi yang baik serta penerapan perilaku hidup sehat, remaja putri dapat menjalani masa pubertas dengan lebih sehat, optimal, dan siap menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya.

D. Perubahan Psikologis pada Remaja

Perubahan psikologis pada remaja merupakan bagian penting dari proses perkembangan yang terjadi seiring dengan perubahan biologis dan pengaruh lingkungan sosial. Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan yang ditandai dengan perubahan dalam kemampuan berpikir, pengelolaan emosi, pembentukan identitas diri, serta perubahan cara individu memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Perubahan psikologis ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi dalam proses perkembangan remaja. Perubahan biologis, khususnya fluktuasi hormon selama masa pubertas, dapat memengaruhi kondisi emosional remaja sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap berbagai situasi dan pengalaman sehari-hari. Aktivitas hormon pubertas diketahui berhubungan dengan kesejahteraan psikologis, respons emosional, dan kemampuan adaptasi remaja terhadap perubahan perkembangan yang terjadi pada dirinya (Chafkin et al., 2022).

Di sisi lain, interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial turut membentuk respons psikologis remaja. Hubungan sosial yang suportif berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional remaja, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko stres emosional dan masalah psikologis. Kualitas hubungan dengan teman sebaya juga diketahui berkontribusi terhadap kesejahteraan subjektif remaja serta

membantu proses adaptasi sosial selama masa perkembangan (Alsarrani et al., 2022; Dall et al., 2022). Oleh karena itu, perubahan psikologis pada masa remaja merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor biologis dan sosial. Pemahaman dan dukungan yang baik dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar sangat diperlukan agar remaja mampu menghadapi perubahan tersebut secara sehat, membangun ketahanan psikologis, dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan.

Salah satu perubahan psikologis yang menonjol pada masa remaja adalah perkembangan kemampuan kognitif. Pada fase ini, remaja mulai mampu berpikir lebih abstrak, logis, dan kritis dibandingkan masa kanak-kanak (Liang et al., 2024). Kemampuan ini memungkinkan remaja untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan konsekuensi, serta mulai membentuk pandangan dan nilai-nilai pribadi. Namun, kemampuan berpikir yang berkembang tersebut belum selalu diikuti dengan kematangan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, remaja terkadang menunjukkan perilaku impulsif atau mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat (Chafkin et al., 2022).

Perubahan emosional juga menjadi karakteristik yang umum pada masa remaja. Fluktuasi hormon yang terjadi selama pubertas dapat memengaruhi suasana hati sehingga remaja lebih mudah mengalami perubahan emosi, seperti merasa senang, sedih, marah, cemas, atau frustrasi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini sering dikenal sebagai *mood swing* dan merupakan bagian dari proses adaptasi perkembangan (Chafkin et al., 2022). Selain faktor biologis, tekanan akademik, hubungan pertemanan, ekspektasi keluarga, serta perubahan citra tubuh juga dapat memengaruhi kestabilan emosi remaja (Alsarrani et al., 2022). Oleh karena itu, remaja memerlukan dukungan lingkungan agar mampu mengenali dan mengelola emosinya secara sehat (Dall et al., 2022).

Masa remaja juga merupakan periode penting dalam pembentukan identitas diri. Pada tahap ini, individu mulai mencari jawaban mengenai siapa dirinya, apa yang diyakini, serta bagaimana perannya dalam lingkungan sosial. Proses pencarian identitas ini dapat terlihat dari perubahan minat, cara berpakaian, pilihan kelompok pertemanan, maupun cara mengekspresikan diri (Branje, 2022). Tidak jarang remaja mengalami kebingungan identitas ketika menghadapi tuntutan sosial yang beragam. Namun, proses ini merupakan bagian normal dari perkembangan psikologis menuju kedewasaan (Bogaerts et al., 2023).

Selain identitas diri, perubahan persepsi terhadap tubuh (*body image*) juga sering terjadi, terutama pada remaja putri. Perubahan fisik yang terjadi selama pubertas dapat memunculkan perasaan tidak nyaman, kurang percaya diri, atau kecemasan apabila remaja membandingkan dirinya dengan standar tertentu yang

berkembang di lingkungan sosial maupun media digital (Gupta et al., 2023). Persepsi negatif terhadap tubuh dapat memengaruhi harga diri dan kesehatan mental remaja (Mougharbel et al., 2023). Sebaliknya, penerimaan diri yang baik dapat membantu remaja menjalani masa perkembangan dengan lebih positif. Oleh karena itu, pendampingan yang mendukung penerimaan tubuh secara sehat sangat diperlukan.

Hubungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis remaja. Pada masa ini, remaja cenderung mulai mengurangi ketergantungan emosional pada orang tua dan lebih dekat dengan teman sebaya. Kelompok teman sebaya menjadi sumber dukungan emosional, tempat berbagi pengalaman, sekaligus referensi dalam membentuk perilaku dan identitas (Alsarrani et al., 2022). Namun, pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi faktor risiko apabila mendorong perilaku negatif (Dall et al., 2022). Oleh karena itu, kemampuan memilih lingkungan pertemanan yang sehat menjadi bagian penting dari perkembangan psikologis remaja.

Perubahan psikologis pada masa remaja merupakan bagian normal dari proses perkembangan menuju kedewasaan (Bogaerts et al., 2023). Perubahan ini dapat menjadi tantangan apabila remaja tidak memiliki pemahaman, dukungan, dan keterampilan dalam mengelola dirinya. Sebaliknya, apabila didampingi dengan baik, perubahan psikologis dapat menjadi kesempatan bagi remaja untuk tumbuh menjadi individu yang matang, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab (Alsarrani et al., 2022; Dall et al., 2022). Secara umum, perubahan psikologis pada remaja dapat meliputi beberapa aspek berikut:

1. Perkembangan Kognitif

Masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan kognitif, yaitu perkembangan kemampuan berpikir, memahami, menalar, serta mengambil keputusan (Lee et al., 2023). Pada fase ini, remaja mengalami perubahan cara berpikir dari pola yang cenderung konkret menuju pemikiran yang lebih abstrak, logis, dan analitis. Perkembangan ini memungkinkan remaja untuk memahami konsep yang lebih kompleks, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta membentuk pandangan pribadi terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Dalam konteks kesehatan, kemampuan tersebut membantu remaja memahami informasi, mengenali risiko, serta mulai membuat keputusan terkait perilaku kesehatan (Orben et al., 2020). Oleh karena itu, perkembangan kognitif menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan kemandirian berpikir pada masa remaja.

Salah satu aspek utama dalam perkembangan kognitif remaja adalah berkembangnya fungsi eksekutif, yaitu kemampuan mental tingkat tinggi yang

mencakup perencanaan, pengendalian diri, memori kerja, fleksibilitas berpikir, serta pengambilan keputusan (Lee et al., 2023). Fungsi ini berkembang pesat sejak akhir masa kanak-kanak hingga pertengahan remaja, kemudian terus mengalami pematangan hingga awal masa dewasa. Perkembangan tersebut membuat remaja semakin mampu menyelesaikan masalah, mempertimbangkan konsekuensi, dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang berubah. Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya matang pada masa remaja. Akibatnya, remaja mungkin telah memahami risiko suatu perilaku, tetapi belum selalu mampu mengendalikan diri untuk menghindarinya. Kondisi ini menjelaskan mengapa pengambilan keputusan pada masa remaja masih sering dipengaruhi oleh emosi, impulsivitas, maupun tekanan dari lingkungan sosial (Chafkin et al., 2022).

Perkembangan kognitif juga berkaitan erat dengan pematangan area otak, khususnya korteks prefrontal yang berperan dalam pengendalian diri, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan (Peters & Naneix, 2022). Karena bagian otak ini masih berkembang hingga awal masa dewasa, kemampuan berpikir rasional pada remaja belum sepenuhnya seimbang dengan respons emosional. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan untuk bertindak spontan, terutama dalam situasi yang melibatkan tekanan teman sebaya atau dorongan emosional (Lorenz & Kray, 2022). Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bagian normal dari proses perkembangan neurologis.

Selain dipengaruhi oleh faktor biologis, perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pengalaman belajar, pola pengasuhan, dukungan keluarga, interaksi sosial, serta lingkungan pendidikan yang positif dapat membantu mengoptimalkan kemampuan berpikir remaja (Lee et al., 2023; Opdenakker, 2022). Sebaliknya, stres berkepanjangan atau pengalaman hidup yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan kemampuan regulasi diri (Lee et al., 2023). Oleh karena itu, lingkungan yang suportif sangat penting dalam membantu remaja mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang sehat, termasuk dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

2. Perubahan Emosi

Masa remaja sering ditandai dengan perubahan emosi yang lebih intens dibandingkan fase perkembangan lainnya. Pada periode ini, remaja kerap mengalami ketidakstabilan emosi atau *mood swing*, yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang cepat, seperti mudah marah, lebih sensitif, mudah tersinggung, merasa sedih tanpa alasan yang jelas, atau sebaliknya merasa sangat bersemangat dalam waktu singkat. Kondisi ini merupakan bagian dari proses

perkembangan yang normal karena masa remaja merupakan periode transisi yang melibatkan perubahan biologis, psikologis, dan sosial secara bersamaan (Bogaerts et al., 2023). Fluktuasi hormon selama pubertas, khususnya hormon reproduksi, turut memengaruhi respons emosional individu pada fase ini (Chafkin et al., 2022). Oleh karena itu, perubahan emosi pada masa remaja perlu dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi perkembangan.

Selain faktor biologis, kondisi emosional remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tuntutan akademik, hubungan dengan teman sebaya, konflik dalam keluarga, perubahan citra tubuh, hingga tekanan dari media sosial dapat menjadi sumber stres emosional (Bozzola et al., 2022; Mougharbel et al., 2023). Pada fase ini, kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan diakui oleh lingkungan sosial menjadi semakin kuat. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, respons emosional yang muncul dapat menjadi lebih intens (Alsarrani et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan emosi pada remaja tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan internal, tetapi juga oleh dinamika sosial yang mereka hadapi sehari-hari (Dall et al., 2022).

Kemampuan regulasi emosi pada masa remaja juga masih dalam tahap perkembangan. Meskipun kemampuan berpikir mulai berkembang ke arah yang lebih abstrak dan logis, kemampuan mengelola emosi belum sepenuhnya matang (Chafkin et al., 2022; Liang et al., 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan remaja menunjukkan perilaku impulsif, kesulitan mengendalikan kemarahan, atau mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat penting untuk membantu remaja mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosinya secara sehat (Alsarrani et al., 2022; Dall et al., 2022). Pengelolaan emosi yang baik pada masa remaja akan menjadi fondasi penting bagi kesehatan mental dan hubungan interpersonal di masa dewasa (Bogaerts et al., 2023).

3. Pencarian Identitas Diri

Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas diri. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase ketika individu berupaya memahami siapa dirinya, apa yang diyakini, serta bagaimana perannya dalam kehidupan sosial (Erikson, 1968). Pada tahap ini, remaja mulai mengembangkan kesadaran diri yang lebih kuat dan berusaha membentuk identitas diri yang lebih jelas dan stabil. Tahap ini merupakan bagian normal dari perkembangan menuju kedewasaan serta menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepribadian. Literatur terkini juga menegaskan bahwa pembentukan identitas pada masa remaja merupakan dinamika perkembangan yang melibatkan eksplorasi diri,

pengambilan keputusan, serta penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sosial (Bogaerts et al., 2023; Branje, 2022).

Pencarian identitas diri dapat terlihat dari perubahan dalam cara berpikir, bersikap, maupun berinteraksi dengan lingkungan. Pada fase ini, remaja mulai mengeksplorasi nilai, keyakinan, minat, serta tujuan hidup yang dianggap sesuai dengan dirinya (Branje, 2022). Selain itu, mereka juga mulai mencari peran sosial yang ingin dijalani, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, maupun masyarakat yang lebih luas. Tahapan ini membantu remaja membangun konsep diri, yaitu bagaimana individu memandang, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Pembentukan konsep diri yang positif menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan psikologis yang sehat (Bogaerts et al., 2023).

Namun, pencarian identitas tidak selalu berlangsung secara mudah. Remaja dapat mengalami kebingungan ketika menghadapi berbagai tuntutan, nilai, atau harapan yang berbeda dari keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan sosial (Bogaerts et al., 2023). Pada era digital, paparan media sosial juga dapat memengaruhi proses ini melalui kecenderungan melakukan perbandingan sosial (*social comparison*) atau dorongan untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu (Bozzola et al., 2022). Jika tidak diimbangi dengan dukungan dan pemahaman yang baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan peran (*role confusion*), rendahnya rasa percaya diri, atau kesulitan dalam mengambil keputusan (Branje, 2022). Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat diperlukan agar remaja dapat membangun identitas diri yang sehat, realistis, dan positif (Dall et al., 2022).

4. Citra Tubuh (*Body Image*) dan Kepercayaan Diri

Perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja tidak hanya memengaruhi kondisi biologis, tetapi juga cara individu memandang dan menilai tubuhnya sendiri. Persepsi terhadap bentuk, ukuran, dan penampilan tubuh dikenal sebagai citra tubuh (*body image*) (Rodgers et al., 2023). Pada masa remaja, terutama pada remaja putri, perubahan akibat pubertas seperti peningkatan berat badan, perkembangan payudara, perubahan proporsi tubuh, maupun munculnya jerawat dapat memunculkan berbagai respons psikologis (Mougharbel et al., 2023). Sebagian individu mampu menerima perubahan tersebut sebagai bagian normal dari perkembangan, sedangkan sebagian lainnya mengalami ketidaknyamanan atau ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan fisik pada masa remaja berkaitan erat dengan pembentukan persepsi diri (Gupta et al., 2023).

Citra tubuh yang negatif dapat memengaruhi kepercayaan diri remaja. Individu yang merasa tubuhnya tidak sesuai dengan harapan atau standar tertentu cenderung mengalami rasa malu, kurang percaya diri, atau enggan terlibat dalam aktivitas sosial (Rodgers et al., 2023). Pada remaja putri, tekanan terhadap penampilan sering kali lebih kuat karena adanya standar kecantikan yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital. Paparan media sosial dapat memperkuat kecenderungan melakukan perbandingan sosial (*social comparison*), sehingga mereka lebih mudah merasa dirinya kurang menarik dibandingkan orang lain (Modrzejewska et al., 2022). Kondisi ini dapat menurunkan harga diri dan memengaruhi kesejahteraan psikologis secara keseluruhan (Rodgers et al., 2023).

Selain berdampak pada aspek emosional, citra tubuh yang negatif juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan. Beberapa remaja mungkin melakukan pembatasan makan yang berlebihan, pola makan restriktif, atau perilaku lain yang berisiko demi mencapai bentuk tubuh yang dianggap ideal (Jung & Jun, 2022). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan makan, masalah kesehatan mental, serta gangguan pertumbuhan apabila terjadi pada masa perkembangan (Rodgers et al., 2023). Sebaliknya, citra tubuh yang positif dapat membantu remaja menerima perubahan tubuhnya secara lebih sehat dan realistis. Oleh karena itu, pembentukan persepsi tubuh yang positif menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan psikologis remaja.

Dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk citra tubuh yang sehat (Alsarrani et al., 2022; Rodgers et al., 2023). Lingkungan yang memberikan penerimaan, edukasi yang benar mengenai perubahan tubuh, serta komunikasi yang suportif dapat membantu remaja mengembangkan rasa percaya diri yang lebih baik. Selain itu, penting bagi remaja untuk memahami bahwa setiap individu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Dengan penerimaan diri yang positif, remaja akan lebih mampu menghargai tubuhnya, menjaga kesehatannya, serta membangun kepercayaan diri yang sehat (Rodgers et al., 2023). Kepercayaan diri yang baik akan membantu remaja menjalani masa perkembangan dengan lebih positif dan mendukung kesejahteraan psikologis jangka panjang.

5. Kemandirian Psikologis

Kemandirian psikologis merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan remaja yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan individu untuk berpikir, mengambil keputusan, serta mengatur dirinya secara lebih mandiri (Erikson, 1968; Opdenakker, 2022). Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan otonomi pribadi, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan

dan bertindak berdasarkan nilai, keyakinan, serta pertimbangan pribadi, bukan semata-mata karena tekanan dari lingkungan sekitar (Eriksson et al., 2022). Perkembangan ini tidak berarti memutus hubungan dengan keluarga atau menjadi sepenuhnya bebas tanpa arahan, melainkan menunjukkan bertumbuhnya kemampuan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu mengelola dirinya secara sehat. Proses tersebut merupakan bagian normal dari perkembangan menuju kedewasaan. Oleh karena itu, kemandirian psikologis menjadi salah satu indikator penting dalam kematangan emosional dan sosial remaja.

Perkembangan otonomi ini dapat terlihat dari meningkatnya kemampuan remaja dalam mengelola emosi, menyampaikan pendapat, menunjukkan inisiatif, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari (Eriksson et al., 2022). Remaja mulai belajar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, menyelesaikan masalah secara lebih mandiri, serta menentukan pilihan yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Pada tahap ini, mereka juga mulai mengembangkan rasa percaya terhadap kemampuan dirinya (*self-efficacy*) dan belajar bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat (Steigen et al., 2022). Kemandirian ini berkaitan erat dengan pembentukan identitas diri, karena semakin jelas pemahaman remaja terhadap dirinya, semakin besar kemampuannya untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian, perkembangan ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan bertindak, tetapi juga dengan kematangan dalam berpikir dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, proses menuju kemandirian tidak selalu berlangsung tanpa tantangan. Keinginan remaja untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar sering kali menimbulkan perbedaan pendapat dengan orang tua atau pengasuh, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai aturan, pilihan hidup, maupun pergaulan. Perbedaan tersebut merupakan dinamika perkembangan yang wajar, selama berlangsung dalam batas yang sehat dan disertai komunikasi yang terbuka. Dalam konteks ini, pola pengasuhan yang mendukung otonomi, seperti memberikan kesempatan bagi remaja untuk menyampaikan pendapat, belajar mengambil keputusan, serta memperoleh bimbingan tanpa kontrol yang berlebihan, dapat membantu perkembangan yang lebih optimal (Bülow et al., 2022). Sebaliknya, pola pengasuhan yang terlalu mengekang maupun terlalu permisif dapat menghambat pembentukan kemandirian (Eriksson et al., 2022).

Selain keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebaya juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan otonomi psikologis remaja (Lorenz & Kray, 2022; Opdenakker, 2022). Dukungan dari guru, hubungan sosial yang positif,

serta lingkungan yang memberikan kesempatan untuk belajar mengambil tanggung jawab dapat membantu remaja mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan mengatur dirinya (Opdenakker, 2022). Sebaliknya, tekanan sosial yang kuat atau hubungan pertemanan yang tidak sehat dapat memengaruhi kemampuan remaja dalam mempertahankan nilai yang diyakininya (Lorenz & Kray, 2022). Oleh karena itu, kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri meskipun menghadapi tekanan sosial menjadi bagian penting dari ketahanan psikologis remaja.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, kemandirian psikologis memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab (Eriksson et al., 2022). Remaja yang memiliki kemandirian yang baik cenderung lebih mampu menolak tekanan teman sebaya, mempertahankan prinsip yang diyakininya, serta membuat pilihan yang lebih aman bagi kesehatan dirinya (Lorenz & Kray, 2022). Kemampuan ini menjadi faktor protektif terhadap berbagai perilaku berisiko yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penguatan kemandirian melalui dukungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting dalam pendampingan remaja (Eriksson et al., 2022). Kemandirian yang berkembang secara sehat akan membantu remaja menjalani masa transisi menuju dewasa dengan lebih matang, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

6. Kerentanan terhadap Masalah Psikologis

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang penuh dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara bersamaan (Fine et al., 2022; Rueth & Lohaus, 2022). Meskipun perubahan tersebut merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang, masa remaja juga dikenal sebagai periode yang rentan terhadap berbagai masalah psikologis. Kerentanan ini muncul karena remaja sedang berada dalam proses adaptasi terhadap perubahan tubuh, perkembangan emosi, pencarian identitas diri, serta tuntutan sosial yang semakin kompleks (Fine et al., 2022). Pada fase ini, kemampuan regulasi emosi dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya matang, sehingga remaja lebih rentan mengalami tekanan psikologis ketika menghadapi berbagai tantangan perkembangan (Rueth & Lohaus, 2022). Oleh karena itu, kesehatan mental remaja perlu menjadi perhatian penting dalam proses pendampingan dan pembinaan kesehatan.

Berbagai masalah psikologis yang umum dialami remaja meliputi stres, kecemasan, gangguan suasana hati, hingga gejala depresi. Stres dapat muncul sebagai respons terhadap tekanan akademik, perubahan hubungan sosial, konflik

keluarga, maupun tuntutan untuk memenuhi harapan tertentu dari lingkungan (Fine et al., 2022). Sementara itu, kecemasan pada remaja dapat berkaitan dengan kekhawatiran terhadap prestasi, penampilan fisik, penerimaan sosial, atau ketidakpastian mengenai masa depan. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa dukungan dan penanganan yang tepat, dampaknya dapat memengaruhi konsentrasi belajar, kualitas tidur, pola makan, hubungan interpersonal, serta kesejahteraan psikologis secara keseluruhan (Santos et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja tidak dapat dipisahkan dari kesehatan umum dan kualitas hidup mereka.

Kerentanan terhadap masalah psikologis dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Faktor internal, meliputi rendahnya kepercayaan diri, kesulitan mengelola emosi, kemampuan *coping* yang belum matang, serta kebingungan dalam pembentukan identitas diri. Kondisi ini dapat membuat remaja lebih sulit menghadapi tekanan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupannya (Rueth & Lohaus, 2022).
- b. Faktor eksternal, meliputi tekanan akademik, konflik keluarga, pola pengasuhan yang kurang suportif, pengalaman perundungan (*bullying*), tekanan dari teman sebaya, kondisi sosial ekonomi, hingga paparan media sosial yang tidak sehat (Fine et al., 2022). Pada era digital, media sosial dapat memperkuat kecenderungan melakukan perbandingan sosial (*social comparison*), sehingga meningkatkan tekanan psikologis, terutama pada remaja yang belum memiliki penerimaan diri yang baik (Modrzejewska et al., 2022).

Kerentanan terhadap masalah psikologis juga dapat dikenali melalui beberapa perubahan perilaku maupun emosional. Tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan antara lain perubahan suasana hati yang berlangsung secara berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial, kesulitan berkonsentrasi, perubahan pola tidur atau nafsu makan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, serta munculnya keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas (Fine et al., 2022; Rueth & Lohaus, 2022). Pengenalan terhadap tanda-tanda tersebut penting agar dukungan dapat diberikan sedini mungkin sebelum kondisi berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Pada remaja putri, kerentanan psikologis dapat menjadi lebih kompleks karena adanya faktor tambahan yang berkaitan dengan perubahan hormonal, sensitivitas terhadap perubahan fisik, serta tekanan terhadap standar penampilan (Lee et al., 2023; Rodgers et al., 2023). Perubahan tubuh selama pubertas, perubahan suasana hati yang berkaitan dengan fluktuasi hormon, serta

ketidakpuasan terhadap citra tubuh dapat meningkatkan risiko kecemasan maupun penurunan kepercayaan diri (Rodgers et al., 2023). Selain itu, remaja putri cenderung lebih sensitif terhadap kualitas hubungan interpersonal, sehingga konflik sosial atau pengalaman penolakan dapat memberikan dampak emosional yang lebih kuat (Fine et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan psikologis pada remaja putri perlu mempertimbangkan aspek biologis maupun sosial yang khas pada kelompok ini.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak masalah kesehatan mental mulai muncul pada masa remaja, sehingga periode ini menjadi tahap yang sangat penting untuk upaya pencegahan, deteksi dini, dan intervensi yang tepat (Fine et al., 2022; Rueth & Lohaus, 2022; Schrijvers et al., 2024). Dalam konteks kesehatan reproduksi, kondisi psikologis yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat, mengelola hubungan interpersonal, serta merespons tekanan sosial yang berpotensi mendorong perilaku berisiko (Lee et al., 2023). Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan lingkungan sosial sangat diperlukan untuk membantu remaja mengembangkan ketahanan psikologis yang sehat (Alsarrani et al., 2022). Komunikasi keluarga yang terbuka, lingkungan yang suportif, edukasi kesehatan mental, serta akses terhadap bantuan profesional apabila diperlukan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan psikologis remaja. Dengan pendampingan yang tepat serta deteksi dini terhadap perubahan kondisi emosional dan perilaku, remaja diharapkan mampu menghadapi tantangan perkembangan secara lebih adaptif dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik maupun mental.

E. Perubahan Sosial pada Remaja

Perubahan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan remaja yang berkaitan dengan perubahan pola interaksi, hubungan interpersonal, serta peran sosial individu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Fine et al., 2022). Pada masa ini, remaja mulai menunjukkan kebutuhan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarga serta memperoleh penerimaan sosial dari kelompok sebayanya (Alsarrani et al., 2022). Perluasan interaksi sosial tersebut merupakan bagian normal dari proses perkembangan menuju kedewasaan, ketika remaja mulai membangun kemandirian sosial dan memperluas peran sosialnya. Melalui hubungan sosial, remaja belajar memahami norma, membangun keterampilan komunikasi, serta mengembangkan kemampuan

beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih kompleks (Alsarrani et al., 2022; Fine et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan tersebut, hubungan remaja dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat juga mengalami perubahan (Fine et al., 2022). Pengaruh teman sebaya menjadi semakin kuat, sementara kebutuhan akan kemandirian dapat memengaruhi dinamika hubungan dengan keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut mengubah cara remaja berinteraksi dan membangun hubungan sosial (Santos et al., 2024). Dalam konteks kesehatan reproduksi, perubahan sosial ini memiliki peran penting karena dapat memengaruhi pembentukan nilai, perilaku, serta pengambilan keputusan remaja (Lee et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan sosial menjadi bagian penting dalam upaya pendampingan kesehatan reproduksi pada remaja.

1. Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan salah satu faktor sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan remaja. Pada masa ini, remaja mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman dibandingkan pada masa kanak-kanak, sehingga kelompok teman sebaya menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan identitas sosial, nilai, serta perilaku sehari-hari (Orben et al., 2020). Kehadiran teman sebaya dapat memberikan dukungan emosional, rasa memiliki, serta kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan individu yang berada pada tahap perkembangan yang serupa (Alsarrani et al., 2022). Hubungan tersebut membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, kerja sama, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, interaksi dengan teman sebaya menjadi salah satu unsur utama dalam perkembangan sosial remaja.

Pada masa remaja, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial cenderung meningkat. Penerimaan dari teman sebaya sering kali menjadi hal yang penting bagi pembentukan rasa percaya diri dan identitas sosial remaja (Alsarrani et al., 2022). Dalam proses ini, remaja dapat menyesuaikan perilaku, cara berpikir, maupun penampilan agar sesuai dengan norma kelompok tempat mereka berada. Penyesuaian sosial ini merupakan bagian dari perkembangan yang wajar, selama tetap berada dalam batas yang sehat dan tidak menghilangkan kemampuan berpikir kritis. Namun, kebutuhan yang berlebihan untuk memperoleh penerimaan sosial dapat membuat remaja lebih rentan terhadap tekanan kelompok (*peer pressure*) (Lorenz & Kray, 2022).

Pengaruh teman sebaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dapat terlihat ketika remaja berada dalam lingkungan pertemanan yang mendukung kebiasaan belajar yang baik, aktivitas positif,

komunikasi terbuka, serta perilaku sosial yang bertanggung jawab (Fine et al., 2022). Sebaliknya, pengaruh negatif dapat muncul apabila kelompok pertemanan mendorong perilaku sosial yang berisiko, pengambilan keputusan yang impulsif, perilaku agresif, maupun penyalahgunaan zat (Fine et al., 2022; Lorenz & Kray, 2022). Remaja yang belum memiliki kepercayaan diri atau kemandirian psikologis yang baik cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok (Eriksson et al., 2022). Oleh karena itu, kemampuan untuk mempertahankan nilai pribadi dan membuat keputusan secara mandiri menjadi sangat penting.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, pengaruh teman sebaya memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja. Informasi mengenai perubahan tubuh, menstruasi, hubungan interpersonal, maupun kesehatan reproduksi sering kali diperoleh dari teman sebaya, meskipun informasi tersebut belum tentu akurat. Selain itu, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dapat memengaruhi cara remaja mengambil keputusan terkait hubungan sosial dan perilaku kesehatan (Dodd et al., 2022). Oleh karena itu, pendampingan dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan tetap diperlukan agar remaja mampu membedakan pengaruh positif dan negatif dari lingkungan pertemanannya. Dengan pendampingan yang tepat, kelompok teman sebaya dapat menjadi sumber dukungan sosial yang konstruktif dalam mendukung perkembangan remaja yang sehat (Alsarrani et al., 2022).

2. Hubungan dengan Keluarga

Hubungan dengan keluarga tetap menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan sosial remaja, meskipun pada masa ini remaja mulai menunjukkan kebutuhan yang lebih besar untuk memperoleh kemandirian. Jika pada masa kanak-kanak keluarga menjadi pusat utama interaksi sosial, maka pada masa remaja terjadi perubahan dinamika hubungan yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang pribadi, kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta keinginan untuk membuat keputusan secara lebih mandiri. Kondisi ini merupakan bagian normal dari proses perkembangan menuju kedewasaan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua yang hangat disertai pemberian otonomi secara sehat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan psikologis remaja dan perkembangan sosial yang adaptif (Bülow et al., 2022; Vrolijk et al., 2023). Namun, dinamika tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan pandangan atau konflik dengan orang tua maupun anggota keluarga lainnya (Nguyen & Nguyen, 2023; Öztürk et al., 2023). Oleh karena itu, hubungan keluarga pada masa remaja memerlukan penyesuaian yang sehat dari kedua belah pihak (Tafà et al., 2023).

Keinginan remaja untuk memperoleh kemandirian sering kali diartikan sebagai bentuk pembangkangan atau penolakan terhadap aturan keluarga, padahal kondisi tersebut umumnya merupakan bagian dari perkembangan sosial dan psikologis yang normal. Pada fase ini, remaja mulai mengembangkan identitas diri, nilai pribadi, serta kemampuan untuk berpikir lebih mandiri. Literatur perkembangan remaja menunjukkan bahwa pencarian otonomi merupakan tugas perkembangan normatif yang berperan penting dalam pembentukan identitas dan kematangan psikososial remaja (Bülow et al., 2022). Perbedaan pendapat mengenai aturan, pergaulan, pilihan aktivitas, maupun penggunaan teknologi dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Namun, konflik dalam batas yang wajar tidak selalu menunjukkan hubungan yang buruk, melainkan dapat menjadi bagian dari proses negosiasi hubungan orang tua–remaja menuju pola interaksi yang lebih dewasa dan seimbang (Nguyen & Nguyen, 2023; Tafà et al., 2023). Yang terpenting adalah bagaimana keluarga merespons dinamika tersebut secara adaptif melalui komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan penghargaan terhadap kebutuhan remaja untuk berkembang secara mandiri (Vroljik et al., 2023).

Komunikasi yang terbuka, suportif, dan penuh penghargaan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hubungan keluarga dengan remaja. Lingkungan keluarga yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk menyampaikan pendapat, didengarkan, serta memperoleh bimbingan tanpa kontrol yang berlebihan dapat membantu perkembangan sosial yang lebih sehat. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang hangat, responsif, dan mendukung otonomi remaja berhubungan dengan kesejahteraan psikososial yang lebih baik, kemampuan regulasi emosi yang lebih adaptif, serta kualitas hubungan interpersonal yang lebih sehat pada remaja (Bülow et al., 2022; Tafà et al., 2023). Sebaliknya, pola komunikasi yang kaku, penuh kritik, atau kurang memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan jarak emosional antara remaja dan keluarga serta meningkatkan risiko munculnya masalah perilaku maupun distress psikologis (Vroljik et al., 2023). Hubungan keluarga yang positif juga berperan sebagai faktor protektif terhadap berbagai perilaku berisiko karena remaja cenderung lebih terbuka dalam mencari bantuan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi bersama keluarga (Tafà et al., 2023). Dengan demikian, kualitas komunikasi keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan remaja.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber nilai, informasi, dan dukungan emosional bagi remaja.

Komunikasi yang sehat antara orang tua dan remaja dapat membantu membentuk pemahaman yang benar mengenai perubahan tubuh, menstruasi, hubungan interpersonal, serta perilaku kesehatan yang bertanggung jawab (Melese et al., 2024). Sebaliknya, keterbatasan komunikasi mengenai isu kesehatan reproduksi dapat mendorong remaja mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu akurat, sehingga berpotensi meningkatkan miskonsepsi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi (Wahyuningsih et al., 2024). Oleh karena itu, keluarga perlu membangun suasana yang aman dan terbuka agar remaja merasa nyaman untuk berdiskusi mengenai berbagai perubahan yang dialami. Dengan dukungan keluarga yang positif, remaja akan lebih mampu menghadapi tantangan perkembangan sosial secara sehat, termasuk dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi.

3. Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sosial remaja karena menjadi ruang bagi individu untuk berinteraksi, belajar, dan memperluas pengalaman sosialnya. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa keterikatan remaja dengan lingkungan sekolah (*school belonging/school connectedness*) berhubungan dengan perkembangan sosial-emosional yang lebih baik, peningkatan kualitas hubungan interpersonal, serta kesejahteraan psikologis yang lebih positif (Allen et al., 2022). Lingkungan sekolah yang suportif juga terbukti berkontribusi terhadap perilaku prososial, ketahanan psikologis, dan kemampuan remaja untuk beradaptasi secara sosial melalui dukungan interpersonal yang positif (Luo et al., 2023). Melalui interaksi dengan guru, teman, maupun kegiatan kelompok, remaja belajar memahami aturan, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Proses ini merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kematangan sosial. Oleh karena itu, lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial remaja.

Selain sebagai tempat belajar, sekolah juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan rasa percaya diri, kepemimpinan, serta keterampilan sosial melalui berbagai kegiatan organisasi maupun aktivitas ekstrakurikuler (Allen et al., 2022). Keterlibatan dalam kegiatan kelompok dapat membantu remaja belajar bekerja sama, mengambil tanggung jawab, serta mengelola perbedaan pendapat dengan orang lain. Penelitian menunjukkan

bahwa lingkungan sekolah yang positif dan suportif berhubungan dengan peningkatan perilaku prososial, dukungan sosial yang lebih baik, serta ketahanan psikologis pada remaja (Luo et al., 2023). Lingkungan sekolah yang suportif juga dapat menjadi faktor protektif terhadap berbagai masalah sosial maupun psikologis karena remaja memiliki ruang untuk memperoleh dukungan dari guru maupun teman sebaya (Allen et al., 2022). Sebaliknya, lingkungan sekolah yang kurang aman, penuh tekanan, atau adanya pengalaman perundungan (*bullying*) dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial dan emosional remaja, termasuk meningkatnya distress psikologis dan gangguan hubungan sosial (Fulantelli et al., 2022). Dengan demikian, kualitas lingkungan sekolah sangat memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan remaja.

Di luar sekolah, masyarakat juga berkontribusi dalam membentuk perkembangan sosial remaja. Lingkungan tempat tinggal, komunitas, organisasi sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi sarana bagi remaja untuk belajar mengenai nilai sosial, norma budaya, tanggung jawab, dan partisipasi dalam kehidupan bersama (Shareck et al., 2023). Keterlibatan dalam aktivitas positif di masyarakat dapat membantu membangun rasa memiliki, kepedulian sosial, serta kemampuan berinteraksi dengan kelompok yang lebih beragam melalui pengalaman partisipatif dalam kegiatan sosial yang mendukung perkembangan positif remaja (Ilari & Cho, 2023). Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang kurang aman, adanya paparan perilaku menyimpang, kekerasan, atau kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah psikososial maupun perilaku berisiko pada remaja (Miliauskas et al., 2022). Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang remaja.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, sekolah dan masyarakat memiliki posisi strategis dalam menyediakan informasi, edukasi, serta lingkungan sosial yang mendukung perilaku sehat pada remaja. Sekolah dapat menjadi tempat yang efektif untuk memberikan pendidikan kesehatan, termasuk edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja (Sell et al., 2023). Sementara itu, lingkungan masyarakat yang positif, termasuk tersedianya akses informasi dan dukungan sosial yang memadai, dapat membantu membentuk norma sosial yang mendukung perilaku sehat dan bertanggung jawab (Zenebe et al., 2023). Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap informasi yang benar atau rendahnya literasi kesehatan reproduksi dapat memengaruhi pembentukan perilaku yang tidak sehat pada remaja (Lirios et al., 2024). Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, tenaga

kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan sosial remaja yang sehat serta pembentukan perilaku yang bertanggung jawab.

4. Media Sosial dan Interaksi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial remaja. Jika pada masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak terjadi secara langsung, saat ini remaja juga aktif membangun hubungan melalui berbagai platform digital dan media sosial. Media sosial memberikan ruang bagi remaja untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, memperluas jaringan pertemanan, serta memperoleh informasi dengan cepat (Haddock et al., 2022; Senekal et al., 2023). Dalam konteks perkembangan sosial, media digital dapat menjadi sarana yang positif untuk memperkuat koneksi sosial dan mendukung proses belajar, meskipun karakter interaksi online dan tatap muka memiliki dinamika yang berbeda (Towner et al., 2022). Oleh karena itu, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial remaja modern.

Di sisi lain, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan sosial dan psikologis remaja. Paparan terhadap standar penampilan, gaya hidup, atau pencapaian orang lain dapat mendorong kecenderungan melakukan perbandingan sosial (*social comparison*), yang berpotensi memengaruhi kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis remaja (Senekal et al., 2023). Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung, mengganggu pola tidur, serta meningkatkan risiko perundungan daring (*cyberbullying*) maupun tekanan psikologis (Ahmed et al., 2024; Senekal et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan mengelola penggunaan media digital secara sehat menjadi keterampilan penting bagi remaja.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, media sosial dan internet kerap menjadi salah satu sumber informasi bagi remaja mengenai perubahan tubuh, hubungan interpersonal, maupun kesehatan reproduksi. Namun, tidak semua informasi yang diperoleh melalui media digital bersifat benar, aman, atau sesuai dengan tahap perkembangan remaja (Wahyuningsih et al., 2024). Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar remaja mampu menilai kualitas informasi, menggunakan media secara bijak, serta menghindari risiko interaksi yang tidak aman (Lirios et al., 2024). Dengan pendampingan dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan, media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang mendukung perkembangan sosial serta pembentukan perilaku kesehatan yang bertanggung jawab (Haddock et al., 2022).

5. Kerentanan terhadap Masalah Sosial

Dalam konteks kesehatan reproduksi, media sosial dan internet kerap menjadi salah satu sumber informasi bagi remaja mengenai perubahan tubuh, hubungan interpersonal, maupun kesehatan reproduksi (Meherali et al., 2024). Namun, tidak semua informasi yang diperoleh melalui media digital bersifat benar, aman, atau sesuai dengan tahap perkembangan remaja, sehingga berpotensi menimbulkan miskonsepsi maupun pengambilan keputusan yang kurang tepat (Wahyuningsih et al., 2024). Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar remaja mampu menilai kualitas informasi, menggunakan media secara bijak, serta menghindari risiko interaksi yang tidak aman (Mancone et al., 2024). Dengan pendampingan dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan, media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang mendukung perkembangan sosial serta pembentukan perilaku kesehatan yang bertanggung jawab.

Beberapa bentuk kerentanan sosial yang dapat dialami remaja antara lain:

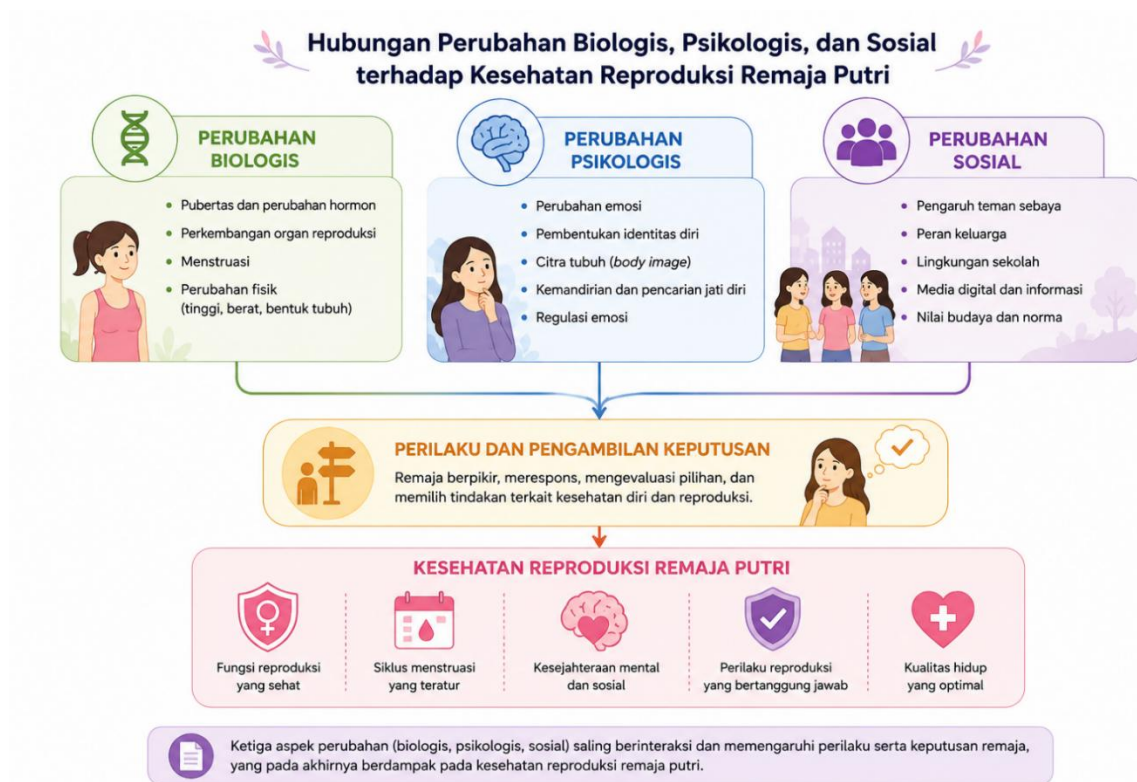
- a. Tekanan teman sebaya (*peer pressure*), yaitu dorongan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok agar memperoleh penerimaan sosial, meskipun terkadang bertentangan dengan nilai atau keputusan pribadi. Kondisi ini dapat memengaruhi cara remaja berpikir maupun bertindak dalam berbagai situasi sosial (van Duijvenvoorde et al., 2022).
- b. Perundungan (*bullying*) dan perundungan daring (*cyberbullying*), yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial maupun emosional remaja. Pengalaman ini dapat menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan perasaan takut, cemas, maupun mendorong remaja untuk menarik diri dari lingkungan sosial (Senekal et al., 2023).
- c. Konflik interpersonal dan isolasi sosial, yaitu kesulitan dalam membangun atau mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, rendah diri, atau kesulitan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas (Pollak et al., 2023).
- d. Pergaulan sosial yang berisiko, yaitu keterlibatan dalam lingkungan sosial yang mendorong perilaku tidak sehat, pengambilan keputusan yang impulsif, atau perilaku yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan remaja (van Duijvenvoorde et al., 2022).

Kerentanan terhadap masalah sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

- a. Faktor internal meliputi rendahnya kepercayaan diri, keterampilan komunikasi yang belum matang, kesulitan mengelola emosi, serta kemampuan pengambilan keputusan yang masih berkembang (Pollak et al., 2023; van Duijvenvoorde et al., 2022).
- b. Faktor eksternal dapat berupa pola pengasuhan yang kurang suportif, lingkungan pertemanan yang negatif, pengalaman penolakan sosial, perundungan, hingga paparan media digital yang tidak sehat. Pada remaja putri, tekanan sosial terkait penampilan, hubungan interpersonal, serta kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dapat menjadi faktor tambahan yang meningkatkan kerentanan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor tersebut penting dalam upaya pencegahan dan pendampingan (Bülow et al., 2022; Senekal et al., 2023). Pada remaja putri, tekanan sosial terkait penampilan, hubungan interpersonal, serta kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dapat menjadi faktor tambahan yang meningkatkan kerentanan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor tersebut penting dalam upaya pencegahan dan pendampingan.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, kerentanan sosial dapat memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan remaja. Tekanan dari lingkungan sosial atau kelompok pertemanan dapat memengaruhi cara remaja memandang hubungan interpersonal, batasan diri, maupun perilaku kesehatan (van Duijvenvoorde et al., 2022). Keterbatasan dukungan sosial dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat juga dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang tidak sehat, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi (Wahyuningsih et al., 2024). Oleh karena itu, keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan sosial yang aman, suportif, dan edukatif bagi remaja (Bülow et al., 2022). Dengan pendampingan sosial yang tepat, remaja diharapkan mampu membangun hubungan yang sehat, menghadapi tekanan sosial secara adaptif, serta berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun kesehatan dirinya.

Perubahan yang terjadi pada masa remaja tidak berlangsung secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan kesehatan secara keseluruhan. Perubahan biologis, psikologis, dan sosial membentuk perilaku serta proses pengambilan keputusan remaja yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan reproduksi. Hubungan konseptual antar aspek tersebut disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 3 Hubungan Perubahan Biologis, Psikologis, dan Sosial terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

F. Simpulan

Perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja merupakan proses perkembangan yang saling berkaitan dan sangat memengaruhi kesehatan reproduksi remaja putri. Perubahan biologis ditandai dengan pubertas, pematangan organ reproduksi, dan perubahan hormonal, sementara perubahan psikologis mencakup perkembangan emosi, identitas diri, citra tubuh, dan kemandirian. Di sisi lain, perubahan sosial ditandai dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, dinamika hubungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, serta media digital. Berbagai perubahan tersebut merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang, namun dapat menjadi fase yang rentan apabila remaja tidak memiliki pengetahuan, keterampilan adaptasi, dan dukungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh aspek psikologis dan sosial yang saling berinteraksi. Kompleksitas perubahan tersebut dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi apabila tidak diimbangi dengan pemahaman, keterampilan adaptasi, dan dukungan yang memadai.

Oleh karena itu, pendampingan kesehatan reproduksi pada remaja putri perlu dilakukan secara komprehensif melalui: 1) pemberian edukasi kesehatan reproduksi

yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja; 2) penguatan komunikasi yang terbuka dan suportif antara remaja dengan keluarga; 3) keterlibatan sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung; serta 4) peningkatan literasi digital agar remaja mampu menyaring informasi dan mengambil keputusan kesehatan secara bertanggung jawab.

Referensi

- Adokorach, G., Oyet, S. M., Obai, G., & Muggaga, C. (2024). Dietary quality, anaemia prevalence and their associated factors among rural school- going adolescents in Acholi sub -region of Uganda. *BMC Nutrition*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00982-3>
- Ahmed, O., Walsh, E. I., Dawel, A., Alateeq, K., Espinoza Oyarce, D. A., & Cherbuin, N. (2024). Social media use, mental health and sleep: A systematic review with meta-analyses. *Journal of Affective Disorders*, 367(August), 701–712. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.08.193>
- Allen, K.-A., Jamshidi, N., Berger, E., Reupert, A., Wurf, G., & May, F. (2022). Impact of School-Based Interventions for Building School Belonging in Adolescence: a Systematic Review. *Educational Psychology Review*, 34(1), 229–257. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09621-w>
- Alsarrani, A., Hunter, R. F., Dunne, L., & Garcia, L. (2022). Association between friendship quality and subjective wellbeing among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, 22(1), 1–37. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14776-4>
- Anderson, G. M., Hill, J. W., Kaiser, U. B., Navarro, V. M., Ong, K. K., Perry, J. R. B., Prevot, V., Tena-Sempere, M., & Elias, C. F. (2024). Metabolic control of puberty: 60 years in the footsteps of Kennedy and Mitra's seminal work. *Nature Reviews Endocrinology*, 20(2), 111–123. <https://doi.org/10.1038/s41574-023-00919-z>
- Argente, J., Dunkel, L., Kaiser, U. B., Latronico, A. C., Lomniczi, A., Soriano-Guillén, L., & Tena-Sempere, M. (2023). Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 11(3), 203–216. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00339-4](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00339-4)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Peraturan BKKBN RI NO. 14 Tahun 2023*. 780, 1–60. www.peraturan.go.id
- Bennett, C., Musa, M. K., Carrier, J., Edwards, D., Gillen, E., Sydor, A., Dunn, C., Jones-Mahoney, K., Nute, A., & Kelly, D. (2023). The barriers and facilitators to young people's engagement with bidirectional digital sexual health interventions: a mixed methods systematic review. *BMC Digital Health*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s44247-023-00030-3>
- Bogaerts, A., Claes, L., Raymaekers, K., Buelens, T., Bastiaens, T., & Luyckx, K. (2023). Trajectories of adaptive and disturbed identity dimensions in adolescence: developmental associations with self-esteem, resilience, symptoms of depression, and borderline personality disorder features. *Frontiers in Psychiatry*, 14(April).

<https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1125812>

- Bozzola, E., Spina, G., Agostiniani, R., Barni, S., Russo, R., Scarpato, E., Di Mauro, A., Di Stefano, A. V., Caruso, C., Corsello, G., & Staiano, A. (2022). The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16). <https://doi.org/10.3390/ijerph19169960>
- Branje, S. (2022). Adolescent identity development in context. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101286. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.11.006>
- Bülow, A., Neubauer, A. B., Soenens, B., Boele, S., Denissen, J. J. A., & Keijsers, L. (2022). Universal ingredients to parenting teens: parental warmth and autonomy support promote adolescent well-being in most families. *Scientific Reports*, 12(1), 16836. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21071-0>
- Calcaterra, V., Rossi, V., Massini, G., Regalbuto, C., Hruby, C., Panelli, S., Bandi, C., & Zuccotti, G. (2022). Precocious puberty and microbiota: The role of the sex hormone–gut microbiome axis. *Frontiers in Endocrinology*, 13(October), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1000919>
- Chafkin, J. E., O'Brien, J. M., Medrano, F. N., Lee, H. Y., Josephs, R. A., & Yeager, D. S. (2022). A dual-system, machine-learning approach reveals how daily pubertal hormones relate to psychological well-being in everyday life. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 58(August), 101158. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2022.101158>
- Dall, M., Fellingner, J., & Holzinger, D. (2022). The link between social communication and mental health from childhood to young adulthood: A systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 13(October). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.944815>
- Dodd, S., Widnall, E., Russell, A. E., Curtin, E. L., Simmonds, R., Limmer, M., & Kidger, J. (2022). School-based peer education interventions to improve health: a global systematic review of effectiveness. *BMC Public Health*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14688-3>
- Du, Y., Yan, W., Bigambo, F. M., Zhou, Q., Ma, C., Gu, W., & Wang, X. (2024). Association between dietary behavior and puberty in girls. *BMC Pediatrics*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12887-024-04840-w>
- Eckert-Lind, C., Busch, A. S., Petersen, J. H., Biro, F. M., Butler, G., Bräuner, E. V., & Juul, A. (2020). Worldwide Secular Trends in Age at Pubertal Onset Assessed by Breast Development Among Girls: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 174(4), e195881–e195881. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.5881>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company.

- Eriksson, M., Boman, E., & Svedberg, P. (2022). Autonomy and health-related quality of life in adolescents. *BMC Pediatrics*, 22(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03607-5>
- Faienza, M. F., Urbano, F., Mosconi, L. A., Chiarito, M., De Santis, S., & Giordano, P. (2022). Genetic, epigenetic and environmental influencing factors on the regulation of precocious and delayed puberty. *Frontiers in Endocrinology*, 13(December), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1019468>
- Fang, J., Yuan, J., Zhang, D., Liu, W., Su, P., Wan, Y., Zhang, Z., Tao, F., & Sun, Y. (2022). Casual Associations and Shape Between Prepuberty Body Mass Index and Early Onset of Puberty: A Mendelian Randomization and Dose–Response Relationship Analysis. *Frontiers in Endocrinology*, 13(March), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.853494>
- Fine, S. L., Musci, R. J., Bass, J. K., Chipeta, E., Mafuta, E. M., Pinandari, A. W., Wilopo, S. A., Zuo, X., & Blum, R. W. (2022). A Multi-Country Study of Risk and Protective Factors for Emotional and Behavioral Problems Among Early Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 71(4), 480–487. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.05.002>
- Fulantelli, G., Taibi, D., Scifo, L., Schwarze, V., & Eimler, S. C. (2022). Cyberbullying and Cyberhate as Two Interlinked Instances of Cyber-Aggression in Adolescence: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, 13(May), 1–21. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.909299>
- Grant, A. D., & Kriegsfeld, L. J. (2023). Neural substrates underlying rhythmic coupling of female reproductive and thermoregulatory circuits. *Frontiers in Physiology*, 14(September), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1254287>
- Gupta, M., Jassi, A., & Krebs, G. (2023). The association between social media use and body dysmorphic symptoms in young people. *Frontiers in Psychology*, 14(August). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1231801>
- Guthold, R., Newby, H., Keogh, S., Afifi, R. A., Austrian, K., Baird, S., Blum, R. W., Bundy, D. A. P., Deardorff, J., Engel, D., Klein, J. D., Kostecky, S. M., Mackworth-Young, C., Marquez, J., NicGabhainn, S., Requejo, J., Ross, D. A., Saewyc, E., & Mohan, A. (2023). Developing a Global Approach for Measurement of Adolescent Well-Being. *Journal of Adolescent Health*, 73(6), 972–974. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.08.029>
- Haddock, A., Ward, N., Yu, R., & O’Dea, N. (2022). Positive Effects of Digital Technology Use by Adolescents: A Scoping Review of the Literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114009>
- Hantsoo, L., Jagodnik, K. M., Novick, A. M., Baweja, R., di Scalea, T. L., Ozerdem, A., McGlade, E. C., Simeonova, D. I., Dekel, S., Kornfield, S. L., Nazareth, M., &

- Weiss, S. J. (2023). The role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in depression across the female reproductive lifecycle: current knowledge and future directions. *Frontiers in Endocrinology*, 14(December), 1–22. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1295261>
- Ilari, B., & Cho, E. (2023). Musical participation and positive youth development in middle school. *Frontiers in Psychology*, 13(January), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1056542>
- Jung, E. H., & Jun, M. K. (2022). Factors Affecting Body Image Distortion in Adolescents. *Children*, 9(12), 1–10. <https://doi.org/10.3390/children9121944>
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah*. Kementrian Kesehatan RI. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/modul_kespro_luar_sekolah.pdf
- Lee, V. V., Vijayakumar, S., Ng, W. Y., Lau, N. Y., Leong, Q. Y., Ooi, D. S. Q., Su, L. L., Lee, Y. S., Chan, S. Y., Blasiak, A., & Ho, D. (2023). Personalization and localization as key expectations of digital health intervention in women pre- to post-pregnancy. *Npj Digital Medicine*, 6(1). <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00924-6>
- Li, D., Xiong, J., & Cheng, G. (2024). Long-term exposure to ambient PM2.5 and its components on menarche timing among Chinese adolescents: evidence from a representative nationwide cohort. *BMC Public Health*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18209-2>
- Liang, X., Sun, L., Liao, X., Lei, T., Xia, M., Duan, D., Zeng, Z., Li, Q., Xu, Z., Men, W., Wang, Y., Tan, S., Gao, J. H., Qin, S., Tao, S., Dong, Q., Zhao, T., & He, Y. (2024). Structural connectome architecture shapes the maturation of cortical morphology from childhood to adolescence. *Nature Communications*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44863-6>
- Lirios, A., Mullens, A. B., Daken, K., Moran, C., Gu, Z., Assefa, Y., & Dean, J. A. (2024). Sexual and reproductive health literacy of culturally and linguistically diverse young people in Australia: a systematic review. *Culture, Health and Sexuality*, 26(6), 790–807. <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2256376>
- Lorenz, C., & Kray, J. (2022). Explore with Me: Peer Observation Decreases Risk-Taking but Increases Exploration Tendencies across Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 51(9), 1693–1707. <https://doi.org/10.1007/s10964-022-01608-2>
- Luo, Y., Ma, T., & Deng, Y. (2023). School climate and adolescents' prosocial behavior: the mediating role of perceived social support and resilience. *Frontiers in*

- Psychology*, 14(July), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095566>
- Majeed, J., Sharma, P., Ajmera, P., & Dalal, K. (2022). Menstrual hygiene practices and associated factors among Indian adolescent girls: a meta-analysis. *Reproductive Health*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01453-3>
- Mancone, S., Corrado, S., Tosti, B., Spica, G., & Diotaiuti, P. (2024). Integrating digital and interactive approaches in adolescent health literacy: a comprehensive review. *Frontiers in Public Health*, 12(October). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1387874>
- Meherali, S., Hussain, A., Rahim, K. A., Idrees, S., Bhaumik, S., Kennedy, M., & Lassi, Z. S. (2024). Digital knowledge translation tools for sexual and reproductive health information to adolescents: an evidence gap-map. *Therapeutic Advances in Reproductive Health*, 18. <https://doi.org/10.1177/26334941241307881>
- Melese, M., Esubalew, D., Siyoum, T. M., Worku, Y. B., Azanaw, J., & Mengistie, B. A. (2024). Parent–adolescent communication on sexual and reproductive health issues and associated factors among secondary public-school students in Gondar town, northwest Ethiopia: an institution based cross-sectional study. *Frontiers in Public Health*, 12(Ci). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1342027>
- Miliauskas, C. R., Faus, D. P., da Cruz, V. L., do Nascimento Vallaperde, J. G. R., Junger, W., & Lopes, C. S. (2022). Community violence and internalizing mental health symptoms in adolescents: A systematic review. *BMC Psychiatry*, 22(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-03873-8>
- Modrzejewska, A., Czepczor-Bernat, K., Modrzejewska, J., Roszkowska, A., Zembura, M., & Matusik, P. (2022). #childhoodobesity – A brief literature review of the role of social media in body image shaping and eating patterns among children and adolescents. *Frontiers in Pediatrics*, 10(August). <https://doi.org/10.3389/fped.2022.993460>
- Mougharbel, F., Chaput, J. P., Sampasa-Kanyinga, H., Hamilton, H. A., Colman, I., Leatherdale, S. T., & Goldfield, G. S. (2023). Heavy social media use and psychological distress among adolescents: the moderating role of sex, age, and parental support. *Frontiers in Public Health*, 11(June), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1190390>
- Mozafarian, N., Hashemipour, M., Maracy, M. R., Pourrajab, M., Omid, R., & Kelishadi, R. (2025). The study of pubertal stage and age of menarche in girls in Isfahan province, Iran. *BMC Pediatrics*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-024-05212-0>
- Nguyen, T. H. H., & Nguyen, T. N. T. (2023). Parent-adolescent conflict: an exploration from the perspective of Vietnamese adolescents. *Frontiers in Psychology*,

- 14(November), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1243494>
- Opdenakker, M. C. (2022). Developments in early adolescents' self-regulation: The importance of teachers' supportive vs. undermining behavior. *Frontiers in Psychology*, 13(November), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1021904>
- Orben, A., Tomova, L., & Blakemore, S. J. (2020). The effects of social deprivation on adolescent development and mental health. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(8), 634–640. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30186-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30186-3)
- Öztürk, Y., Eichhorn, T., & Zerle-Elsäßer, C. (2023). Conflicts in Adolescence and Their Association with Closeness: Results of a Multi-Perspective Study from Germany. *Youth*, 3(4), 1363–1377. <https://doi.org/10.3390/youth3040085>
- Peters, K. Z., & Naneix, F. (2022). The role of dopamine and endocannabinoid systems in prefrontal cortex development: Adolescence as a critical period. *Frontiers in Neural Circuits*, 16. <https://doi.org/10.3389/fncir.2022.939235>
- Pollak, I., Mitic, M., Birchwood, J., Dörfler, S., Krammer, I., Rogers, J. C., Schek, E. J., Schrank, B., Stiehl, K. A. M., & Woodcock, K. A. (2023). A Systematic Review of Intervention Programs Promoting Peer Relationships Among Children and Adolescents: Methods and Targets Used in Effective Programs. *Adolescent Research Review*, 8(3), 297–321. <https://doi.org/10.1007/s40894-022-00195-4>
- Rimbawan, R., Nurdiani, R., Rachman, P., Kawamata, Y., & Nozawa, Y. (2023). Los programas de almuerzos escolares y la educación nutricional mejoran los conocimientos, las actitudes y las prácticas y reducen la prevalencia de la anemia: Un estudio pre-postintervención en un internado islámico indonesio. *Nutrients*, 15(4), 1–15.
- Rodgers, R. F., Laveway, K., Campos, P., & De Carvalho, P. H. B. (2023). Body image as a global mental health concern. *Global Mental Health*, 10. <https://doi.org/10.1017/gmh.2023.2>
- Rosenfield, R. L. (2021). Normal and Premature Adrenarche. *Endocrine Reviews*, 42(6), 783–814. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnab009>
- Ross, D. A., Hinton, R., Melles-Brewer, M., Engel, D., Zeck, W., Fagan, L., Herat, J., Phaladi, G., Imbago-Jácome, D., Anyona, P., Sanchez, A., Damji, N., Terki, F., Baltag, V., Patton, G., Silverman, A., Fogstad, H., Banerjee, A., & Mohan, A. (2020). Adolescent Well-Being: A Definition and Conceptual Framework. *Journal of Adolescent Health*, 67(4), 472–476. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.06.042>
- Rueth, J. E., & Lohaus, A. (2022). Process-Oriented Measurement of Emotion Regulation: General and Specific Associations With Psychosocial

- Adjustment and Well-Being in (Pre-)Adolescence. *Frontiers in Psychiatry*, 13(June), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.904389>
- Santos, R. M. S., Ventura, S. de A., Nogueira, Y. J. de A., Mendes, C. G., Paula, J. J. de, Miranda, D. M., & Romano-Silva, M. A. (2024). The Associations Between Screen Time and Mental Health in Adults: A Systematic Review. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 9(4), 825–845. <https://doi.org/10.1007/s41347-024-00398-7>
- Schrijvers, K., Cosma, A., Potrebny, T., Thorsteinsson, E., Catunda, C., Reiss, F., Hulbert, S., Kostičová, M., Melkumova, M., Bersia, M., Klanšček, H. J., Gaspar, T., & Dierckens, M. (2024). Three Decades of Adolescent Health: Unveiling Global Trends Across 41 Countries in Psychological and Somatic Complaints (1994–2022). *International Journal of Public Health*, 69(December). <https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1607774>
- Sell, K., Oliver, K., & Meiksin, R. (2023). Comprehensive Sex Education Addressing Gender and Power: A Systematic Review to Investigate Implementation and Mechanisms of Impact. *Sexuality Research and Social Policy*, 20(1), 58–74. <https://doi.org/10.1007/s13178-021-00674-8>
- Senekal, J. S., Ruth Groenewald, G., Wolfaardt, L., Jansen, C., & Williams, K. (2023). Social media and adolescent psychosocial development: a systematic review. *South African Journal of Psychology*, 53(2), 157–171. <https://doi.org/10.1177/00812463221119302>
- Shareck, M., Aubé, E., & Sersli, S. (2023). Neighborhood Physical and Social Environments and Social Inequalities in Health in Older Adolescents and Young Adults: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph20085474>
- Steigen, A. M., Finbråten, H. S., & Kleppang, A. L. (2022). Using Rasch Analysis to Assess the Psychometric Properties of a Five-Item Version of the General Self-Efficacy Scale in Adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph19053082>
- Street, M. E., Ponzi, D., Renati, R., Petraroli, M., D'Alvano, T., Lattanzi, C., Ferrari, V., Rollo, D., & Stagi, S. (2023). Precocious puberty under stressful conditions: new understanding and insights from the lessons learnt from international adoptions and the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Endocrinology*, 14(May), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1149417>
- Tafà, M., Bracaglia, F., Inguscio, L., & Carone, N. (2023). What Decides the Well-Being of the Relationship between Parents and Adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1).

<https://doi.org/10.3390/ijerph20010383>

- Towner, E., Grint, J., Levy, T., Blakemore, S.-J., & Tomova, L. (2022). Revealing the self in a digital world: A systematic review of adolescent online and offline self-disclosure. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101309. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101309>
- van Duijvenvoorde, A. C. K., van Hoorn, J., & Blankenstein, N. E. (2022). Risks and rewards in adolescent decision-making. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101457. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101457>
- Vrolijk, P., Van Lissa, C. J., Branje, S., Meeus, W. H. J., & Keizer, R. (2023). Within-family linkages between parental monitoring and adolescents externalizing problems with autonomy support as a moderator. *Journal of Research on Adolescence: The Official Journal of the Society for Research on Adolescence*, 33(4), 1179–1195. <https://doi.org/10.1111/jora.12868>
- Wahyuningsih, S., Widati, S., Praveena, S. M., & Azkiya, M. W. (2024). Unveiling barriers to reproductive health awareness among rural adolescents: a systematic review. *Frontiers in Reproductive Health*, 6(November), 1–9. <https://doi.org/10.3389/frph.2024.1444111>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Adolescent Health*. <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Adolescent Health and Development*. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/adolescent-health-and-development>
- Zanolie, K., Ma, I., Bos, M. G. N., Schreuders, E., Vandenbroucke, A. R. E., van Hoorn, J., van Duijvenvoorde, A. C. K., Wierenga, L., Crone, E. A., & Güroğlu, B. (2022). Understanding the Dynamics of the Developing Adolescent Brain Through Team Science. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 16(February), 2016–2023. <https://doi.org/10.3389/fnint.2022.827097>
- Zenebe, G. A., Ewunie, T. M., Belay, M. M., & Abose, A. M. (2023). Quality of adolescent and youth-friendly sexual and reproductive health services and associated factors in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1191676>.

Glosarium

<i>Adolescence</i> (Remaja)	: Masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial secara bertahap.
<i>Body Image</i> (Citra Tubuh)	: Persepsi, pikiran, dan perasaan individu terhadap bentuk, ukuran, serta penampilan tubuhnya.
<i>Bullying</i> (Perundungan)	: Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan individu lain secara fisik, verbal, maupun sosial.
<i>Cyberbullying</i> (Perundungan Daring)	: Bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital atau platform daring, seperti media sosial, pesan elektronik, atau aplikasi komunikasi.
Estrogen	: Hormon reproduksi utama pada perempuan yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan karakteristik seksual sekunder.
<i>Growth Spurt</i>	: Percepatan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang terjadi selama masa pubertas.
Hipotalamus–Hipofisis– Gonad (HHG)	: Sistem hormonal yang berperan dalam mengatur proses pubertas melalui koordinasi antara hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan ovarium.
Identitas Diri	: Pemahaman individu mengenai siapa dirinya, nilai yang diyakini, serta peran sosial yang dijalani dalam kehidupan.
Kemandirian Psikologis	: Kemampuan individu untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri sesuai nilai dan tanggung jawab pribadi.
Kesehatan Mental	: Kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu mampu mengelola stres, berfungsi secara produktif, dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan.

Kesehatan Reproduksi	: Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
Konsep Diri (<i>Self-Concept</i>)	: Pandangan, penilaian, dan pemahaman individu terhadap dirinya sendiri, termasuk kemampuan, karakter, dan identitas personal.
Literasi Digital	: Kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab.
Literasi Kesehatan Reproduksi	: Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi terkait kesehatan reproduksi dalam pengambilan keputusan kesehatan.
Menarche	: Menstruasi pertama yang menandai dimulainya fungsi reproduksi pada remaja putri.
Menstruasi	: Proses peluruhan lapisan dinding rahim yang disertai perdarahan secara periodik sebagai bagian dari siklus reproduksi perempuan.
<i>Mood Swing</i> (Perubahan Suasana Hati)	: Perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat dalam waktu relatif singkat.
Ovulasi	: Proses pelepasan sel telur matang dari ovarium sebagai bagian dari siklus reproduksi perempuan.
<i>Peer Pressure</i> (Tekanan Teman Sebaya)	: Dorongan dari kelompok teman sebaya yang memengaruhi individu untuk menyesuaikan perilaku, sikap, atau keputusan agar diterima dalam kelompok.
Progesteron	: Hormon reproduksi perempuan yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi dan persiapan kehamilan.
Pubertas	: Masa pematangan biologis ketika individu mulai mengalami perkembangan seksual dan reproduksi.

Regulasi Emosi	: Kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara adaptif.
Siklus Menstruasi	: Rangkaian perubahan hormonal dan fisiologis pada sistem reproduksi perempuan yang berlangsung secara periodik untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan.
<i>Social Comparison</i> (Perbandingan Sosial)	: Kecenderungan individu membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan, penampilan, atau status sosialnya.
Teman Sebaya	: Individu dengan rentang usia atau tahap perkembangan yang relatif sama dan memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial remaja.
Thelarche	: Tahap awal perkembangan payudara yang menjadi salah satu tanda pertama pubertas pada remaja putri.

CHAPTER 3

MENSTRUASI SEHAT DAN PENANGANAN MASALAH MENSTRUASI REMAJA

Ns. Meriem Meisyaroh Syamson, S.Kep., M.Kes.

A. Definisi dan Konsep Menstruasi Sehat

Menstruasi adalah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus (Bobak, 2004). Kondisi ini terjadi karena tidak ada pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim (endometrium) yang sudah menebal untuk persiapan kehamilan menjadi luruh. Jika seorang wanita tidak mengalami kehamilan, maka siklus menstruasi akan terjadi setiap bulannya. Umumnya siklus menstruasi pada wanita yang normal adalah 28-35 hari dan lama haid antara 3-7 hari. Siklus menstruasi pada wanita dikatakan tidak normal jika siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. siklusmenstruasi merupakan waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya, sedangkan panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya Proverawati dan Maisaroh (2009).

1. Fase-fase pada siklus menstruasi

a. Siklus Endomentrium

1) Fase menstruasi

Fase ini adalah fase yang harus dialami oleh seorang wanita dewasa setiap bulannya. Sebab melalui fase ini wanita baru dikatakan produktif. Oleh karena itu fase menstruasi selalu dinanti oleh para wanita, walaupun kedatangannya membuat para wanita merasa tidak nyaman untuk beraktifitas. Biasanya ketidaknyamanan ini terjadi hanya 1-2 hari, dimana pada awal haid pendarahan yang keluar lebih banyak dan gumpalan darah lebih sering keluar. Pada fase menstruasi, endometrium terlepas dari dinding uterus dengan disertai pendarahan. Rata-rata fase ini berlangsung selama lima hari (rentang 3-6 hari). Pada awal fase menstruasi kadar estrogen, progesteron, LH (Lutenizing Hormon) menurun atau pada kadar terendahnya, sedangkan siklus dan kadar FSH (Folikel Stimulating Hormon) baru mulai meningkat

2) Fase Proliferasi

Pada fase ini ovarium sedang melakukan proses pembentukan dan pematangan ovum. Fase proliferasi merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sejak sekitar hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus haid. Permukaan endometrium secara lengkap kembali normal sekitar empat hari atau menjelang perdarahan berhenti. Dalam fase ini endometrium tumbuh menjadi tebal $\pm 3,5$ mm atau sekitar 8-10 kali lipat dari semula, yang akan berakhir saat ovulasi. Pada fase proliferasi terjadi peningkatan kadar hormon estrogen, karena fase ini tergantung pada stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium.

3) Fase sekresi/luteal

Fase sekresi berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar tiga hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Pada akhir fase sekresi, endometrium sekretorius yang matang dengan sempurna mencapai ketebalan seperti beludru yang tebal dan halus. Endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar. Umumnya pada fase pasca ovulasi wanita akan lebih sensitif. Sebab pada fase ini hormon reproduksi (FSH, LH, estrogen dan progesteron) mengalami peningkatan. Jadi pada fase ini wanita mengalami yang namanya Pre Menstrual Syndrome (PMS). Beberapa hari kemudian setelah gejala PMS maka lapisan dinding rahim akan luruh kembali.

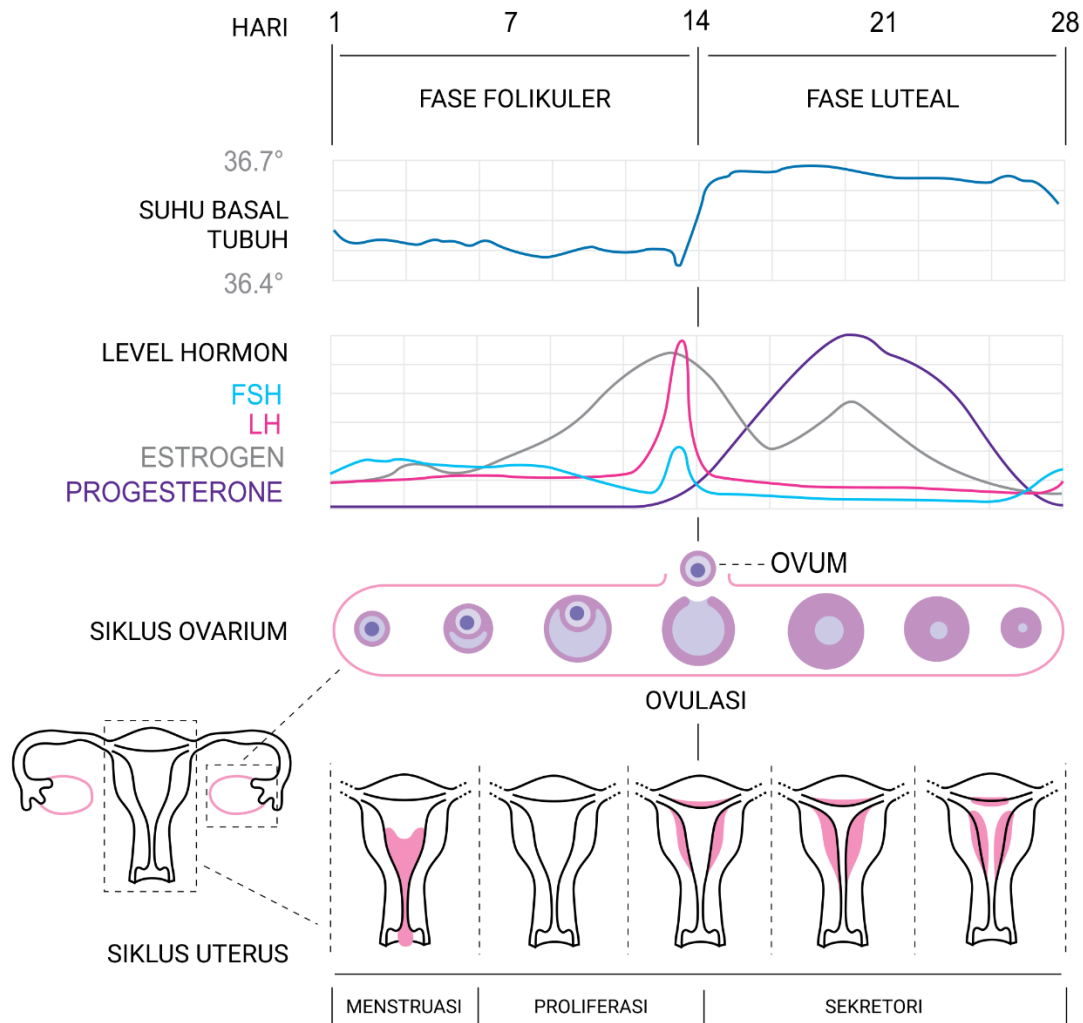
4) Fase iskemi/premenstrual

Apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi, korpus Luteum yang mensekresi estrogen dan progesterone menyusut. Seiring penyusutan kadar estrogen dan progesterone yang cepat, arteri spiral menjadi spasme, sehingga suplai darah ke endometrium fungsional terhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan perdarahan menstruasi dimulai.

b. Siklus Ovarium

Ovulasi merupakan peningkatan kadar estrogen yang menghambat pengeluaran FSH, kemudian kelenjar hipofisis mengeluarkan LH (lutenizing hormon). Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Sebelum ovulasi, satu sampai 30 folikel mulai matur didalam ovarium dibawah pengaruh FSH dan estrogen. Lonjakan LH sebelum terjadi ovulasi mempengaruhi folikel yang terpilih. Di dalam folikel yang terpilih, oosit matur (folikel de Graaf) terjadi ovulasi, sisa folikel yang kosong di dalam ovarium berformasi menjadi korpus luteum. Korpus luteum mencapai puncak aktivitas fungsional pada 8 hari setelah ovulasi, dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Apabila tidak terjadi implantasi, korpus luteum berkurang dan

kadar hormon progesterone menurun. Sehingga lapisan fungsional endometrium tidak dapat bertahan dan akhirnya luruh (Bobak, 2004).



Gambar 3. 1 Siklus Menstruasi (Clayton, 2008)

B. Variasi Normal pada Remaja Awal

Remaja awal menunjukkan variasi siklus menstruasi akibat imaturitas aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium (HPO). Variasi ini bersifat fisiologis dalam 1-2 tahun pertama pascamenarche. Bab ini membahas karakteristik, dasar biologis, serta implikasi klinis untuk praktik keperawatan.

1. Karakteristik variasi normal

a. Siklus Anovulatorik

Siklus anovulatorik adalah siklus tanpa pelepasan ovum. Kondisi ini umum pada awal menarche.

- 1) Terjadi pada $\pm 50\%$ siklus dalam 1 tahun pertama
- 2) Tidak ada lonjakan LH yang adekuat

- 3) Endometrium tetap mengalami proliferasi tanpa fase sekretori optimal
 - b. Interval Siklus yang Memanjang
Interval antar siklus pada remaja awal dapat lebih panjang dibanding dewasa
 - 1) Rentang normal remaja : 21-45 hari (lebih luas dari dewasa)
 - 2) Siklus >35 hari masih fisiologis selama tidak persisten ekstrem
 - c. Pola Perdarahan Tidak Teratur
Perdarahan menstruasi pada remaja awal sering menunjukkan variasi
 - 1) Durasi dapat lebih pendek atau tidak konsisten
 - 2) Volume darah cenderung ringan hingga sedang
 - 3) Kadang terjadi spotting intermenstrual ringan
2. Determinasi Biologis
- a. Imaturitas Aksis HPO
Aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium belum matang sepenuhnya pada awal pubertas.
 - 1) Pulsatilitas GnRH belum stabil
 - 2) Sekresi FSH dan LH fluktuatif
 - 3) Umpan balik estrogen-progesteron belum optimal
 - b. Respons Ovarium yang Belum Konsisten
Ovarium belum selalu merespons stimulasi gonadotropin secara adekuat
 - 1) Folikel dapat berkembang tanpa ovulasi
 - 2) Produksi progesterone rendah akibat tidak terbentuk korpus luteum optimal
3. Implikasi Klinis dalam Keperawatan
- a. Ketidakteraturan pada fase awal pubertas tidak otomatis patologis. Pendekatan konservatif lebih dianjurkan. Peran perawat : Edukasi remaja dan keluarga tentang variasi normal, monitoring siklus menggunakan kalender atau aplikasi, mengurangi kecemasan terkait perubahan tubuh.
 - b. Indikasi Evaluasi Lanjut
Meskipun banyak variasi bersifat normal, kondisi berikut memerlukan penilaian klinis: Amenore >3 bulan setelah siklus sebelumnya, Perdarahan sangat banyak (≥ 80 mL atau >7 hari), Gejala anemia : lemah, pucat, pusing, Tanda gangguan endokrin : obesitas ekstrem, hirsutisme, atau galaktorea.
4. Dampak Psikososial
Ketidakteraturan siklus dapat memengaruhi persepsi diri remaja.
- a. Menimbulkan kecemasan terkait "ketidaknormalan"
 - b. Berpotensi memengaruhi kepercayaan diri dan aktivitas sekolah

C. Perkembangan Remaja dan Menarche

Perkembangan remaja ditandai oleh aktivasi aksis hipotalamus–hipofisis–ovarium (HPO) yang memicu pubertas dan menarche. Menarche umumnya terjadi pada usia 12–13 tahun secara global. Variasi dipengaruhi faktor genetik, status nutrisi, dan kondisi sosial ekonomi. Asumsi: populasi remaja sehat tanpa penyakit kronis signifikan.

Pubertas adalah proses maturasi biologis menuju kemampuan reproduksi. Menarche adalah menstruasi pertama sebagai indikator maturasi endokrin dan reproduksi.

1. Tahapan Pubertas (Tanner Staging)

- a. Tanner Stage I (Pra Pubertas) : Tidak ada perkembangan payudara, tidak ada rambut pubis, aktivitas hormonal minimal.
- b. Tanner Stage II (Awal Pubertas) : Thelarche, pembesaran payudara awal, rambut pubis halus mulai muncul, aktivitas awal GnRH ke peningkatan FSH dan LH
- c. Tanner Stage III : Payudara berkembang lebih lanjut, areola menonjol, rambut pubis menyerupai dewasa, tetapi belum menyebar luas, menarche biasanya terjadi pada tahap ini
- d. Tanner Stage IV : Payudara berkembang lebih lanjut, areola menonjol, rambut pubis menyerupai dewasa, tetapi belum menyebar luas, menarche biasanya terjadi pada tahap ini
- e. Tanner Stage V : Payudara matur, rambut pubis distribusi dewasa, fungsi reproduksi relative matang

2. Usia Menarche

Secara global berkisar 12-13 tahun, dengan variasi antar populasi

- a. Negara maju : $\pm 12,5$ tahun
- b. Negara berkembang : sedikit lebih tinggi, tergantung nutrisi

Variasi Usia Menarche

- a. Normal : 10-15 tahun
- b. Menarche dini (<10 tahun) : perlu evaluasi pubertas prekoks
- c. Menarche terlambat (> 15 tahun) : evaluasi pubertas terlambat
- d. Faktor Variasi : Ras/etnis, Lingkungan, Status kesehatan

3. Faktor Determinan Menarche

Faktor genetik merupakan determinan utama usia pubertas :

- a. Korelasi kuat antara usia menarche ibu dan anak
- b. Variasi genetic memengaruhi sensitivitas aksis HPO

Status Nutrisi mempengaruhi aktivitas hormonal dan komposisi tubuh

- a. Lemak tubuh minimum diperlukan untuk menarche
- b. Obesitas, menarche lebih awal
- c. Malnutrisi, menarche tertunda

Status Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi mempengaruhi nutrisi, stress, dan akses kesehatan

- a. Sosial ekonomi tinggi, menarche lebih awal (nutrisi adekuat)
- b. Sosial ekonomi rendah, variasi; dapat mempercepat (stress) atau menunda (malnutrisi)

4. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

- a. Aktivitas fisik ekstrem (atlet) menunda menarche
- b. Paparan endocrine disruptors potensi percepatan pubertas
- c. Urbanisasi tren menarche lebih dini

D. Menstruasi Sehat pada Remaja

Menstruasi adalah keadaan yang normal, yang akan dialami oleh setiap perempuan yang normal kesehatannya. Tetapi pada saat menstruasi dapat terjadi beberapa hal yang mungkin dapat mencemaskan diri kita ataupun keluarga. Walaupun tidak semua perempuan akan mengalami hal yang sama, namun beberapa gangguan atau perubahan keadaan ketika menstruasi adalah normal. Namun demikian, kalau dibiarkan begitu saja, apalagi kita tidak mengerti, tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut, gangguan tersebut mungkin akan semakin parah. Akan tetapi kalau kita memahaminya dan tahu cara mengatasinya, maka kemungkinan besar gangguan tersebut akan menjadi ringan sehingga tidak akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari.

1. Praktik higiene menstruasi yang adekuat mencakup:
 - a. Mengganti pembalut setiap 4–6 jam atau saat penuh
 - b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut
 - c. Membersihkan genitalia dengan air bersih (arah depan ke belakang)
 - d. Menggunakan pakaian dalam bersih dan kering
 - e. Membuang pembalut bekas secara higienis
2. Ketersediaan fasilitas sangat menentukan kualitas hygiene :
 - a. Air bersih mengalir
 - b. Sabun atau antiseptic ringan
 - c. Toilet privat dan aman
 - d. Tempat pembuangan limbah

3. Jenis Produk Menstruasi :
 - a. Pembalut sekali pakai
 - b. Pembalut Kain
 - c. Menstrual Cup
4. Jenis Risiko akibat Higiene Buruk
 - a. Praktik hygiene yang tidak adekuat meningkatkan risiko : Infeksi saluran reproduksi, Infeksi saluran kemih, Iritasi dan dermatitis vulva
 - b. Mekanisme risiko, Pembalut jarang diganti, pertumbuhan bakteri meningkat, kelembapan tinggi lingkungan ideal mikroorganisme, penggunaan bahan tidak bersih kontaminasi langsung
5. Konteks Budaya dan Stigma
 - a. Komunitas menstruasi masih dikaitkan dengan stigma, larangan aktivitas tertentu (olahraga, ibadah)
 - b. Anggapan “kotor” atau tabu,
 - c. Pembatasan akses informasi
6. Dampak Stigma
 - a. Menurunkan kepercayaan diri remaja
 - b. Menghambat praktik hygiene optimal
 - c. Menyebabkan absensi sekolah

E. Nutrisi dan Gaya Hidup

1. Peran Nutrisi dalam Menstruasi

Status nutrisi dan gaya hidup memodulasi aksis hipotalamus–hipofisis–ovarium (HPO) serta kualitas siklus menstruasi. Asupan zat besi, vitamin, dan cairan memengaruhi volume darah, gejala, dan risiko anemia. Aktivitas fisik dan kualitas tidur berperan dalam regulasi hormonal. Asumsi: remaja tanpa penyakit kronis mayor.

- a. Zat Besi krusial untuk sintesis haemoglobin dan kompensasi kehilangan darah menstruasi :
 - 1) Kebutuhan remaja putri : ± 15 mg/hari (RDA)
 - 2) Kehilangan darah menstruasi meningkatkan risiko anemia defisiensi besi.
 - 3) Gejala: lemah, pusing, konsentrasi menurun.
 - 4) Sumber pangan: Heme: daging merah, hati (bioavailabilitas tinggi), Non-heme: sayuran hijau, kacang-kacangan
 - 5) Implikasi klinis : Suplementasi dipertimbangkan pada anemia atau risiko tinggi, Kombinasi dengan vitamin C meningkatkan absorpsi.

- b. Vitamin dan Mikronutrien

Beberapa vitamin berperan dalam regulasi siklus dan gejala menstruasi:

 - 1) Vitamin B kompleks (B6): modulasi neurotransmitter → mengurangi gejala PMS
 - 2) Vitamin D: regulasi hormon reproduksi dan sensitivitas insulin
 - 3) Vitamin E: berpotensi mengurangi nyeri haid melalui efek antiinflamasi
 - 4) Magnesium: relaksasi otot polos → membantu dismenore
 - c. Cairan (Hidrasi), Hidrasi memengaruhi volume plasma dan kenyamanan selama menstruasi.
 - 1) Anjuran: $\pm 1,5\text{--}2$ liter/hari
 - 2) Dehidrasi dapat memperburuk kelelahan dan nyeri
2. Aktivitas Fisik dan Menstruasi
- a. Peran Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik moderat berkontribusi terhadap stabilitas hormonal.

 - 1) Meningkatkan sirkulasi darah
 - 2) Menurunkan prostaglandin → mengurangi nyeri haid
 - 3) Mengurangi stres dan gejala PMS
 - b. Risiko Aktivitas Berlebihan

Latihan intensitas tinggi tanpa keseimbangan energi dapat mengganggu siklus

 - 1) Menyebabkan amenore hipotalamik fungsional
 - 2) Penurunan GnRH akibat deficit energi
3. Kualitas Tidur dan Regulasi Hormonal
- a. Hubungan Tidur dan Hormon

Tidur berperan dalam sinkronisasi ritme sirkadian dan sekresi hormone

 - 1) Durasi ideal remaja: 8–10 jam/malam
 - 2) Gangguan tidur → disrupti GnRH, kortisol meningkat
 - b. Dampak Klinis :
 - 1) Siklus tidak teratur
 - 2) Peningkatan gejala PMS
 - 3) Penurunan kualitas hidup
4. Dampak Status Gizi terhadap Siklus Menstruasi
- a. Obesitas mempengaruhi metabolisme hormone dan fungsi ovarium
 - 1) Peningkatan estrogen perifer dari jaringan adiposa
 - 2) Resistensi insulin → risiko sindrom ovarium polikistik (PCOS)
 - 3) Siklus tidak teratur atau anovulasi
 - b. Undernutrition (Malnutrisi), kekurangan energi dan lemak tubuh menghambat fungsi reproduksi
 - 1) Penurunan leptin → inhibisi GnRH

- 2) Amenore atau keterlambatan menarche
- 3) Risiko gangguan tulang (densitas mineral rendah)

F. Kesehatan Mental dan Menstruasi

Kesehatan mental dalam konteks menstruasi adalah kemampuan remaja mengelola perubahan emosi, stres, dan persepsi diri yang dipengaruhi fluktuasi hormon reproduksi. Ruang lingkup mencakup hubungan biologis hormon–emosi, strategi coping adaptif, serta aspek psikososial (body image dan self-esteem).

1. Hubungan Hormon dan Emosi

Fluktuasi hormon sepanjang siklus memengaruhi neurotransmitter otak.

- a. Estrogen meningkatkan aktivitas serotonin dan dopamin → efek stabilisasi mood.
- b. Progesteron dan metabolitnya (allopregnanolone) memodulasi reseptor GABA → efek sedatif/ansietas.
- c. Penurunan tajam hormon pada akhir fase luteal → memicu gejala emosional.

2. Pola Emosi Berdasarkan Fase

Sebagian remaja mengalami Premenstrual Syndrome (PMS); sebagian kecil mengalami Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) dengan gejala lebih berat.

- a. Fase folikular (awal siklus): energi meningkat, mood relatif stabil.
- b. Ovulasi: peningkatan well-being dan kepercayaan diri.
- c. Fase luteal akhir: iritabilitas, mudah marah, cemas, atau sedih.

3. Edukasi Coping Stress

- a. Konsep coping adalah strategi kognitif dan perilaku untuk mengelola stres. Pada remaja, coping adaptif menurunkan dampak negatif PMS dan meningkatkan fungsi harian.

b. Strategi Coping Adaptif

- 1) Teknik relaksasi: napas dalam, progressive muscle relaxation (PMR)
- 2) Aktivitas fisik ringan–moderat: berjalan, stretching, yoga.
- 3) Manajemen waktu dan tugas sekolah: mengurangi overload saat fase luteal.
- 4) Jurnal emosi/menstrual diary: mengenali pola gejala dan pemicu.
- 5) Dukungan sosial: komunikasi dengan teman, keluarga, atau tenaga kesehatan.

c. Edukasi berbasis keperawatan

- 1) Ajarkan identifikasi fase siklus dan antisipasi gejala.
- 2) Latih keterampilan regulasi emosi (reframing kognitif, problem-solving)
- 3) Integrasikan edukasi dengan program sekolah atau layanan kesehatan remaja.

4. Body Image dan Self -Esteem

- a. Body Image adalah persepsi dan sikap individu terhadap tubuhnya
 - 1) Pubertas memicu perubahan bentuk tubuh (lemak tubuh meningkat, payudara berkembang)
 - 2) Perubahan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan tubuh pada sebagian remaja
- b. Self-Esteem adalah penilaian individu terhadap nilai diri
 - 1) Fluktuasi hormon dan pengalaman sosial (stigma menstruasi) memengaruhi self-esteem.
 - 2) Self-esteem rendah berkorelasi dengan kecemasan dan depresi ringan
- c. Faktor Risiko
 - 1) Paparan standar kecantikan tidak realistis (media sosial)
 - 2) Kurangnya edukasi pubertas
 - 3) Stigma budaya terhadap menstruasi

G. Masalah Menstruasi pada Remaja

1. Dismenoreia disebut juga kram menstruasi atau nyeri menstruasi.

Dalam bahasa Inggris, dismenoreia sering disebut sebagai “painful period” atau menstruasi yang menyakitkan (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2015). Nyeri menstruasi terjadi terutama di perut bagian bawah, tetapi dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, paha atas, hingga betis. Nyeri juga bisa disertai kram perut yang parah. Kram tersebut berasal dari kontraksi otot rahim yang sangat intens saat mengeluarkan darah menstruasi dari dalam rahim. Kontraksi otot yang sangat intens ini kemudian menyebabkan otot-otot menegang dan menimbulkan kram atau rasa sakit atau nyeri. Ketegangan otot ini tidak hanya terjadi pada bagian perut, tetapi juga pada otot-otot penunjang yang terdapat di bagian punggung bawah, pinggang, panggul, paha hingga betis.

Proses ini sebenarnya merupakan bagian normal proses menstruasi, dan biasanya mulai dirasakan ketika mulai perdarahan dan terus berlangsung hingga 32-48 jam. Sebagian besar perempuan yang menstruasi pernah mengalami dismenoreia dalam derajat keparahan yang berbeda-beda. Dismenoreia yang dialami remaja umumnya bukan karena penyakit, dan disebut dismenoreia primer. Dismenoreia primer pada perempuan yang lebih dewasa akan makin berkurang rasa sakit dan nyerinya. Dismenoreia primer juga makin berkurang pada perempuan yang sudah melahirkan.

Pada wanita lebih tua, dismenorea dapat disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya fibroid uterus, radang panggul, endometriosis atau kehamilan ektopik. Dismenorea yang disebabkan oleh penyakit disebut dismenorea sekunder. Berbeda dengan dismenorea primer, rasa sakit dan nyeri pada dismenorea sekunder biasanya berlangsung lebih lama dari pada dismenorea primer. Nyeri karena dismenorea sekunder biasanya dimulai beberapa hari sebelum menstruasi, makin lama akan makin terasa nyeri selama menstruasi berlangsung, dan biasanya baru hilang beberapa hari setelah menstruasi selesai. Apabila pada dismenorea primer, rasa sakit akan makin berkurang seiring dengan makin bertambahnya umur, pada dismenorea sekunder, makin bertambah umur biasanya makin bertambah parah.

2. Penyebab Dismenorea

a. Dismenore Primer

- 1) Umumnya muncul 6–12 bulan setelah menarche
- 2) Berkaitan dengan siklus ovulatorik
- 3) Nyeri berlangsung 8–72 jam
- 4) Tidak ditemukan patologi pada pemeriksaan

b. Dismenore Sekunder

- 1) Endometriosis
- 2) Adenomiosis
- 3) Infeksi Pelvis

3. Mengatasi Dismenore

Dismenorea primer dapat diperingan gejalanya dengan obat penghilang nyeri/anti-inflamasi seperti ibuprofen, ketoprofen, naproxen, dan obat analgesik-antiinflamasi lainnya. Obat-obat analgesik ini akan mengurangi produksi prostaglandin. Berolah raga dan banyak bergerak akan memperlancar aliran darah dan tubuh akan terangsang untuk memproduksi endorfin yang bekerja mengurangi rasa sakit dan menimbulkan rasa gembira. Kompres dengan botol air panas dan mandi air hangat juga dapat mengurangi rasa sakit. Jika suka, cobalah diurut atau dipijat dengan tekanan ringan, jangan terlalu keras, untuk membantu menghilangkan rasa pegal pada otot-otot tubuh Anda. Berbaring pada satu sisi tubuh Anda, lalu tarik lutut sampai ke batas dada, lakukan beberapa kali. Ini akan membantu meringankan rasa sakit dan pegal pada punggung. Makan makanan bergizi dan hindari konsumsi garam dan kafein. Bila nyeri menstruasi tidak hilang dengan obat pereda nyeri atau cara-cara yang sudah disebutkan tadi, maka sebaiknya Anda berkonsultasi kepada dokter. Beliau mungkin akan memberikan obat-obat yang lebih kuat daya kerjanya atau mungkin akan memberikan terapi hormonal, atau akan melakukan pemeriksaan

yang lebih intensif untuk menemukan sumber masalah, sehingga dapat menyarankan penanganan yang lebih tepat.

4. Dampak Terhadap Kualitas Hidup

a. Dampak Fisik

- 1) Nyeri hebat menghambat aktivitas harian
- 2) Gangguan Tidur
- 3) Kelelahan dan Penurunan energi

b. Dampak Psikologis

- 1) Iritabilitas dan perubahan mood
- 2) Kecemasan terhadap siklus menstruasi
- 3) Penurunan konsentrasi belajar

c. Dampak Sosial dan Pendidikan

- 1) Absensi sekolah meningkat
- 2) Penurunan performa akademik
- 3) Pembatasan aktivitas sosial dan olahraga

H. Gangguan Siklus Menstruasi pada Remaja

1. Amenorea

Gangguan siklus menstruasi mencakup kelainan frekuensi, durasi, dan volume perdarahan. Kondisi utama meliputi amenore, oligomenore, polimenore, menorrhagia, dan metrorrhagia. Identifikasi dini penting untuk mencegah komplikasi seperti anemia dan gangguan endokrin. Asumsi: remaja berada pada 2–5 tahun pascamenarche.

Amenorea adalah keadaan dimana menstruasi berhenti atau tidak terjadi pada masa subur atau pada saat yang seharusnya menstruasi terjadi secara teratur. Hal ini tentu saja tidak termasuk berhenti menstruasi pada wanita yang sedang hamil, menyusui atau menopause.

Amenorea dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu amenorea primer dan amenorea sekunder. Amenorea primer adalah istilah yang digunakan untuk perempuan yang terlambat mulai menstruasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada Bab II, biasanya seorang perempuan akan mengalami menstruasi pertama sekitar usia 10 tahun hingga 16 tahun. Jika usianya sudah menginjak 16 tahun dan belum menstruasi, maka ini yang disebut amenorea primer. Hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian. Seseorang terlambat mulai menstruasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kelainan hormonal, gangguan kesehatan fisik atau masalah tekanan jiwa dan emosi.

Amenorea sekunder adalah berhenti menstruasi, paling tidak selama 3 bulan berturut turut, padahal sebelumnya sudah pernah mengalami menstruasi. Amenore sekunder dapat disebabkan oleh rendahnya hormon pelepas gonadotropin (GoRH = Gonadotropine Releasing Hormone), yaitu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus (salah satu bagian dari otak), yang salah satu fungsinya adalah mengatur siklus menstruasi. Di samping itu, kondisi stres, anoreksia, penurunan berat badan yang ekstrim, gangguan tiroid, olahraga berat, pil KB, dan kista ovarium, juga dapat menyebabkan amenorea.

2. Polimenorea

Polimenorea merupakan kelainan siklus menstruasi yang menyebabkan wanita berkali-kali mengalami menstruasi dalam sebulan, bisa dua atau tiga kali atau bahkan lebih. Normalnya, siklus menstruasi berlangsung selama 21- 35 hari dengan durasi sekitar 2-8 hari. Wanita yang mengalami polimenorea memiliki siklus menstruasi yang lebih pendek dari 21 hari dengan pola yang teratur dan jumlah perdarahan yang relatif sama atau lebih banyak dari biasanya.

Polimenorea berbeda dengan metroragia. Metroragia merupakan suatu perdarahan iregular yang terjadi di antara dua waktu menstruasi. Pada metroragia menstruasi terjadi dalam waktu yang lebih singkat dengan darah yang dikeluarkan lebih sedikit. Polimenorea berbeda pula dengan menoragia. Menoragia adalah istilah medis untuk perdarahan menstruasi yang berlebihan. Dalam satu siklus menstruasi normal, perempuan rata-rata kehilangan sekitar 30-40 ml darah selama sekitar 7 hari haid, tetapi pada menoragia perdarahan dapat melampaui 7 hari dan jumlahnya lebih banyak (melebihi 80 ml).

3. Menoragia

Menoragia adalah istilah medis untuk perdarahan menstruasi yang berlebihan. Dalam satu siklus menstruasi normal, perempuan rata-rata kehilangan sekitar 30-40 ml darah selama sekitar 5-7 hari haid. Bila perdarahan melampaui 7 hari atau terlalu deras (melebihi 80 ml), maka dikategorikan menoragia atau menstruasi berat (Marret et al, 2010). Menentukan berapa banyak darah yang dikeluarkan saat haid tentu tidak mudah untuk kalangan awam, namun untuk memudahkan, perhatikanlah indikasi-indikasi tertentu, seperti banyaknya jumlah pembalut yang Anda habiskan atau seringnya darah menembus pakaian Anda karena tidak tertampung oleh pembalut. Menstruasi dianggap berat jika Anda sampai harus mengganti pembalut setiap jam atau setiap beberapa jam berturut- turut. Gejala lain dari menstruasi berlebihan dapat mencakup pendarahan malam hari yang membuat Anda terbangun untuk mengganti pembalut, adanya gumpalan darah besar saat menstruasi, haid berlangsung lebih dari tujuh hari, serta pada kasus yang berat, menstruasi dapat

mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari. Kehilangan darah dari menstruasi berlebihan dapat menyebabkan anemia serta gejala seperti kelelahan dan sesak napas.

I. Penatalaksanaan Masalah Menstruasi

1. Terapi non-farmakologis merupakan pendekatan lini awal untuk mengurangi gejala menstruasi, terutama dismenore dan PMS. Intervensi meliputi kompres hangat, teknik relaksasi, aktivitas fisik ringan, serta edukasi self-management. Pendekatan ini aman, mudah diterapkan, dan berbasis bukti moderat. Asumsi: pasien tanpa indikasi kegawatan atau patologi organik.
 - a. Mekanisme kerja
 - 1) Vasodilatasi lokal meningkatkan aliran darah
 - 2) Relaksasi otot uterus
 - 3) Penurunan iskemia dan nyeri
 - b. Cara penerapan
 - 1) Gunakan suhu $\pm 40\text{--}45^{\circ}\text{C}$
 - 2) Tempelkan pada abdomen bawah selama 15–20 menit
 - 3) Ulangi 2–3 kali/hari sesuai kebutuhan
 - c. Studi menunjukkan efektivitas kompres hangat setara dengan NSAID ringan pada sebagian kasus dismenore
2. Teknik Relaksasi (Progressive Muscle Relaxation / PMR)
PMR adalah teknik mengencangkan lalu melemaskan kelompok otot secara sistematis untuk menurunkan ketegangan.
 - a. Mekanisme
 - 1) Menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis
 - 2) Mengurangi persepsi nyeri
 - 3) Meningkatkan control emosional
 - b. Langkah dasar
 - 1) Posisi nyaman (duduk/berbaring)
 - 2) Tarik napas dalam
 - 3) Tagangkan otot (5–10 detik) lepaskan perlahan
 - 4) Ulangi dari kaki hingga wajah
3. Exercise Ringan dan Yoga
 - a. Jenis Aktivitas
 - 1) Jalan kaki
 - 2) Streching
 - 3) Yoga (child pose, cobra pose, pelvic stretch)

- b. Mekanisme
 - 1) Meningkatkan endorphen (analgesic alami)
 - 2) Menurunkan prostaglandin
 - 3) Memperbaiki sirkulasi darah
- c. Rekomendasi
 - 1) Intensitas ringan-moderat
 - 2) Durasi 20-30 menit, 3-5 kali/minggu
- 4. Edukasi Self-Management

Self-management adalah kemampuan remaja mengelola gejala menstruasi secara mandiri melalui pengetahuan dan keterampilan.

 - a. Komponen edukasi
 - 1) Pemahaman siklus menstruasi
 - 2) Pencatatan siklus (menstrual diary/aplikasi)
 - 3) Identifikasi pemicu nyeri
 - 4) Pola hidup sehat (nutrisi, tidur, hidrasi)
 - b. Strategi Implementasi
 - 1) Edukasi berbasis sekolah
 - 2) Media digital (aplikasi kesehatan)
 - 3) Konseling individu / kelompok
 - 4) Penurunan kecemasan
 - 5) Peningkatan self-efficacy
 - 6) Kepatuhan terhadap perawatan
- 5. Integrasi intervensi

Pendekatan optimal mengombinasikan beberapa metode :

 - a. Kompres hangat, relaksasi, efek analgesic lebih baik
 - b. Exercise, edukasi, stabilisasi jangka panjang
 - c. Pendekatan individu sesuai preferensi remaja
- 6. Terapi Farmakologis

Terapi farmakologis digunakan bila gejala menstruasi (terutama dismenore dan gangguan siklus) tidak terkontrol dengan pendekatan non-farmakologis. Intervensi utama meliputi NSAID dan terapi hormonal (pil kontrasepsi kombinasi/PKK). Bab ini menguraikan mekanisme, indikasi, dosis umum, keamanan, serta kriteria rujukan. Asumsi: pasien remaja tanpa kontraindikasi obat.

 - a. NSAID menghambat enzim siklooksigenase (COX) → menurunkan produksi prostaglandin endometrium → mengurangi kontraksi uterus dan nyeri.
 - b. Terapi Hormonal (Pil Kontrasepsi Kombinasi/PKK)
 - c. Rujukan ke dokter spesialis (obgyn/endokrin) diperlukan

Referensi

- Akin, M. D., et al. (2001). Continuous low-level topical heat therapy. *Obstetrics & Gynecology*, 97(3), 343–349.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Menstruation in girls and adolescents: Using the menstrual cycle as a vital sign*.
- American Academy of Pediatrics. (2015). *Menstrual cycle as a vital sign*.
- Armour, M., et al. (2019). Self-care strategies and psychological interventions for PMS. *BMC Women's Health*, 19(1).
- Baker, F. C., et al. (2018). Sleep and menstrual-related disorders. *Sleep Medicine Reviews*, 40, 14–23.
- De Souza, M. J., et al. (2014). Female athlete triad. *British Journal of Sports Medicine*, 48(4), 289.
- Diaz, A., Laufer, M. R., & Breech, L. L. (2006). Menstruation in girls and adolescents. *Pediatrics*, 118(5), 2245–2250.
- Hickey, M., Balen, A., & Menon, S. (2012). Menstrual disorders in adolescence. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 26(1), 75–88.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). *Wong's Nursing Care of Infants and Children*.
- Kaplowitz, P. (2008). Link between body fat and puberty. *Pediatrics*, 121(Supplement 3), S208–S217.
- Lowdermilk, D. L. (2020). *Maternity & Women's Health Care*.
- Munro, M. G., et al. (2018). The FIGO classification of causes of abnormal uterine bleeding. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*.
- Parent, A. S., et al. (2003). The timing of normal puberty and the age limits of sexual precocity. *Endocrine Reviews*, 24(5), 668–693.
- Proctor, M., & Farquhar, C. (2006). Management of dysmenorrhoea. *BMJ*, 332(7550), 1134–1138.
- Rosenfield, R. L., & Cooke, D. W. (2019). Puberty and its disorders. In *Williams Textbook of Endocrinology*.
- Rubinow, D. R., & Schmidt, P. J. (2019). Sex differences and the neurobiology of mood disorders. *Neuropsychopharmacology*.
- Sumpter, C., & Torondel, B. (2013). A systematic review of menstrual hygiene management. *PLOS ONE*, 8(4).

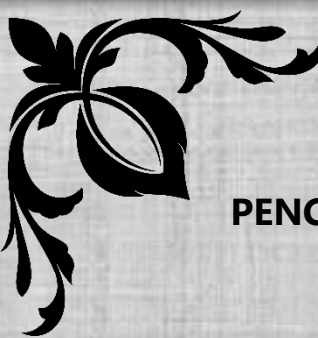
Sommer, M., et al. (2016). A time for global action on menstrual hygiene. *PLOS Medicine*, 13(4).

UNICEF. (2019). *Guidance on menstrual health and hygiene*.

World Health Organization, & UNICEF. (2012). *Consultation on menstrual hygiene management*.

World Health Organization. (2022). *Adolescent health*.

Yonkers, K. A., & Simoni, M. K. (2018). Premenstrual disorders. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 218(1), 68–74.



CHAPTER 4



PENCEGAHAN ANEMIA, MALNUTRISI, DAN PERILAKU BERISIKO PADA REMAJA

Dr. Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., M.K.M.

A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Izzani et al., 2024). Fase remaja ini kebutuhan gizi meningkat secara signifikan untuk mendukung proses pertumbuhan. Asupan gizi yang tidak mencukupi dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan remaja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Fitriani et al., 2024). Problematika gizi pada remaja dewasa ini saat ini telah bergeser dari sekadar masalah kekurangan gizi menjadi beban ganda malnutrisi (double burden of malnutrition), dimana kasus obesitas meningkat pesat sementara masalah stunting dan anemia belum sepenuhnya tuntas sepenuhnya (Fitriyani, 2025).

Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Rematri yang menderita anemia berisiko mengalami anemia pada saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup dan penyebab utama kematian ibu adalah pre-eklampsia dan eklampsia (32,4%) serta perdarahan paska persalinan (20,3%) (Sensus Penduduk, 2010).

Anemia merupakan kondisi medis yang umum di mana darah seseorang kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ketika seseorang terkena anemia, mereka mungkin merasa lelah, lemah, dan sesak napas. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan zat besi, vitamin B12, atau folat; kehilangan darah; dan kerusakan sumsum tulang. Dalam upaya untuk meningkatkan diagnosis awal dan akurasi klasifikasi penyakit anemia. Anemia merupakan salah satu penyakit tidak menular yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin

dibawah normal yang menyebabkan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Kekurangan oksigen mengakibatkan penderita anemia mengalami gejala berupa pucat, letih lesu, pusing atau sakit kepala, dan mata ber kunang-kunang.

Menurut *World Health Organization* (WHO) angka kejadian anemia di seluruh dunia masih tinggi, diperkirakan sebanyak 1,3 milyar penduduk dunia menderita anemia dengan prevalensi sebesar (32,9%). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi anemia pada balita hingga remaja mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni 23,8% pada usia 0-4 tahun, 15,3% pada usia 5-14 tahun, dan 15,5% pada usia 15-24 tahun. Anemia masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Anemia merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan penyelesaian, hal ini dikarenakan kejadian anemia dapat menurunkan produktivitas kerja dan tingkat kesejahteraan hidup keluarga.

Jutaan perempuan usia reproduktif dan anak-anak di bawah usia lima tahun saat ini mungkin mengalami kelelahan, lesu, atau sesak napas akibat anemia. Gejala-gejala yang melemahkan ini mengganggu kesejahteraan dan produktivitas, terutama perempuan, yang pada akhirnya memengaruhi seluruh keluarga, masyarakat, dan negara. Anemia menyebabkan konsekuensi antargenerasi yang buruk, termasuk hasil kehamilan dan kelahiran yang merugikan, risiko kematian dan morbiditas yang lebih tinggi, serta perkembangan kognitif dan motorik yang buruk pada anak-anak. Menurut WHO tahun 2025, perempuan berusia 15–49 tahun mengalami anemia, dan berdasarkan status kehamilannya anemia menjadi salah satu masalah utama. Hanya 18 negara (10% dari seluruh negara) yang menunjukkan kemajuan menuju pencapaian target tersebut, yang mengindikasikan bahwa dunia saat ini masih belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan penurunan anemia sebesar 50% pada tahun 2030..

Pada masa pubertas, tubuh remaja mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga kebutuhan akan zat besi meningkat untuk mendukung produksi sel darah merah. Kekurangan sel darah merah dalam tubuh dapat memicu terjadinya resiko anemia. Beberapa faktor, seperti adanya penyakit infeksi atau non-infeksi juga berperan dalam penyebab anemia. Faktor infeksi umumnya terkait infeksi parasit dan rendahnya asupan energi, protein, zat besi, vitamin C, serta pola makan yang tidak teratur. Sementara itu, faktor non-infeksi meliputi stres, kebiasaan minum teh atau kopi, rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD), pola menstruasi, pola tidur, dan kebiasaan makan. Asupan gizi yang tidak memadai pada remaja dapat menghambat proses hematopoiesis serta sintesis hemoglobin (Hb). Kondisi ini, apabila berlangsung secara berulang, berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan metabolisme, mengganggu produksi hormon maupun sel darah merah, serta mempercepat hemolisis eritrosit. Akibatnya, jumlah eritrosit dalam tubuh menurun dan meningkatkan risiko terjadinya anemia (Sahashika & Setiyaningrum, 2024). Selain itu, anemia juga berdampak pada menurunnya kemampuan darah dalam mengikat serta mendistribusikan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh (Budiarti et al., 2021).

Selain itu, pada masa remaja sesuai dengan Data epidemiologis secara global prevalensi Prevalensi obesitas pada remaja usia 15–19 tahun telah meningkat empat kali lipat sejak tahun 1990. Tahun 2022, tercatat ada sekitar 390 juta anak dan remaja mengalami kelebihan berat badan (overweight), termasuk 160 juta diantaranya yang menderita obesitas (Mulyantoro, 2024). Anemia yang terjadi pada remaja khususnya remaja putri, menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 remaja putri di seluruh dunia mengalami anemia, yang berdampak pada konsentrasi belajar dan kesehatan reproduksi di masa depan (Prastiwi et al., 2024). Selain permasalahan gizi pada remaja yang cukup menjadi perhatian secara global, kesehatan reproduksi remaja juga menjadi tantangan besar dalam kesehatan masyarakat. WHO, mencatat hampir 43% remaja putri yang ingin menunda kehamilan tidak memiliki akses ke alat kontrasepsi modern (unmet need) dan secara global, remaja dengan rentang usia 15–24 tahun menyumbang hampir setengah dari kasus baru infeksi menular seksual (IMS) setiap tahunnya (Dehne & Riedner, 2005). Mengacu data secara global, Indonesia dihadapkan pada tiga masalah gizi sekaligus, yakni: (1) Prevalensi anemia pada remaja Indonesia masih berkisar di angka 32% (hampir 1 dari 3 remaja).

Hal ini didominasi oleh asupan zat besi yang rendah dan pola makan yang kurang beragam. (2) Stunting: Meskipun tren stunting nasional turun menjadi 19,8% pada tahun 2024, angka ini masih diatas batas toleransi WHO (20%) (Nasruddin et al., 2021). Remaja yang stunting berisiko melahirkan bayi stunting pula di masa depan, dan (3) Kelebihan Berat Badan & Obesitas, menunjukkan data tren obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun dan remaja terus meningkat akibat konsumsi makanan olahan, minuman berpemanis, dan kurangnya aktivitas fisik (Mokodompit et al., 2025). Pada data kasus kesehatan reproduksi, data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan bawa adanya peningkatan persentase remaja yang mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah dan terdapat 8- 9% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan di usia ini meningkatkan risiko komplikasi persalinan karena panggul yang belum berkembang sempurna (Syafitriani et al., 2022). Permasalahan gizi dan kesehatan reproduksi yang di terjadi pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor yang sering dijumpai adalah kekurangan zat besi (Anemia) dan gangguan menstruasi (Natasya Dewinta Oktafiani et al., 2026).

Pada remaja, kebutuhan zat besi meningkat seiring dengan pertumbuhan, ditambah dengan adanya kehilangan darah saat menstruasi pada remaja putri. Kondisi ini menyebabkan remaja putri menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap anemia (Putri & Fauzia, 2022). Secara fisik, anemia dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, lemah, pusing, serta menurunnya daya tahan tubuh. Selain itu, anemia juga dapat memengaruhi kemampuan kognitif, seperti konsentrasi dan daya ingat, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi belajar di sekolah. Secara jangka panjang anemia yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Nurhaliza, 2024).

B. Anemia dan Malnutrisi pada Remaja

Remaja merupakan masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, dengan rentang usia 10-19 tahun (WHO, 2018). Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja diartikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun (Kemenkes RI, 2014), sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2016) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa dan disertai pertumbuhan fisik, kognitif, dan psiko sosial atau tingkah laku. Pada masa remaja ini banyak terjadinya perubahan karena bertambahnya massa otot dan jaringan lemak dalam tubuh juga terjadi perubahan hormonal, hal tersebut yang memengaruhi kebutuhan gizi dan makanan remaja (Adriani and Bambang Wirjatmadi 2012).

Anemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari nilai normal sehingga mengakibatkan terganggunya distribusi oksigen keseluruh tubuh (Ahmad Zaki, 2023). Berdasarkan World Health Organization (WHO), anemia pada remaja putri didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 12 g/dL (Helmyati et al., 2023). Anemia pada remaja putri sering disebabkan oleh defisiensi zat besi, kehilangan darah akibat menstruasi atau asupan zat besi yang tidak mencukupi melalui pola makan dimana gejala anemia meliputi kelelahan, pusing, konsentrasi menurun dan pucat (Aspihani, et al., 2023).

Klasifikasi anemia dibagi menjadi beberapa kelompok menurut umur, dapat dikategorikan menjadi tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat (Uswatun, Prastiwi, 2021).

Tabel 4. 1 Kalsifikasi Anemia berdasarkan umur

Polulasi	Non Anemia	Anemia		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak 6-59 Bulan	11	10.0-10.9	7.0-9.9	<7.0
Anak 5-11 Tahun	11.5	11.0-11.4	8.0-10.9	<8.0
Anak 12-14 tahun	12	11.0-11.9	8.0-10.9	<8.0
Perempuan tidak hami (>15 Tahun)	12	11.0-11.9	8.0-10.9	<8.0
Anak Laki-laki >15 tahun	13	11.0-12.9	8.0-10.9	<8.0
Ibu hamil	11	10.0-10.9	7.0-9.9	<7.0

Klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya (Uswatun, Prastiwi, 2021) yaitu :

1. Anemia defisiensi besi

Anemia karena kekurangan zat besi adalah tipe anemia yang paling umum di seluruh dunia. Keadaan ini ditandai dengan kadar hemoglobin yang rendah dan sel darah merah yang mikrositik akibat pasokan zat besi yang tidak mencukupi dalam tubuh. Keterbatasan zat besi berdampak negatif pada pembentukan hemoglobin, sehingga konsentrasi hemoglobin dalam sel darah merah menurun. Hal ini menyebabkan pengangkutan oksigen menjadi tidak cukup efisien ke seluruh jaringan tubuh. Dalam kondisi normal kebutuhan zat besi untuk orang dewasa berkisar antara 2-4 gram, dan absorpsi zat besi terjadi di lambung, duodenum, dan bagian atas jejunum.

Zat besi masuk ke tubuh melalui makanan dan penting untuk tubuh sebagai bagian dari hemoglobin, myoglobin, dan enzim lain. Zat besi berfungsi sebagai transportasi dalam bentuk transferrin yang disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin. Zat besi dari makanan berubah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap dalam kondisi asam. Setelah diserap, berikatan dengan protein untuk membentuk ferritin, dalam bentuk transportasi zat besi berikatan dengan protein untuk membentuk transferrin, yang juga dikenal sebagai serotransferrin dalam plasma darah.

2. Anemia Megaloblastik

Anemia yang disebabkan oleh kerusakan sintesis DNA mengganggu pembentukan sel darah merah, biasanya karena kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Ciri khasnya adalah adanya megaloblast yaitu sel darah merah yang besar dan belum matang. Gejala anemia megaloblastik termasuk rendahnya kadar hemoglobin, ikterus, glossitis, dan gangguan neurologis akibat kekurangan vitamin B12.

3. Anemia defisiensi vitamin B12

Masalah autoimun yang terjadi karena kurangnya intrinsic factor (IF) yang dibuat oleh sel parietal di lambung, akibatnya mengganggu penyerapan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dan asam folat menghalangi pembentukan DNA yang dibutuhkan untuk sel, termasuk sel darah merah yang dapat memengaruhi ukuran, jumlah dan fungsi sel darah merah. Intrinsic factor membantu penyerapan vitamin B12 di ileum dan vitamin B12 penting untuk pembentukan myelin pada sel saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan berbagai masalah pada saraf.

4. Anemia defisiensi asam folat

Kebutuhan folat biasanya kecil dan sering dialami oleh orang yang kurang mengonsumsi sayuran dan buah-buahan atau yang punya masalah pencernaan. Defisiensi asam folat bisa terjadi karena sindrom malabsorpsi. Gejala mirip dengan defisiensi vitamin B12, seperti gangguan neurologis, perubahan kepribadian, dan masalah ingatan. Selain itu, bisa juga disertai ketidakseimbangan elektrolit seperti magnesium dan kalsium. Kadar asam folat biasanya kurang dari 3-4 ng/ml, sedangkan kadar vitamin B12 tetap normal.

5. Anemia aplastik

Kondisi ini terjadi akibat ketidakmampuan sumsum tulang dalam memproduksi sel-sel darah. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kerusakan primer pada sistem sel yang mengakibatkan anemia, leukopenia, dan trombositopenia, yang dikenal sebagai pansitopenia. Zat yang dapat merusak sumsum tulang disebut mielotoksin, yang sering kali disebabkan oleh kemoterapi dan radioterapi. Situasi ini banyak dialami oleh pasien yang menderita hepatitis, HIV, dan tuberkulosis.

Masalah anemia yang paling sering dijumpai pada remaja putri adalah anemia gizi besi. Anemia merupakan kondisi dimana jumlah sel darah merah atau hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 12 g/dL. Anemia gizi besi timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel - sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu (Adriani and Bambang Wirjatmadi 2012). Kejadian anemia gizi besi erat kaitannya dengan status gizi remaja. Status gizi merupakan faktor pada level individu yang dipengaruhi secara langsung oleh jumlah dan jenis asupan makanan yang dikonsumsi serta kondisi infeksi yang dialami seseorang. Status gizi juga menggambarkan keadaan fisik individu yang ditentukan melalui satu atau kombinasi indikator gizi tertentu (Supriasa et al., 2016). Remaja putri dengan status gizi kurang cenderung memiliki asupan zat besi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga berisiko lebih tinggi mengalami anemia. Sebaliknya, status gizi yang baik mencerminkan terpenuhinya kebutuhan zat gizi, termasuk zat besi, yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dan pencegahan anemia.

Status gizi dapat diketahui melalui pengukuran beberapa parameter, kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau rujukan. Peran penilaian status gizi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya status gizi yang salah. Penilaian status gizi menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait dengan status gizi. Oleh karena itu dengan diketahuinya status gizi, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Status gizi seseorang tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya, jika antara asupan gizi dengan kebutuhan tubuhnya seimbang, maka akan menghasilkan status gizi baik. Kebutuhan asupan gizi setiap individu berbeda antarindividu, hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan (Wiyono&Harjatmo, 2017).

Selain anemia, Adapun masalah gizi pada remaja yaitu :

1. Gangguan Makan

Ada dua macam gangguan makan yang biasa terjadi pada remaja yaitu bulimia nervosa dan anoreksia. Kedua gangguan ini biasanya terjadi karena obsesi untuk membentuk tubuh langsing dengan cara menguruskan badan. Ciri-ciri seseorang dengan gangguan makan ini antara lain sangat mengontrol asupan makannya, kehilangan berat badan secara drastis tetapi tetap melarang dirinya untuk mengkonsumsi makanan berat, tidak menstruasi selama beberapa bulan karena gangguan hormonal.

2. Obesitas

Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Aktif berolah raga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi, dengan demikian dapat membantu menurunkan berat badan, di samping itu serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makanan atau kue-kue

3. Kurang Energi Kronis (KEK)

Pada remaja badan kurus atau disebut Kurang Energi Kronis tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olah raga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk seperti ibunya atau dipandang lawan jenis kurang seksi.

Penilaian status gizi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penilaian status gizi secara langsung dan tidak langsung (Supariasa,dkk.,2012).

a. Penilaian status gizi secara langsung

1) Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidak seimbangan asupan protein dan energi. Ketidak seimbangan ini dapat dilihat melalui pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. Untuk menilai status gizi remaja dapat digunakan pengukuran antropometri selanjutnya menggunakan indeks IMT/U. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks IMT/U seperti pada Tabel.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan IMT/U

Indeks		Kategori Gizi	Status	Ambang Batas (<i>Z score</i>)
Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 5-18 Tahun		Gizi	Buruk	< - 3 SD
		<i>(severely thinness)</i>		
		Gizi	Kurang	-3 SD sd <-2 SD
		<i>(thinness)</i>		
		Gizi	Baik	-2 SD sd +1 SD
		<i>(Normal)</i>		
		Gizi	Lebih	+1 SD sd +2 SD
		<i>(overweight)</i>		
		Obesitas (<i>obese</i>)		> +2 SD

2) Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidak cukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (*supervicial epithelial tissue*) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk survey klinis secara cepat (*rapid clinical surveys*). Survey ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu pula digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan gejala (symptom) atau riwayat penyakit.

3) Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja, juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan sebagai suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.

4) Biofisik

Metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi(khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian rabun senja epidemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung

1) Survey konsumsi makanan

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survey ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

2) Statistik vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

c. Faktor ekologi

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dll. Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Supariasa, dkk, 2012).

C. Dampak Anemia dan Malnutrisi terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja

Saat kehilangan darah tubuh perlu memproduksi sel darah merah lebih banyak, sehingga kebutuhan zat besi juga ikut meningkat. Anemia pada remaja memiliki dampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi hingga prestasi belajar, kebugaran remaja dan produktivitas pada remaja. Secara khusus bila anemia tidak ditangani akan berdampak lebih serius, mengingat remaja putri adalah para calon ibu yang melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar risiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur dan berat bayi lahir rendah (Kemenkes RI, 2018).

Anemia pada remaja putri dapat berdampak negatif terhadap:(Galloway, 2023)

1. Perkembangan Kognitif: Kekurangan oksigen ke otak dapat menghambat konsentrasi dan kemampuan belajar.
2. Produktivitas: Penurunan energi dan daya tahan fisik mengurangi partisipasi dalam kegiatan sehari-hari.
3. Kesehatan Reproduksi: Anemia dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan di masa depan, seperti kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah.

Dampak jangka pendek remaja putri yang mengalami anemia menimbulkan keterlambatan pertumbuhan fisik maturitas seksual dapat tertunda. Dampak dari anemia ini mungkin tidak langsung terlihat, namun dapat berlangsung lama dan dapat mempengaruhi kehidupan remaja selanjutnya (Yunita et al., 2020). Sedangkan dampak jangka panjang anemia remaja putri adalah pada saat menjadi seorang Ibu seperti memperbesar Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan, kelahiran bayi prematur dan menyebabkan bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Status gizi pada remaja putri ini sangat penting untuk kesehatan, keselamatan baik saat kehamilan maupun persalinan (A. D. A. Dewi et al., 2022).

Anemia dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas hidup terkait kesehatan pada remaja putri dengan mempengaruhi aspek hormonal, tingkat ketahanan fisik, kondisi psikologis dan emosional. Dampak anemia pada remaja terutama yang berkaitan dengan kualitas hidup terkait kesehatan masih belum banyak ditelaah. Berbagai studi anemia pada remaja masih berfokus pada penurunan fungsi kognitif. Tujuan penulisan artikel ini untuk menyampaikan perspektif yang lebih baik tentang anemia dan dampaknya terhadap kualitas hidup terkait kesehatan khususnya aspek fisik dan psikologis pada populasi remaja sehingga tindakan preventif terhadap anemia pada remaja dapat terus ditingkatkan serta dioptimalkan.

Remaja putri termasuk salah satu kelompok yang rawan menderita malnutrisi. Menstruasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan malnutrisi, karena selama

menstruasi darah akan terus keluar sehingga membutuhkan asupan zat gizi terutama besi untuk membantu produksi hemoglobin pada tubuh. Status gizi pada remaja merupakan pantulan dari permulaan kejadian kekurangan gizi pada anak usia dini. Negara dengan penghasilan menengah, remaja merupakan masa penurunan malnutrisi dari anak usia dini, baik itu *stunting* atau anemia sebelumnya yang disebabkan oleh defisiensi mikronutrien (Thurnham et al, 2013). Defisiensi besi mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan remaja, dengan menghambat pertumbuhan linier (Caulfield et al, 2006). Stunting pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau pra-sekolah. Malnutrisi yang terjadi pada masa balita yang mengindikasikan stunting, akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan remaja terhambat. Dampak jangka panjang dari stunting pada kesehatan remaja putri adalah berupa perawakan tubuh pendek, peningkatan resiko obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi, sedangkan dampak pada hal perkembangan ialah penurunan prestasi dan kapasitas belajar, serta penurunan kemampuan dan kapasitas kerja (WHO, 2013).

Upaya untuk menanggulangi terjadinya anemia pada remaja putri dapat difokuskan pada kegiatan promosi dan pencegahan meliputi: peningkatan makanan kaya zat besi, suplemen penambah darah serta peningkatan fortifikasi bahan pangan dengan zat besi dan asam folat. Suplemen penambah darah pada remaja putri merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi asupan zat besi (Puspitasari et al., 2022).

D. Strategi Pencegahan Anemia dan Malnutrisi pada Remaja

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan mengalami anemia dan malnutrisi akibat peningkatan kebutuhan zat gizi seiring pertumbuhan fisik dan perkembangan psikososial. Menurut World Health Organization (WHO), anemia pada remaja, terutama remaja putri, menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di negara berkembang, termasuk Indonesia (WHO, 2021). Selain itu, malnutrisi dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan gizi dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas generasi mendatang (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Strategi pencegahannya bisa dilakukan dengan:

1. Edukasi dan Promosi Gizi Seimbang

Peningkatan pengetahuan remaja mengenai pentingnya gizi seimbang menjadi langkah utama dalam pencegahan anemia dan malnutrisi. Program edukasi gizi yang terintegrasi di sekolah dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi makanan bergizi. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan zat besi, protein, vitamin, dan mineral lain yang

esensial untuk pertumbuhan (Kemenkes RI, 2022). Melalui pelajaran formal seperti pendidikan kesehatan atau biologi, siswa dapat memperoleh informasi tentang pentingnya zat gizi makro dan mikro, khususnya zat besi, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, edukasi informal dapat diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seminar, lomba, atau kampanye hari gizi nasional.

Penyuluhan di Komunitas seperti posyandu remaja, karang taruna, dan organisasi kepemudaan, juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi gizi. Penyuluhan dapat dilakukan menggunakan berbagai media, seperti leaflet, poster, atau media sosial yang dekat dengan kehidupan remaja. Melalui pendekatan komunitas, edukasi gizi menjadi lebih mudah diterima dan dipahami karena disampaikan dalam bahasa dan konteks yang sesuai dengan keseharian remaja. Materi edukasi harus mencakup pentingnya konsumsi makanan sumber zat besi (daging, hati, ikan, sayuran hijau), protein, vitamin C (untuk meningkatkan penyerapan zat besi), serta risiko dari konsumsi makanan instan, tinggi gula, dan rendah zat gizi. Metode edukasi yang interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, serta pemanfaatan media digital (infografis, video pendek, aplikasi edukasi gizi), terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat remaja.

2. Peningkatan Akses dan Konsumsi Pangan Bergizi

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat utama agar remaja dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu memastikan distribusi pangan bergizi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sumber protein hewani (daging, ikan, telur), serta pangan pokok, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, keterjangkauan harga pangan bergizi juga harus diupayakan, misalnya melalui subsidi pangan atau program bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu (Allen et al., 2017).

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi seperti sayuran hijau, buah-buahan, daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan. Pemilihan makanan kaya zat besi (heme dan non-heme) serta kombinasi dengan sumber vitamin C penting untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Selain itu, membatasi konsumsi makanan olahan tinggi gula dan lemak juga perlu ditekankan (Soekatri, 2020). Remaja perlu didorong untuk mengonsumsi beragam jenis makanan guna memastikan kecukupan seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan memperkenalkan berbagai sumber zat besi (baik heme maupun non-heme), protein nabati dan hewani, serta vitamin dan mineral. Konsumsi pangan lokal yang kaya gizi, seperti tempe, tahu, ikan air tawar, serta sayur dan buah musiman,

juga mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus memperkaya variasi asupan (Soekatri, 2020).

Pola konsumsi pangan remaja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pilihan makanan di lingkungan sekolah dan rumah. Penyediaan kantin sehat di sekolah, pembiasaan membawa bekal bergizi, serta edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menyediakan makanan sehat dalam rumah tangga terbukti efektif meningkatkan konsumsi pangan bergizi pada remaja (UNICEF, 2019). Selain mendorong konsumsi pangan bergizi, penting juga untuk membatasi asupan makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, serta minuman berpemanis yang sering menjadi pilihan remaja. Konsumsi makanan cepat saji dan jajanan yang rendah nilai gizi berkontribusi terhadap risiko malnutrisi dan anemia (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Fortifikasi dan Suplementasi

Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi kedalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan pada industri pangan, untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi. Makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia antara lain tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Zat besi dan vitamin mineral lain juga dapat ditambahkan dalam makanan yang disajikan di rumah tangga dengan bubuk tabur gizi atau dikenal juga dengan *Multiple Micronutrient Powder*. Fortifikasi bahan pangan seperti tepung terigu dan beras dengan zat besi dan mikronutrien lain terbukti efektif menurunkan prevalensi anemia di berbagai negara (Allen et al., 2017). Suplementasi zat besi rutin, terutama pada remaja putri, direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui program Tablet Tambah Darah (TTD) mingguan di sekolah.

4. Deteksi Dini dan Penanganan Kasus

Pelaksanaan skrining berkala yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), serta pemeriksaan kadar hemoglobin memberikan gambaran status gizi dan risiko anemia pada remaja. Data yang diperoleh dari skrining ini sangat penting untuk pemetaan status kesehatan siswa secara menyeluruh dan sebagai dasar perencanaan intervensi yang tepat sasaran (UNICEF, 2019). Skrining status gizi dan anemia secara berkala di sekolah memungkinkan deteksi dini kasus malnutrisi dan anemia. Remaja yang teridentifikasi mengalami masalah gizi dapat segera diberikan intervensi yang tepat, baik berupa rujukan ke fasilitas kesehatan maupun pendampingan gizi (Kemenkes RI, 2021).

Remaja yang teridentifikasi mengalami anemia atau malnutrisi melalui hasil skrining selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan masalah gizinya. Klasifikasi ini bertujuan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu, baik untuk kasus ringan (misalnya, edukasi dan pemantauan) maupun kasus sedang hingga berat (rujukan ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut) (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Keberhasilan deteksi dini dan penanganan kasus sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan (petugas puskesmas, dokter, ahli gizi), serta pemerintah daerah. Sistem rujukan yang jelas dan pelatihan bagi guru serta petugas kesehatan sekolah akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan skrining dan intervensi (WHO, 2021).

5. Pemberdayaan Lingkungan dan Keluarga

Pemberdayaan lingkungan dan keluarga memegang peranan sentral dalam upaya pencegahan anemia dan malnutrisi pada remaja. Lingkungan keluarga merupakan fondasi pertama pembentukan pola makan dan gaya hidup sehat yang akan terbawa hingga dewasa. Keterlibatan aktif orang tua sangat menentukan kecukupan asupan gizi, penerapan perilaku hidup bersih, dan pembentukan kebiasaan makan sehat pada anak-anak dan remaja (UNICEF, 2019). Peran keluarga dalam Pe Peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting untuk membentuk pola makan dan gaya hidup sehat. Keterlibatan orang tua dalam menyediakan makanan bergizi dan mendorong perilaku hidup bersih menjadi faktor penunjang keberhasilan pencegahan anemia dan malnutrisi (UNICEF, 2019).

Keluarga, khususnya orang tua, berperan dalam menentukan jenis, kualitas, dan variasi makanan yang tersedia di rumah. Dengan menyediakan makanan yang bergizi seimbang—mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral—orang tua memberikan contoh nyata bagi anak-anak dalam memilih makanan yang tepat. Pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi remaja juga penting untuk mencegah kekurangan zat besi dan mikronutrien lain yang berperan dalam pembentukan hemoglobin dan pertumbuhan optimal. Selain keluarga, lingkungan sekitar seperti sekolah, komunitas, dan media massa juga sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan makan sehat. Lingkungan yang mendukung penerapan pola hidup bersih, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang memadai, akan membantu mencegah infeksi yang bisa memperburuk status gizi remaja (WHO, 2021). Komunitas dapat berperan dalam mengedukasi dan mengajak seluruh anggotanya untuk menjalankan pola makan sehat melalui kampanye kesehatan, demo masak sehat, serta kegiatan sosial lainnya.

E. Deteksi Dini dan Penanganan Anemia serta Malnutrisi

Deteksi dini anemia merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi kondisi anemia sebelum gejala parah muncul. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan kadar hemoglobin, riwayat pola makan, serta pengamatan gejala klinis seperti lemah, pucat, atau pusing. Anemia sendiri adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang dapat disebabkan oleh defisiensi zat besi, penyakit kronis, atau faktor genetik tertentu (Katsumi et al., 2021). Pemeriksaan hemoglobin dengan alat sederhana maupun analisis hematologi lengkap terbukti efektif dalam mendeteksi anemia sejak dini, termasuk pemeriksaan volume retikulosit yang berperan dalam diagnosis anemia terkait kanker (Lin et al., 2024)

Selain pemeriksaan laboratorium, indikator antropometrik juga dapat membantu mengidentifikasi risiko anemia, khususnya pada kelompok usia muda. Pengukuran indeks massa tubuh dan lingkar lengan atas dapat menjadi prediktor awal terhadap potensi anemia (Dutta et al., 2021). Deteksi dini ini juga penting pada ibu hamil karena anemia maternal yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan komplikasi lain. Dengan demikian, deteksi dini anemia memiliki dampak luas, tidak hanya menjaga kesehatan individu tetapi juga berperan dalam pencegahan komplikasi kesehatan masyarakat. (Khan et al., 2024) Hemoglobin sebagai protein utama dalam sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru (Ataga et al., 2020). Pada kondisi anemia, kadar hemoglobin menurun sehingga pasokan oksigen berkurang dan memunculkan gejala seperti pucat, kuku rapuh, dan kelelahan (Hornedo- González et al., 2023). Pemeriksaan hemoglobin dapat dilakukan secara invasif maupun noninvasif untuk meningkatkan akurasi deteksi (Young et al., 2021). Penanganan anemia terkait kadar hemoglobin rendah meliputi suplementasi zat besi, perbaikan pola makan, hingga terapi medis sesuai penyebab (Manandhar, 2018).

Menurut Deivita, dkk (2021), perlu adanya upaya skrining sejak awal guna mengenali sedini mungkin munculnya anemia dan menyampaikan informasi tentang anemia untuk seluruh golongan remaja putri. Mengingat hal tersebut sangat urgen mencari jalan keluar yang tepat menangani anemia. Salah satu yang ditawarkan adalah deteksi dini agar dapat dilakukan pencegahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan deteksi dini anemia pada remaja. Penanggulangan anemia pada remaja putri dan WUS wajib dilaksanakan beriringan dengan pencegahan dan penanganan beberapa penyakit seperti Kurang Energi Kronik (KEK), kecacingan, malaria, tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.

F. Perilaku Berisiko Pada Remaja

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung melakukan eksplorasi diri, termasuk mencoba berbagai perilaku baru, baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu isu penting yang sering muncul pada masa ini adalah perilaku berisiko, yaitu perilaku yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, maupun sosial remaja.

Ketertarikan remaja terhadap pengalaman baru merupakan fenomena yang wajar dan esensial dalam tahapan perkembangan psikososial mereka. Dorongan untuk bereksplorasi dan melampaui batasan sebelumnya dianggap sebagai proses adaptif yang mendukung pembentukan kemandirian serta identitas diri remaja (Steinberg, 2014). Melalui proses ini, remaja belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya, yang pada akhirnya membentuk kemampuan mereka untuk menjadi individu dewasa yang mandiri. Namun demikian, kecenderungan untuk mencari sensasi dan pengalaman baru juga dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku yang berisiko, yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya (WHO, 2021). Situasi ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, meskipun penting untuk dipahami bahwa dorongan menuju kemandirian dan otonomi merupakan bagian dari perkembangan yang sehat pada masa remaja.

Sebagaimana disampaikan oleh psikolog remaja Dr. Lisa Damour, peran orang tua sangat penting dalam mendampingi remaja melewati fase ini. Orang tua diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada remaja untuk bertumbuh dan bereksplorasi, dengan tetap memastikan adanya batasan dan pengawasan yang memadai agar remaja tetap aman dalam mengeksplorasi pengalaman (Unisef, 2019). Menurut World Health Organization (WHO), perilaku berisiko pada remaja adalah segala bentuk perilaku yang meningkatkan kemungkinan individu mengalami masalah kesehatan atau sosial di masa mendatang (WHO, 2021).

1. Jenis-jenis Perilaku Berisiko pada Remaja

a. Konsumsi Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan senyawa yang umumnya ditemukan dalam makanan, minuman, atau obat-obatan. Penggunaan zat adiktif secara berulang dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi), di mana seseorang akan merasa tidak nyaman jika tidak mengonsumsi zat tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Ketidaknyamanan ini dapat muncul dalam bentuk gejala ringan seperti sakit kepala, atau bahkan gangguan yang lebih berat

seperti rasa nyeri di seluruh tubuh atau gangguan pada kondisi mental. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, zat adiktif dan psikotropika dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan efek yang ditimbulkannya pada tubuh.

b. Perilaku Seksual Berisiko

Perilaku seksual berisiko adalah segala bentuk aktivitas seksual yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi pelakunya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada kejadian perilaku seksual berisiko pada remaja adalah kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan psikologis, dan penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditularkan melalui hubungan seksual baik melalui vagina, oral, maupun anus (Kesehatan Saintika Meditory et al., 2024). Sedangkan perilaku seksual lainnya menurut Kemenkes RI (2022), perilaku seksual berisiko adalah perilaku seksual yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi mencakup perilaku seksual pranikah yang dapat berdampak pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan perilaku berisiko tertular infeksi menular seksual (IMS) hingga seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan merangsang pasangannya. Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap gangguan dari luar namun respon yang diberikan tergantung dari karakteristik atau faktor-faktor yang orang tersebut. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku manusia yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Sedangkan perilaku seksual dikatakan berisiko apabila perilaku tersebut membawa akibat yang tidak diinginkan seperti tindakan aborsi, hamil diluar nikah, penyakit menular seksual (PMS), dan HIV/AIDS. Menurut Maulana (2020) perilaku seksual remaja berdistribusi berisiko kurang dari setengahnya 37,3% dan tidak berisiko lebih dari setengahnya yaitu 62,7% (Purnama, Sriati and Maulana, 2020).

Klasifikasi perilaku seksual berisiko yaitu:

1) Masturbasi

Masturbasi adalah menyentuh, menggosok, dan meraba bagian tubuh sehingga mendapat kepuasan seksual, baik menggunakan alat atau tidak. Masturbasi dilakukan pada bagian tubuh yang sensitif seperti pada puting payudara, paha dalam maupun pada bagian klitoris atau dengan meraba penis sehingga timbul ejakulasi.

2) Onani

Onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun, istilah onani hanya diperuntukkan oleh pria, sedangkan masturbasi untuk pria dan wanita. Onani dilakukan dengan cara membayangkan hal-hal erotis dan

mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif sehingga menimbulkan kenikmatan.

3) Bercumbu berat (*petting*)

Bercumbu berat adalah melakukan hubungan seksual dengan atau tanpa pakaian tetapi tanpa melakukan penetrasi penis ke vagina, sebatas menggesekkan penis ke alat kelamin wanita.

4) Hubungan seksual

Merupakan masuknya penis ke dalam vagina. Bila terjadi ejakulasi (pengeluaran cairan semen yang di dalamnya terdapat jutaan sperma) dengan posisi alat kelamin pria berada dalam vagina memudahkan pertemuan sperma dan sel telur yang menyebabkan terjadinya pembuahan dan kehamilan.

c. Kekerasan

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah. Kita sering mendengar terjadinya kasus kekerasan terjadi di sekolah. Masa orientasi sekolah, training, dan latihan dasar kepemimpinan sering digunakan sebagai wahana untuk melakukan bullying. Tak jarang kasus kekerasan juga terjadi pada saat pertemanan. Bullying menjadi persoalan yang penting yang harus ditangani secara serius. Sebenarnya kekerasan merupakan masalah yang klasik, berkesinambungan dan kompleks. Bullying terjadi hampir di segala aspek kehidupan baik keluarga, sekolah, masyarakat dan dunia kerja. Perilaku kekerasan atau bullying termasuk tindakan yang sengaja dilakukan pelaku pada korbannya, yang bertujuan untuk mengganggu orang yang lebih lemah darinya. Kurangnya pengetahuan juga merupakan salah satu faktor individu yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku kekerasan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan remaja tentang perilaku bullying maka akan dapat meminimalkan terjadinya perilaku bullying di kalangan siswa. selain bullying kekerasan lainnya yang terjadi seperti kekerasan seksual.

Remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena remaja masih membutuhkan konsep diri sebagai acuan dalam menumbuhkan jati diri. Remaja mempunyai tahapan tumbuh kembang sebagai bagian selanjutnya dari masa hidup sebagai anak-anak menuju dewasa. Secara umumnya (Tisngati et al., 2021) umur seorang remaja ialah 12-

21 tahun untuk perempuan dan lelaki ialah sekitar 13-22 tahun. Umumnya pada masa remaja seseorang akan memperlihatkan sifat yang sangat berbeda dari waktu anak-anak. Hal inilah yang membuat remaja dalam proses pencarian jati diri biasanya salah dalam memposisikan diri atau bahkan pergaulan yang salah menyebabkan remaja tersebut bisa terjerumur pada hal yang bersifat seksual hingga terjadi kekerasan pada remaja yang mana inilah awal dari terjadinya Human trafficking. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti teman sebaya dan lain-lain. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap remaja. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada remaja baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan begitu sering terjadi dalam waktu sehari-hari baik pada tempat keluarga, masyarakat bahkan teman sendiri. Kekerasan pada pandangan yang lebih menyeluruh sering terjadi pada seseorang yang lemah fisiknya. Seringnya berita kekerasan yang terjadi bagi perempuan atau remaja menjadi suatu topik yang sangat bagi perempuan yang mempunyai suatu pekerjaan di luar meskipun begitu tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang bekerja dekat keluarga atau tempat tinggalnya mungkin juga mengalami hal yang sama (Nurfaizah et al., 2023).

d. Perilaku Membahayakan Diri

Perilaku membahayakan diri atau self-harm pada remaja merupakan fenomena kompleks yang dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori. Salah satu teori utama adalah teori regulasi emosi (emotion regulation theory), yang menyatakan bahwa perilaku ini merupakan upaya maladaptif remaja untuk mengatasi atau meredakan emosi negatif yang intens, seperti kemarahan, kecemasan, atau kesedihan yang sulit diungkapkan secara verbal. Dengan melakukan self-harm, remaja berusaha memperoleh kelegaan sementara dari tekanan emosi yang dialaminya (Nock, 2009).

G. Simpulan

Masa remaja merupakan periode kritis dalam siklus kehidupan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat dinamis. Pada fase ini, remaja menghadapi tantangan kebutuhan zat gizi yang meningkat akibat

pertumbuhan pesat serta berbagai tekanan lingkungan yang dapat mendorong munculnya perilaku berisiko.

Anemia dan malnutrisi masih menjadi masalah kesehatan utama pada remaja, khususnya remaja putri. Anemia, terutama akibat defisiensi zat besi, berdampak buruk terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, kesehatan reproduksi, serta kualitas hidup remaja secara keseluruhan. Malnutrisi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti stunting, obesitas, dan gangguan makan. Penilaian status gizi penting dilakukan secara berkala agar upaya deteksi dini dan intervensi dapat dioptimalkan.

Perilaku berisiko pada remaja, seperti konsumsi zat adiktif, perilaku seksual berisiko, kekerasan, self-harm, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan penggunaan teknologi berlebihan, merupakan bentuk eksplorasi diri yang wajar namun dapat berdampak negatif bila tidak dikelola dengan baik. Faktor individu, keluarga, lingkungan, dan media sangat mempengaruhi munculnya perilaku tersebut.

Oleh karena itu, upaya pencegahan anemia, malnutrisi, dan perilaku berisiko pada remaja harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, promosi gizi seimbang, peningkatan akses pangan bergizi, fortifikasi dan suplementasi, deteksi dini, serta pemberdayaan keluarga dan lingkungan. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan remaja tumbuh sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan.

Referensi

- Dewi, A. D. A., Fauzia, F. R., & Astuti, T. D. (2022). Asupan Zat Besi, Vitamin C, Pengetahuan Gizi Kaitannya dengan Kejadian Anemia Remaja Putri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Amerta Nutrition*, 6(1SP), 291–297. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1sp.2022.291-297>
- Yunita, F. A., Parwatiningsih, S. A., Hardiningsih, M., Nurma Yuneta, A. E., Kartikasari, M. N. D., & Ropitasari, M. (2020). The Relationship between Young Women 's Knowledge About Iron Consumption and The Incidence of Anemia in Junior High School 18 Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 8(1), 36. <https://jurnal.uns.ac.id/placentum/article/view/38632/26838>
- Puspitasari, H. Z. G., Armini, N. K. A., Pradanie, R., & Triharini, M. (2022). Anemia prevention behavior in female adolescents and related factors based on Theory of Planned Behavior: A cross-sectional study. *Jurnal Ners*, 17(1), 25–30. <https://doi.org/10.20473/jn.v17i1.27744>
- Priliani L, Harahap AR, Satyagraha AW, Noviyanti R, Apriyana I, Nanine IS, et al. Mapping anemia prevalence across Indonesia. *Asia Pac J Clin Nutr* [Internet]. 2025;34(3):430–9. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12126302/>
- Soekatri, M. Y. E. (2020). Status Gizi Remaja dan Faktor yang Mempengaruhi. *Gizi Indonesia*, 43(1), 53-60.
- Dwi Sarwani Srirejeki, dkk. 2024. *Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Anemia pada Petani di Desa Linggasari Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Asmin E., Salulinggi A., Titaley CR., Bension J. *Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Konsumsi Tablet Tambah Darah dengan Kejadian Anemia di Kecamatan Leitimur Selatan dan Teluk Ambon*. *J Epidemiol Kesehat Komunitas*. 2021;6(1) : 229-36.
- Harahap NR. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri*. *Nurs Arts*. 2018;12(2):78-90.
- World Health Organization. 2020. *Global Anemia Report*. Geneva : WHO Press.
- Smith, J., & Zhang, L. 2021. *Epidemiology of Anemia and Its Impact on Global Health*. *Journal of Medical Science*, 25(3), 456-468.
- K. Wardhani, dkk. *Perbandingan Algoritma Naive Bayes dan Decision Tree dalam Pengujian Data Anemia Menggunakan*. *Inotek*, vol. 8, 2024.
- Y. Maulina, A. Gunaryati, and R. T. Aldisa. 2016. *Sistem Pakar Diagnosis Awal Penyakit Anemia Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Certainty Factor, STRING*.

- UNICEF. (2019). Adolescent Nutrition: A Review of the Situation in Selected South-East Asian Countries.
- Lin, H., Zhan, B., Shi, X., Feng, D., Tao, S., Wo, M., Fei, X., Wang, W., & Yu, Y. (2024). The mean reticulocyte volume is a valuable index in early diagnosis of cancer-related anemia. *PeerJ*, 12, 1–17. <https://doi.org/10.7717/peerj.17063>
- Dutta, S., Karkada, I. R., Sengupta, P., & Chinni, S. V. (2021). Anthropometric Markers With Specific Cut-Offs Can Predict Anemia Occurrence Among Malaysian Young Adults. *Frontiers in Physiology*, 12(September), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.731416>
- Ataga, K. I., Gordeuk, V. R., Agodoa, I., Colby, J. A., Gittings, K., & Allen, I. E. (2020). Low hemoglobin increases risk for cerebrovascular disease, kidney disease, pulmonary vasculopathy, and mortality in sickle cell disease: A systematic literature review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 15(4), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229959>
- Hornedo-González, K. D., Jacob, A. K., Burt, J. M., Higgins, A. A., Engel, E. M., Hanson, A. C., Belch, L., Kor, D. J., & Warner, M. A. (2023). Non-invasive hemoglobin estimation for preoperative anemia screening. *Transfusion*, 63(2), 315–322.
- Young, M. F., Raines, K., Jameel, F., Sidi, M., Oliveira-Streiff, S., Nwajei, P., McGlamry, K., Ou, J., Oladele, A., & Suchdev, P. S. (2021). Non-invasive hemoglobin measurement devices require refinement to match diagnostic performance with their high level of usability and acceptability. *PLoS ONE*, 16(7 July), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254629>
- Manandhar, N. (2018). Anemia in Hospitalized Patients: A Cross-Sectional Study on Different Erythrocyte Indices and their Relationships. *Journal of Health Science Research*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.18311/jhsr/2018/20969>
- Deivita, Y., Syafruddin, S., Andi Nilawati, U., Aminuddin, A., Burhanuddin, B., & Zahir, Z. (2021). Overview of Anemia; risk factors and solution offering. *Gaceta Sanitaria*, 35, S235–S241. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.07.034>
- Purnama, Y., Sriati, A., & Maulana, R. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual berisiko pada remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–128. <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i2.22481>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) pada remaja. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pedoman/IMS-remaja.pdf>
- Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions of self-injury. *Current Directions in Psychological Science*, 18(2), 78–83. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01613.x>

CHAPTER 5

EDUKASI *PERSONAL HYGINE* DAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Konsep Dasar Remaja

1. Definisi remaja

Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan cepat pada aspek fisik, psikologis, emosional, kognitif, dan sosial. Masa ini menjadi periode penting dalam perkembangan manusia karena remaja mulai mengalami proses menuju kemandirian serta pembentukan identitas diri. Remaja tidak hanya melanjutkan perkembangan dari masa anak-anak, tetapi juga dapat menjadi titik perubahan yang memengaruhi kehidupan pada tahap dewasa (Blakemore, 2018).

Secara umum, remaja didefinisikan sebagai tahap ketika individu mencapai kematangan biologis, psikologis, dan sosial secara bertahap. Masa ini sering dikaitkan dengan dekade kedua kehidupan dan biasanya dimulai sejak pubertas. Pada fase ini terjadi proses pematangan somatik, seksual, emosional, intelektual, kognitif, dan sosial yang akhirnya membentuk peran serta identitas baru sebagai individu dewasa (Chaku & Davis-Kean, 2024).

2. Domain Perkembangan Utama pada Masa Remaja

a. Perkembangan Fisik dan Seksual

Pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan seksual akibat proses pubertas. Perubahan tersebut meliputi pertambahan tinggi dan berat badan, perkembangan organ reproduksi, munculnya ciri-ciri seksual sekunder, serta kematangan seksual. Perubahan ini menandai dimulainya transisi biologis dari anak menuju dewasa (Alifia Izzani et al., 2024).

b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif pada remaja ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir abstrak, logis, dan kritis. Remaja mulai mampu memecahkan masalah dengan lebih kompleks, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta menggunakan penalaran yang menyerupai cara berpikir orang dewasa (Alifia Izzani et al., 2024).

c. Perkembangan Emosional

Masa remaja ditandai dengan emosi yang lebih intens dan perubahan suasana hati yang cepat. Pada fase ini remaja mulai mencari identitas diri, memahami perasaan pribadi, serta belajar mengelola emosi dalam berbagai situasi sosial dan lingkungan (Alifia Izzani et al., 2024).

d. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial remaja terlihat dari meningkatnya kedekatan dengan teman sebaya, mulai munculnya ketertarikan romantis, serta perubahan hubungan dengan keluarga. Remaja cenderung lebih banyak mencari dukungan sosial dari kelompok teman dan mulai membangun hubungan interpersonal yang lebih luas (Alifia Izzani et al., 2024).³

B. Konsep *Personal hygiene* pada Remaja

1. Pengertian personal hygiene

Personal hygiene merupakan upaya perawatan diri yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sehingga mendukung kesejahteraan fisik maupun psikologis. *Personal hygiene* mencakup berbagai aktivitas sehari-hari seperti mandi, menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan, menyikat gigi, merawat rambut dan kuku, serta menjaga kebersihan organ reproduksi. Pada remaja perempuan, kebersihan menstruasi juga termasuk bagian penting dari *personal hygiene* karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi selama masa menstruasi (Minda et al., 2024).

2. Tujuan personal hygiene

a. Mencegah Penyakit dan Infeksi

Personal hygiene bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan berbagai infeksi yang disebabkan oleh kebersihan tubuh yang buruk. Kebiasaan hidup bersih dapat mengurangi risiko diare, infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit akibat bakteri dan virus (Minda et al., 2024).

b. Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Hidup

Kebersihan diri yang baik membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan rasa nyaman, serta mendukung penerimaan sosial di lingkungan sekitar. Remaja yang menjaga kebersihan diri umumnya lebih percaya diri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Minda et al., 2024).

c. Mengurangi Ketidakhadiran di Sekolah dan Beban Ekonomi

Penerapan *personal hygiene* yang baik dapat menurunkan angka sakit pada remaja sehingga mengurangi ketidakhadiran di sekolah. Selain itu,

pencegahan penyakit melalui kebersihan diri juga dapat mengurangi beban biaya pengobatan bagi keluarga dan pelayanan Kesehatan (Minda et al., 2024).

d. Melindungi Kesehatan Reproduksi

Pada remaja perempuan, *personal hygiene* terutama saat menstruasi bertujuan untuk mencegah infeksi saluran reproduksi dan infeksi saluran kemih. Kebersihan organ genital yang baik membantu menjaga kesehatan reproduksi dan kenyamanan selama menstruasi (Djaguna et al., 2024).

3. Prinsip *personal hygiene*

a. Dilakukan Secara Teratur dan Konsisten

Personal hygiene perlu dilakukan secara rutin agar kebersihan tubuh tetap terjaga dan risiko penyakit dapat dicegah. Kebiasaan seperti mandi dua kali sehari, mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet, menyikat gigi, serta mengganti pakaian bersih harus menjadi bagian dari aktivitas harian remaja. Konsistensi dalam menjaga kebersihan diri juga membantu meningkatkan rasa nyaman dan percaya diri (Minda et al., 2024).

b. Menggunakan Sarana yang Memadai

Pelaksanaan *personal hygiene* membutuhkan fasilitas yang bersih dan memadai, seperti ketersediaan air bersih, sabun, sikat gigi, toilet sehat, pembalut yang higienis, serta lingkungan yang bersih. Sarana yang baik membantu remaja menjaga kesehatan tubuh secara optimal dan mencegah penularan penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis (Minda et al., 2024).

c. Didukung Pengetahuan dan Sikap Positif

Pengetahuan mengenai pentingnya kebersihan diri sangat memengaruhi perilaku remaja dalam menerapkan *personal hygiene*. Remaja yang memahami manfaat menjaga kebersihan tubuh cenderung memiliki sikap positif dan lebih disiplin dalam merawat dirinya. Sikap peduli terhadap kesehatan juga dapat membentuk kebiasaan hidup sehat hingga dewasa.

d. Pendidikan dan Pendampingan yang Berkelanjutan (Hairil Akbar, 2020).

Pendidikan kesehatan mengenai *personal hygiene* perlu diberikan secara terus-menerus melalui keluarga, sekolah, maupun tenaga kesehatan. Pendampingan dan dukungan dari orang tua serta guru membantu remaja menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Edukasi yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan (Adhyatma et al., 2023).

4. Dampak *personal hygiene* yang buruk pada remaja

a. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

1) Penyakit Infeksi

Personal *hygiene* yang buruk dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit menular, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, kolera, disentri, polio, hepatitis, dan cacingan. Kondisi tubuh dan lingkungan yang tidak bersih memudahkan berkembangnya bakteri, virus, dan parasit penyebab penyakit (Minda et al., 2024).

2) Gangguan Kesehatan Reproduksi dan Urogenital

Kebersihan organ reproduksi yang kurang baik, terutama saat menstruasi, dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, serta keputihan abnormal. Dalam jangka panjang, kebersihan genital yang buruk juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada leher rahim (serviks) (Hairil Akbar, 2020).

3) Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut

Kebiasaan tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut, seperti jarang menyikat gigi, dapat menyebabkan gigi berlubang, radang gusi, plak gigi, dan bau mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta menurunkan kualitas hidup remaja (Han et al., 2020).

b. Dampak Psikososial

Kebersihan diri yang buruk dapat memengaruhi hubungan sosial dan kondisi psikologis remaja. Remaja yang kurang menjaga kebersihan tubuh cenderung merasa kurang percaya diri dan dapat dijauhi oleh teman sebaya. Kondisi ini berisiko menimbulkan rasa malu, rendah diri, bahkan perundungan (bullying) yang berdampak pada kesehatan mental remaja (Chowdhury et al., 2024).

c. Dampak terhadap Pendidikan

Gangguan kesehatan akibat personal *hygiene* yang buruk dapat menyebabkan remaja sering sakit dan tidak masuk sekolah. Hal tersebut dapat menurunkan konsentrasi belajar, menghambat proses pembelajaran, serta berdampak pada penurunan prestasi akademik. Selain itu, rasa tidak nyaman akibat kurang menjaga kebersihan diri juga dapat mengurangi partisipasi remaja dalam kegiatan sekolah (Han et al., 2020).

C. Komponen Utama *Personal Hygiene* pada Remaja

Tabel 5. 1 Komponen Personal Hygiene pada remaja

No	Komponen Personal Hygiene	Penjelasan	Contoh Perawatan
1	Kebersihan Kulit	Kebersihan kulit bertujuan menjaga kulit tetap sehat dan melindungi tubuh dari kuman, debu, serta penyakit kulit. Pada remaja, produksi keringat dan minyak meningkat akibat perubahan hormon sehingga kulit lebih mudah berminyak, berjerawat, dan menimbulkan bau badan.	Mandi minimal 2 kali sehari, menggunakan sabun yang sesuai, mengganti pakaian setelah berkeringat, dan mengeringkan tubuh dengan handuk bersih.
2	Kebersihan Rambut	Kebersihan rambut penting untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan mencegah ketombe, kutu rambut, rambut berminyak, serta bau tidak sedap. Rambut yang tidak bersih dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan jamur.	Keramas secara rutin, menggunakan sampo yang sesuai, menyisir rambut setiap hari, dan tidak berbagi sisir dengan orang lain.
3	Kebersihan Gigi dan Mulut	Kebersihan gigi dan mulut bertujuan mencegah gigi berlubang, plak, bau mulut, dan penyakit gusi. Kebiasaan konsumsi makanan manis pada remaja dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi jika kebersihan mulut tidak dijaga.	Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi berfluoride, berkumur setelah makan, dan memeriksakan gigi secara berkala.
4	Kebersihan Tangan dan Kuku	Tangan dan kuku mudah menjadi tempat menempelnya kuman karena sering bersentuhan dengan benda di sekitar. Kebersihan tangan penting untuk mencegah penularan penyakit infeksi seperti diare dan influenza.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memotong kuku secara teratur, membersihkan bagian bawah kuku, dan menghindari kebiasaan menggigit kuku.

5	Kebersihan Pakaian	Pakaian yang bersih membantu menjaga kesehatan kulit, mencegah bau badan, dan meningkatkan kenyamanan serta rasa percaya diri remaja. Pakaian yang kotor dan lembap dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur.	Mengganti pakaian setiap hari, mencuci pakaian secara rutin, menjemur pakaian hingga kering, dan menyimpan pakaian di tempat yang bersih dan kering.
----------	---------------------------	---	--

Sumber: (Chowdhury et al., 2024; Hairil Akbar, 2020; Han et al., 2020)

D. *Personal hygiene* Organ Reproduksi Remaja

1. *Hygiene* Organ Reproduksi Perempuan

Hygiene organ reproduksi remaja merupakan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi untuk mencegah terjadinya infeksi, iritasi, bau tidak sedap, serta gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Pada masa remaja, perubahan hormon menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar keringat dan minyak sehingga area reproduksi menjadi lebih lembap dan rentan terhadap pertumbuhan bakteri maupun jamur. Oleh karena itu, remaja perlu memiliki pengetahuan dan perilaku *hygiene* reproduksi yang baik (Graziottin, 2024).

a. Cara membersihkan vulva

1) Frekuensi dan Cara Membersihkan

Vulva dianjurkan dibersihkan secara rutin sebanyak 1 kali sehari dan dapat ditingkatkan maksimal 2 kali sehari sesuai kebutuhan. Pembersihan dilakukan dengan arah dari depan ke belakang, terutama setelah buang air besar, untuk mencegah perpindahan bakteri dari anus ke area genital (Graziottin, 2024).

2) Penggunaan Produk Pembersih

Penggunaan produk pembersih yang tidak tepat dapat menyebabkan iritasi dan mengganggu keseimbangan flora normal vagina. Sabun batang biasa, sabun antiseptik, shower gel, bubble bath, serta vaginal douching sebaiknya dihindari karena dapat merusak pH alami dan meningkatkan risiko infeksi (Bohbot et al., 2025).

b. Pemilihan pakaian dalam

Pemilihan celana dalam yang tepat merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi perempuan. Celana dalam berfungsi melindungi area genital dari kotoran, gesekan, kelembapan

berlebih, serta membantu menjaga sirkulasi udara pada daerah intim (Umami et al., 2022).

Celana dalam yang dianjurkan adalah berbahan katun karena memiliki daya serap keringat yang baik, lembut di kulit, dan memungkinkan sirkulasi udara tetap lancar. Selain itu, celana dalam sebaiknya longgar, nyaman digunakan, dan tidak terlalu ketat agar area genital tidak lembap. Celana dalam juga perlu diganti secara teratur, minimal dua kali sehari atau setiap kali terasa lembap dan kotor, untuk menjaga kebersihan area genital tetap optimal (Umami et al., 2022). Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemilihan Celana Dalam

- 1) Memilih bahan katun yang mudah menyerap keringat.
- 2) Menggunakan ukuran yang nyaman dan tidak terlalu ketat.
- 3) Mengganti celana dalam secara rutin.
- 4) Menghindari penggunaan celana dalam lembap terlalu lama.
- 5) Mencuci celana dalam dengan sabun yang lembut dan membilas hingga bersih.
- 6) Mengeringkan celana dalam di tempat yang terkena sinar matahari agar kuman dan jamur berkurang.

c. Perawatan saat menstruasi

Tabel 5. 2 Perawatan saat menstruasi

<i>Menstrual Hygiene</i>	Penjelasan
Penggunaan Pembalut yang Bersih dan Aman	Pembalut berfungsi menyerap darah menstruasi dan menjaga area genital tetap bersih serta kering. Penggunaan pembalut sekali pakai yang bersih lebih aman dibandingkan kain pakai ulang yang tidak dicuci dan disimpan dengan baik. Kain yang lembap dan tidak higienis dapat meningkatkan risiko infeksi seperti bacterial vaginosis (BV), infeksi saluran kemih (ISK), dan kandidiasis. Jika menggunakan kain, kain harus dicuci bersih, dikeringkan di bawah sinar matahari, dan disimpan di tempat yang bersih dan kering.
Frekuensi Mengganti Pembalut	Pembalut perlu diganti secara rutin setiap 4–6 jam atau lebih sering apabila darah menstruasi banyak. Mengganti pembalut terlalu jarang dapat menyebabkan area genital menjadi lembap, menimbulkan bau tidak sedap, iritasi, dan

	meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi. Penggantian pembalut yang teratur juga membantu meningkatkan kenyamanan selama beraktivitas.
Menjaga Kebersihan saat Menstruasi	Selama menstruasi, tubuh dan area genital perlu dibersihkan secara rutin minimal 1 kali sehari dan lebih baik 2 kali atau lebih sesuai kebutuhan. Membersihkan area genital membantu mengurangi penumpukan darah dan kuman penyebab infeksi. Mandi setiap hari saat menstruasi juga penting untuk menjaga kebersihan tubuh dan mencegah bau tidak sedap.
Cara Membersihkan Setelah BAK dan BAB	Area genital harus dibersihkan dengan arah dari depan ke belakang untuk mencegah perpindahan bakteri dari anus ke vagina dan saluran kemih. Pembersihan dianjurkan menggunakan air bersih yang mengalir, kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk bersih secara lembut. Hindari menggosok terlalu keras karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit sekitar vulva.
Pembuangan Pembalut Bekas	Pembalut bekas perlu dibungkus dengan baik sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan mencegah penyebaran kuman. Pembalut sebaiknya dibuang pada tempat sampah tertutup dan tidak dibuang ke toilet karena dapat menyebabkan saluran tersumbat.

Sumber: (Ademas et al., 2020; Bohbot et al., 2025; Graziottin, 2024)

d. Pencegahan infeksi

1) Praktik yang Meningkatkan Risiko Infeksi

Beberapa kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko infeksi organ reproduksi antara lain melakukan douching atau membersihkan bagian dalam vagina, cara mencuci genital yang salah, membiarkan area genital lembap, menggunakan kain bekas yang tidak higienis saat menstruasi, tidak mengeringkan area genital setelah dibersihkan, tidak mencuci tangan sebelum menyentuh area genital, serta menggunakan toilet yang kotor. Kondisi tersebut dapat mempermudah pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab infeksi (Umami et al., 2022).

2) Menjaga Kebersihan Vulva

Kebersihan vulva yang baik dapat membantu menurunkan risiko keputihan abnormal dan infeksi organ reproduksi. Area genital perlu dijaga tetap bersih dan kering dengan cara membersihkan menggunakan air bersih serta menghindari penggunaan produk pembersih yang dapat menyebabkan iritasi (Bohbot et al., 2025).

3) Mencuci Tangan sebelum Menyentuh Area Genital

Tangan yang kotor dapat menjadi media perpindahan kuman ke organ reproduksi. Oleh karena itu, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah menyentuh area genital atau sebelum mengganti pembalut sangat penting untuk mencegah infeksi (Ademas et al., 2020).

4) Menjaga Area Genital Tetap Kering

Area genital yang lembap mempermudah pertumbuhan bakteri dan jamur. Setelah membersihkan area genital, bagian tersebut perlu dikeringkan dengan tisu atau handuk bersih secara lembut agar tetap kering dan nyaman (Bohbot et al., 2025).

5) Penggunaan Fasilitas Sanitasi yang Bersih

Ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet bersih, air bersih, sabun, dan tempat pembuangan pembalut, sangat mendukung penerapan personal hygiene yang baik dan membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi (Ademas et al., 2020).

6) Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi

Edukasi mengenai kebersihan genital terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku remaja putri dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Pengetahuan yang baik membantu remaja menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat secara konsisten (Adhyatma et al., 2023).

2. *Hygiene* Organ Reproduksi Laki-laki

Kebersihan organ reproduksi pria merupakan bagian penting dari personal hygiene yang berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah infeksi. Kebersihan penis dan skrotum yang tidak terjaga dapat meningkatkan risiko peradangan, infeksi saluran kemih, hingga infeksi menular seksual (IMS). Selain itu, sunat (sirkumsisi) juga diketahui memberikan manfaat kesehatan tertentu, terutama dalam membantu menjaga kebersihan organ genital pria (Niewozinska et al., 2024).

a. Perawatan penis dan Kebersihan skrotum

Kebersihan penis dan skrotum perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah penumpukan keringat, kotoran, minyak, dan sisa urine yang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Penis dianjurkan

dibersihkan setiap hari menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan baik agar area genital tetap bersih dan tidak lembap (Niewozinska et al., 2024).

Pada pria yang belum disunat, bagian kulup perlu dibersihkan secara lembut tanpa dipaksa ditarik karena dapat menyebabkan luka dan iritasi. Penggunaan sabun atau produk pembersih yang terlalu keras juga sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit penis dan kulup. Kurangnya kebersihan genital dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti:

- 1) Balanitis, yaitu peradangan pada kepala penis akibat kebersihan yang buruk.
- 2) Dermatitis iritan atau alergi, yang dapat dipicu oleh sabun, deterjen, atau produk pembersih tertentu.
- 3) Infeksi kulit dan bau tidak sedap akibat area genital yang lembap dan tidak bersih.

b. Sunat

Sunat adalah tindakan memotong sebagian atau seluruh kulup penis. Selain memiliki nilai budaya dan agama, sunat juga memiliki manfaat medis dalam membantu menjaga kebersihan penis dan mengurangi risiko beberapa penyakit (Mehta et al., 2021).

Manfaat Sunat

- 1) Mempermudah proses pembersihan penis.
- 2) Mengurangi risiko penumpukan kotoran dan bakteri di bawah kulup.
- 3) Menurunkan risiko balanitis dan phimosis.
- 4) Menurunkan risiko infeksi saluran kemih pada bayi laki-laki.
- 5) Membantu mengurangi risiko beberapa infeksi menular seksual, seperti HIV heteroseksual, HPV, dan HSV-2.

c. Pencegahan infeksi

Pencegahan infeksi organ reproduksi pria dapat dilakukan melalui penerapan kebersihan genital yang baik dan perilaku hidup sehat. Area genital yang lembap, terutama di bawah kulup pada pria yang belum disunat, dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme penyebab infeksi (Mehta et al., 2021).

Beberapa upaya pencegahan infeksi antara lain:

- 1) Membersihkan penis dan skrotum setiap hari menggunakan air bersih.
- 2) Mengeringkan area genital setelah mandi atau setelah BAK.
- 3) Mengganti pakaian dalam secara rutin dan menggunakan bahan yang menyerap keringat.
- 4) Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh area genital.

- 5) Menghindari penggunaan produk pembersih yang dapat menyebabkan iritasi.
- 6) Menerapkan perilaku seks aman dan menggunakan kondom untuk mencegah IMS.

E. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi kesehatan reproduksi (WHO dan ICPD)

Menurut *World Health Organization* dan *International Conference on Population and Development*, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit. Konsep ini juga mencakup kehidupan seksual yang aman, sehat, dan memuaskan, serta hak setiap individu untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang baik. Remaja merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan reproduksi sehingga kesehatan reproduksi remaja perlu mendapat perhatian khusus. Pada masa remaja terjadi berbagai perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar remaja mampu menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah berbagai risiko dan masalah kesehatan di masa depan (Akande, 2021).

2. Hak kesehatan reproduksi remaja

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) atau Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi adalah konsep yang menggabungkan aspek kesehatan reproduksi dengan hak asasi manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk remaja, memiliki hak untuk mencapai kondisi kesehatan seksual dan reproduksi yang optimal, aman, dan bermartabat sepanjang siklus kehidupannya (Santhya & Jejeebhoy, 2015).

Aspek-Aspek Sexual and Reproductive Health and Rights :

a. Hak Mendapatkan Informasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Setiap individu berhak memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan berbasis ilmiah mengenai kesehatan seksual dan reproduksi untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah perilaku berisiko.

b. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Aman dan Berkualitas

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, nyaman, mudah diakses, serta diberikan oleh tenaga kesehatan secara profesional tanpa diskriminasi.

c. Hak Bebas dari Kekerasan dan Diskriminasi Seksual

Setiap individu berhak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang berkaitan dengan seksualitas maupun reproduksi.

d. Hak Menjaga Privasi dan Kerahasiaan

Informasi dan kondisi kesehatan reproduksi seseorang harus dijaga kerahasiaannya agar individu merasa aman dan nyaman saat memperoleh pelayanan kesehatan.

e. Hak Mengambil Keputusan tanpa Paksaan

Setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksi secara sadar dan mandiri tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.

3. Ruang lingkup kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi remaja memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai aspek fisik, mental, sosial, dan perilaku yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja tidak hanya terbatas pada organ reproduksi, tetapi juga mencakup perilaku seksual, penyakit menular, kekerasan seksual, status gizi, hingga kebersihan diri. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi kesehatan reproduksi serta kualitas hidup remaja di masa depan (Santhya & Jejeebhoy, 2015).

Beberapa fokus utama ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja di antaranya:

a. Perilaku Seksual dan Kehamilan Remaja

Kesehatan reproduksi remaja mencakup masalah perilaku seksual, seperti hubungan seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, serta risiko aborsi tidak aman yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental remaja.

b. Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS

Remaja perlu memahami pencegahan, penularan, dan dampak infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, karena perilaku seksual berisiko dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi.

c. Kekerasan Seksual dan Perkawinan Dini

Ruang lingkup kesehatan reproduksi juga meliputi perlindungan remaja dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi seksual, serta praktik perkawinan usia anak yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan masa depan remaja.

d. Masalah Kesehatan Reproduksi Perempuan

Aspek ini mencakup berbagai masalah khusus perempuan, seperti gangguan menstruasi, kebersihan saat menstruasi, mutilasi genital

perempuan, serta pencegahan penyakit reproduksi seperti kanker serviks dan kanker ovarium.

e. Gizi dan Personal Hygiene

Status gizi, anemia, stunting, serta kebersihan organ reproduksi menjadi bagian penting dalam kesehatan reproduksi remaja karena sangat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan reproduksi di masa depan.

4. Tujuan kesehatan reproduksi remaja

Kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk membantu remaja mencapai kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang optimal dalam aspek reproduksi. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan remaja (Kabiru, 2019).

Beberapa tujuan dilakukannya program kesehatan reproduksi remaja diantaranya adalah:

a. Mencegah Perilaku Seksual Berisiko dan Dampaknya

Kesehatan reproduksi remaja bertujuan mencegah perilaku seksual berisiko yang dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, kekerasan seksual, serta pernikahan usia dini.

b. Mempersiapkan Kehidupan Reproduksi yang Sehat dan Bertanggung Jawab

Remaja dipersiapkan agar memiliki kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam menjalani kehidupan reproduksi, termasuk kesiapan membangun keluarga dan menjadi orang tua pada usia yang matang.

c. Memenuhi Hak dan Kebutuhan Perkembangan Remaja

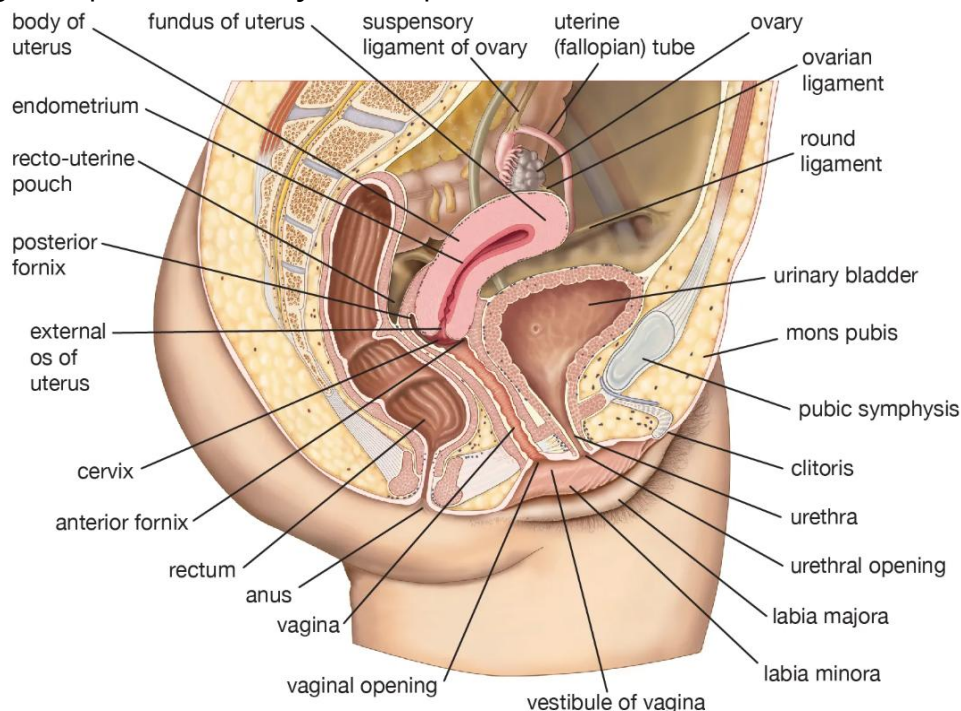
Kesehatan reproduksi remaja juga bertujuan mendukung perkembangan emosional, kognitif, dan psikososial remaja, serta mendorong kesetaraan gender dan kesempatan sosial yang lebih baik.

d. Mengurangi Ketimpangan Kesehatan Reproduksi

Upaya kesehatan reproduksi bertujuan mengurangi kesenjangan akses informasi dan pelayanan kesehatan antar kelompok remaja sehingga setiap remaja memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan berkualitas.

F. Organ Reproduksi Remaja

1. Organ Reproduksi Remaja Perempuan



Gambar 5. 1 Organ Reproduksi Remaja Perempuan

Keterangan Bagian Anatomi Reproduksi Wanita

Organ Reproduksi Internal

- 1) Body of uterus (Badan rahim) :Bagian utama rahim tempat janin berkembang selama kehamilan.
- 2) Fundus of uterus (Fundus rahim) : Bagian paling atas rahim, sering digunakan untuk mengukur tinggi fundus pada kehamilan.
- 3) Endometrium :Lapisan terdalam rahim yang menebal setiap siklus menstruasi dan menjadi tempat implantasi embrio.
- 4) Cervix (Serviks / leher rahim) :Bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina.
- 5) External os of uterus (Ostium uteri eksternum) : Lubang luar serviks yang membuka ke vagina.
- 6) Anterior fornix : Ruang cekung di depan serviks pada bagian atas vagina.
- 7) Posterior fornix : Ruang cekung di belakang serviks; paling dalam dibanding fornix lain.
- 8) Vagina : Saluran muskular yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh; berfungsi sebagai jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi.
- 9) Vaginal opening (Introitus vagina): Lubang masuk vagina.

- 10) Vestibule of vagina (Vestibulum vagina): Area di antara labia minora tempat muara uretra dan vagina berada.
- 11) Uterine/Fallopian tube (Tuba falopi / saluran telur) : Saluran yang membawa ovum dari ovarium menuju rahim dan tempat terjadinya fertilisasi.
- 12) Ovary (Ovarium / indung telur) : Organ penghasil sel telur serta hormon estrogen dan progesteron.
- 13) Ovarian ligament (Ligamentum ovarii) : Ligamen yang menghubungkan ovarium dengan rahim.
- 14) Suspensory ligament of ovary : Ligamen yang menopang ovarium dan membawa pembuluh darah ovarium.
- 15) Round ligament (Ligamentum rotundum) : Ligamen yang membantu mempertahankan posisi rahim tetap anteversi.

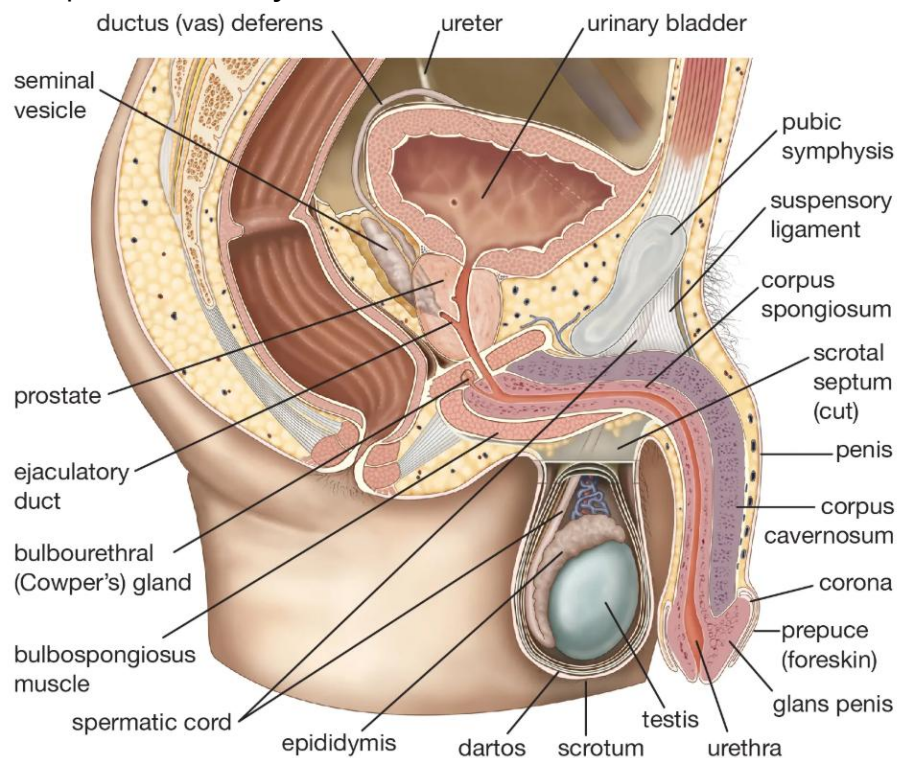
Organ Kemih dan Pencernaan

- 16) Urinary bladder (Kandung kemih) : Organ penyimpan urine sebelum dikeluarkan.
- 17) Urethra : Saluran pengeluaran urine dari kandung kemih.
- 18) Urethral opening (Meatus uretra eksternus) : Lubang tempat keluarnya urine.
- 19) Rectum : Bagian akhir usus besar sebelum anus.
- 20) Anus : Lubang tempat keluarnya feses.
- 21) Recto-uterine pouch (Kavum Douglas): Ruang antara rahim dan rektum; merupakan bagian terdalam rongga panggul wanita.

Organ Genitalia Eksterna

- 22) Mons pubis : Jaringan lemak di atas tulang pubis yang ditumbuhi rambut setelah pubertas.
- 23) Pubic symphysis (Simfisis pubis) : Sendi penghubung tulang pubis kanan dan kiri.
- 24) Clitoris (Klitoris) : Organ erektile yang sangat sensitif dan berperan dalam rangsangan seksual.
- 25) Labia majora : Bibir besar vagina yang melindungi organ genital bagian dalam.
- 26) Labia minora : Bibir kecil vagina yang berada di dalam labia majora dan melindungi muara uretra serta vagina.

2. Sistem Reproduksi Remaja Laki-laki



Gambar 5. 2 Organ Reproduksi Remaja Laki-laki

Keterangan Bagian Anatomi Reproduksi Laki-laki

Organ Reproduksi Internal

- 1) Ductus (vas) deferens / Vas deferens : Saluran yang membawa sperma dari epididimis menuju duktus ejakulatorius.
- 2) Seminal vesicle (Vesikula seminalis) : Kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai nutrisi sperma dan penyusun utama semen.
- 3) Ejaculatory duct (Duktus ejakulatorius) : Saluran yang terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesikula seminalis, bermuara ke uretra.
- 4) Prostate (Kelenjar prostat) : Kelenjar yang menghasilkan cairan prostat untuk membantu melindungi dan mengaktifkan sperma.
- 5) Bulbourethral/Cowper's gland (Kelenjar Cowper) : Menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan sisa keasaman uretra sebelum ejakulasi.
- 6) Epididymis : Saluran berkelok di atas testis tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.
- 7) Testis : Organ penghasil sperma dan hormon testosteron.
- 8) Spermatic cord (Korda spermatika) : Struktur yang berisi vas deferens, pembuluh darah, saraf, dan limfe menuju testis.

Organ Kemih

- 9) Ureter : Saluran yang membawa urine dari ginjal ke kandung kemih.
- 10) Urinary bladder (Kandung kemih) :Organ penyimpan urine sebelum dikeluarkan.
- 11) Urethra (Uretra) :Saluran pengeluaran urine dan semen melalui penis.

Struktur Penis dan Skrotum

- 12) Penis : Organ reproduksi luar pria yang berfungsi untuk kopulasi dan pengeluaran urine.
- 13) Glans penis : Ujung penis yang sangat sensitif terhadap rangsangan.
- 14) Prepuce/Foreskin (Preputium/kulup) : Lipatan kulit yang menutupi glans penis pada pria yang belum disirkumsisi.
- 15) Corona : Bagian tepi menonjol di dasar glans penis.
- 16) Corpus cavernosum : Jaringan erektile utama penis yang terisi darah saat ereksi.
- 17) Corpus spongiosum : Jaringan erektile yang mengelilingi uretra dan mencegah uretra tertekan saat ereksi.
- 18) Scrotum (Skrotum) : Kantung kulit yang melindungi dan menjaga suhu testis.
- 19) Scrotal septum : Sekat yang memisahkan testis kanan dan kiri di dalam skrotum.
- 20) Dartos : Lapisan otot polos pada skrotum yang membantu pengaturan suhu testis.
- 21) Suspensory ligament (Ligamentum suspensorium penis) : Ligamen yang menopang penis pada tulang pubis.
- 22) Bulbospongiosus muscle (Otot bulbospongiosus) : Membantu pengeluaran semen dan urine serta berperan dalam ereksi.

Struktur Tulang Panggul

- 23) Pubic symphysis (Simfisis pubis) : Sendi penghubung tulang pubis kanan dan kiri di bagian depan panggul.

G. Pubertas pada Remaja

1. Pengertian pubertas

Pubertas merupakan masa transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan kematangan seksual dan kemampuan reproduksi. Pada masa ini terjadi perubahan biologis, fisik, hormonal, psikologis, serta sosial yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut menyebabkan remaja mengalami perkembangan ciri-ciri seksual primer maupun sekunder (Alotaibi, 2019).

Pubertas tidak hanya berkaitan dengan perubahan tubuh, tetapi juga memengaruhi emosi, pola pikir, perilaku, hubungan sosial, dan pembentukan identitas diri. Oleh karena itu, masa pubertas sering menjadi periode yang membingungkan sekaligus menantang bagi remaja.

2. Perubahan Utama pada Masa Pubertas

Perubahan fisik terjadi akibat peningkatan hormon reproduksi dan hormon pertumbuhan. Perubahan ini berbeda antara remaja perempuan dan laki-laki.

Tabel 5. 3 Perubahan Masa Pubertas

Aspek	Perempuan	Laki-laki
Pertumbuhan rambut	Rambut pubis dan ketiak	Rambut pubis, ketiak, dada, dan wajah
Pertumbuhan tubuh	Pinggul melebar, peningkatan lemak tubuh	Bahu melebar, peningkatan massa otot
Pertumbuhan tinggi badan	Terjadi lonjakan pertumbuhan	Terjadi lonjakan pertumbuhan lebih besar
Perubahan kulit	Jerawat dan kulit lebih berminyak	Jerawat dan kulit lebih berminyak
Organ reproduksi	Payudara berkembang, menstruasi mulai terjadi	Penis dan testis membesar

Sumber: (Alotaibi, 2019)

3. Pubertas pada Perempuan

a. Perkembangan Payudara (*Thelarche*)

Tanda awal pubertas pada perempuan umumnya berupa pembentukan tunas payudara (*thelarche*). Perubahan ini terjadi akibat peningkatan hormon estrogen.

1) Menarche

Menarche adalah menstruasi pertama yang menandai mulai matangnya fungsi reproduksi perempuan. *Menarche* biasanya terjadi sekitar 2,5–3 tahun setelah perkembangan payudara dimulai.

2) Sebagian remaja mengalami keluhan saat menarche, seperti:

- Nyeri perut atau kram menstruasi
- Perubahan suasana hati
- Rasa cemas atau malu

Kurangnya informasi dan dukungan keluarga dapat menyebabkan remaja merasa takut atau panik ketika mengalami menstruasi pertama.

- 3) Perubahan Fisik Lain
 - a) Perubahan lain yang umum terjadi pada remaja perempuan meliputi:
 - b) Pinggul melebar
 - c) Bokong membulat
 - d) Pertumbuhan rambut pubis dan ketiak
 - e) Muncul jerawat
 - f) Pertumbuhan tinggi badan yang cepat
4. Pubertas pada Laki-Laki
 - a. Pembesaran Testis

Tanda awal pubertas pada laki-laki adalah pembesaran testis. Perubahan ini menunjukkan mulai aktifnya produksi hormon testosteron dan pembentukan sperma.
 - b. Perubahan Organ Reproduksi

Setelah pembesaran testis, terjadi:

 - 1) Pertumbuhan penis
 - 2) Produksi sperma
 - 3) Mimpi basah (nocturnal emission)
 - c. Perubahan Fisik Lain
 - 1) Perubahan lain pada laki-laki meliputi:
 - 2) Pertumbuhan rambut pubis, ketiak, dada, dan wajah
 - 3) Suara menjadi lebih berat
 - 4) Bahu dan dada melebar
 - 5) Massa otot meningkat
 - 6) Nafsu makan meningkat
 - 7) Pertumbuhan tinggi badan yang pesat
 - 8) Timbul jerawat
5. Perubahan Hormonal pada Pubertas

Pubertas dipengaruhi oleh aktivasi sistem hormonal yang melibatkan hipotalamus, hipofisis, dan gonad (sumbu hipotalamus–pituitari–gonad/HPG).

 - a. Adrenarche

Adrenarche adalah peningkatan aktivitas kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon androgen, seperti DHEA dan DHEAS. Hormon ini menyebabkan:

 - 1) Pertumbuhan rambut pubis dan ketiak
 - 2) Timbul bau badan
 - 3) Kulit menjadi lebih berminyak
 - 4) Muncul jerawat

b. Gonadarche

Gonadarche merupakan aktivasi gonad (ovarium dan testis) akibat pelepasan hormon GnRH dari hipotalamus.

Proses ini meningkatkan produksi:

- 1) Estrogen dan estradiol pada perempuan
- 2) Testosteron pada laki-laki

Hormon-hormon tersebut berperan dalam:

- 1) Perkembangan organ reproduksi
- 2) Pembentukan ciri kelamin sekunder
- 3) Lonjakan pertumbuhan tinggi badan
- 4) Perubahan distribusi lemak dan massa otot
- 5) Selain itu, hormon pubertas juga memengaruhi perkembangan otak, emosi, dan perilaku remaja.

H. Masalah Kesehatan Reproduksi pada Remaja

Remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh perubahan hormonal, kurangnya pengetahuan, perilaku berisiko, personal hygiene yang kurang tepat, serta masih adanya stigma dan tabu dalam membahas kesehatan reproduksi. Masalah yang sering terjadi meliputi infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, kehamilan remaja, anemia, dan gangguan psikososial .

1. Infeksi saluran reproduksi dan Keputihan Patologis

Infeksi saluran reproduksi (ISR) adalah infeksi yang terjadi pada organ reproduksi perempuan, seperti vagina, serviks, atau organ reproduksi bagian atas. Salah satu gejala yang paling sering muncul adalah keputihan patologis, yaitu keluarnya cairan vagina yang tidak normal, berwarna, berbau, menimbulkan gatal, atau nyeri. Keputihan patologis dapat disebabkan oleh: Vaginosis bakterialis, Kandidiasis (infeksi jamur), Trikomoniasis (Salina et al., 2025).

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko ISR dan keputihan patologis pada remaja antara lain:

- a. Personal hygiene yang buruk
- b. Cara membersihkan genital yang salah
- c. Penggunaan pakaian terlalu ketat dan lembap
- d. Jarang mengganti pembalut
- e. Perubahan hormonal saat pubertas
- f. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi
- g. Kebiasaan menahan kelembapan pada area genital

Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi saluran reproduksi (ISR) dan keputihan patologis dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penderita sering mengalami rasa tidak nyaman, gatal, nyeri, dan bau tidak sedap pada area genital yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Infeksi juga dapat terjadi berulang apabila kebersihan organ reproduksi tidak dijaga atau penyebab infeksi tidak diobati secara tuntas (Salina et al., 2025).

2. Infeksi menular seksual (IMS)

Infeksi menular seksual (IMS) adalah penyakit infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, maupun anal. Remaja termasuk kelompok yang rentan karena kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko. IMS yang sering ditemukan antara lain gonore, klamidia, sifilis, dan HIV/AIDS. Sebagian IMS tidak menimbulkan gejala pada tahap awal sehingga penderita sering tidak menyadari dirinya terinfeksi dan dapat menularkan kepada orang lain (Adamyman et al., 2023).

Faktor yang meningkatkan risiko Infeksi menular seksual (IMS) pada remaja meliputi:

- a. Seks pranikah
- b. Berganti-ganti pasangan seksual
- c. Tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom
- d. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual
- e. Pengaruh teman sebaya
- f. Penyalahgunaan alkohol atau narkoba
- g. Akses informasi yang tidak tepat

IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi maupun kesehatan umum. Infeksi dapat menimbulkan nyeri pada organ reproduksi, keputihan abnormal, luka pada genital, hingga nyeri panggul kronis. Pada perempuan, IMS tertentu dapat menyebabkan kerusakan tuba falopi yang berujung pada infertilitas atau kehamilan ektopik. IMS juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan penularan HIV. Selain dampak fisik, penderita IMS sering mengalami stres, rasa malu, kecemasan, dan stigma sosial yang memengaruhi kesehatan psikologis serta hubungan sosialnya (Adamyman et al., 2023).

3. Kehamilan remaja

Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan berusia kurang dari 20 tahun. Kehamilan pada usia remaja umumnya terjadi ketika organ reproduksi dan kondisi psikologis belum matang sepenuhnya. Sebagian besar kasus berkaitan dengan hubungan seksual tanpa persiapan fisik, mental, sosial,

maupun ekonomi yang memadai, sehingga remaja lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan dan sosial (Diabelková et al., 2023).

Faktor risiko kehamilan remaja antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan seks
- b. Seks pranikah
- c. Pernikahan usia dini
- d. Pengaruh lingkungan dan media
- e. Rendahnya pengawasan orang tua
- f. Faktor sosial ekonomi rendah
- g. Kurangnya akses pelayanan kesehatan reproduksi

Kehamilan remaja dapat menimbulkan dampak serius bagi ibu maupun bayi. Pada ibu, kehamilan usia muda meningkatkan risiko anemia, tekanan darah tinggi dalam kehamilan, serta komplikasi persalinan karena kondisi fisik belum optimal. Bayi yang dilahirkan juga lebih berisiko mengalami persalinan prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Selain dampak kesehatan, kehamilan remaja sering menyebabkan putus sekolah, keterbatasan kesempatan kerja, tekanan psikologis, stigma sosial, serta ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Risiko kematian ibu dan bayi pada kehamilan usia remaja juga cenderung lebih tinggi dibandingkan usia reproduksi sehat (Rahmawati & Murtaqib, 2024).

4. Anemia pada remaja putri

Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun. Remaja putri lebih rentan mengalami anemia karena kehilangan darah saat menstruasi dan kebutuhan zat besi yang meningkat selama pertumbuhan (Suprapti et al., 2025).

Faktor risiko anemia pada remaja putri meliputi:

- a. Kurangnya asupan zat besi
- b. Pola makan tidak seimbang
- c. Diet ketat
- d. Menstruasi yang banyak
- e. Kurang konsumsi makanan bergizi
- f. Infeksi atau penyakit tertentu

Anemia pada remaja dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, lemas, pusing, dan kurang bertenaga karena kadar hemoglobin yang rendah menghambat distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar dan daya ingat sehingga prestasi akademik dapat terganggu. Jika berlangsung lama, anemia dapat menghambat

pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh sehingga remaja lebih mudah sakit, serta memengaruhi perkembangan mental dan emosional seperti mudah marah, kurang percaya diri, dan menurunnya motivasi dalam beraktivitas (Suprpti et al., 2025).

Referensi

- Adamyan, L. V., Sibirskaya, E. V., Sharkov, S. M., Pivazyanyan, L. G., Shapovalenko, R. A., & Zakaryan, A. A. (2023). The impact of sexually transmitted infections on the reproductive health in adolescent girls. *Russian Pediatric Journal*, 26(5), 376–382. <https://doi.org/10.46563/1560-9561-2023-26-5-376-382>
- Ademas, A., Adane, M., Sisay, T., Kloos, H., Eneyew, B., Keleb, A., Lingerew, M., Derso, A., & Alemu, K. (2020). Does menstrual hygiene management and water, sanitation, and hygiene predict reproductive tract infections among reproductive women in urban areas in Ethiopia? *PloS One*, 15(8). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0237696>
- Adhyatma, A. A., Purba, N. H., & Panggabean, S. M. U. (2023). Personal Hygiene Education As the Application of Personal Hygiene Behavior in Adolescents. *Awal Bros Journal of Community Development*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.54973/abjcd.v4i1.333>
- Akande, E. O. (2021). Sexual and reproductive health and rights: An overview. *Contemporary Obstetrics and Gynecology for Developing Countries: Second Edition*, 3–6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75385-6_1
- Alifia Izzani, T., Octaria, S., Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sjceh Djamil Djambek Bukittinggi Alamat, L. M., Gurun Aua, J., Putiah, K., Banuhampu, K., Bukittinggi, K., & Barat, S. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/JISPENDIORA.V3I2.1578>
- Alotaibi, M. F. (2019). Physiology of puberty in boys and girls and pathological disorders affecting its onset. *Journal of Adolescence*, 71, 63–71. <https://doi.org/10.1016/J.ADOLESCENCE.2018.12.007>
- Blakemore, S. J. (2018). Development of the adolescent brain: implications for executive function and social cognition. *European Neuropsychopharmacology*, 28, S1. <https://doi.org/10.1016/J.EURONEURO.2017.12.017>
- Bohbot, J. M., Rebelo, C., & Nappi, R. E. (2025). Vulvar Care: Reviewing Concepts in Daily Hygiene. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(13). <https://doi.org/10.3390/HEALTHCARE13131523>
- Chaku, N., & Davis-Kean, P. E. (2024). Positioning adolescence in the developmental timeline. *Journal of Research on Adolescence: The Official Journal of the Society for Research on Adolescence*, 34(4), 1191–1200. <https://doi.org/10.1111/JORA.12928>
- Chowdhury, N. S., Adrita, E. A., Jahan, H., Nahar, N., & Khanduker, S. (2024). Knowledge and Practice about Personal Hygiene among Secondary

- School Children. *PriMera Scientific Surgical Research and Practice*, 3(6), 0–6. <https://doi.org/10.56831/pssrp-03-108>
- Diabelková, J., Rimárová, K., Dorko, E., Urdzík, P., Houžvičková, A., & Argalášová, Ľ. (2023). Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/IJERPH20054113>
- Djaguna, N., Marlina, R., Sembiring, E. F., & Andriyanti, A. (2024). The Relationship Between Knowledge and Personal Hygiene Behavior in Adolescent Girls During Menstruation: A Literature Review. *International Journal Of Scientific Advances*, 5(5), 884–887. <https://doi.org/10.51542/ijscia.v5i5.4>
- Graziottin, A. (2024). Maintaining vulvar, vaginal and perineal health: Clinical considerations. *Women's Health (London, England)*, 20. <https://doi.org/10.1177/17455057231223716>
- Hairil Akbar. (2020). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSONAL HYGIENE PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 11(2), 23–28. <https://doi.org/10.35907/BGJK.V11I2.148>
- Han, L., Gao, X., Liao, M., Yu, X., Zhang, R., Liu, S., & Zeng, F. (2020). Hygiene practices among young adolescents aged 12–15 years in low- and middle-income countries: a population-based study. *Journal of Global Health*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.7189/JOGH.10.020436>
- Kabiru, C. W. (2019). Adolescents' Sexual and Reproductive Health and Rights: What Has Been Achieved in the 25 Years Since the 1994 International Conference on Population and Development and What Remains to Be Done? *Journal of Adolescent Health*, 65(6), S1–S2. <https://doi.org/10.1016/J.JADOHEALTH.2019.09.010>
- Mehta, K., Marfatia, Y., Jain, A., Shah, D., & Baxi, D. (2021). Male circumcision and Sexually transmitted Infections – An update. *Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS*, 42(1), 1. https://doi.org/10.4103/IJSTD.IJSTD_20_21
- Minda, G. H., Tola, H. H., Amhare, A. F., Kebie, A., & Endale, T. (2024). Personal hygiene practice and associated factors among elementary school students in Fiche Town, Oromia, Ethiopia. *BMC Infectious Diseases*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/S12879-024-09665-7>
- Niewozinska, Z. A., Анатольевна, Н. З., Sakaniya, L. R., Руслановна, С. Л., Korsunskaya, I. M., & Марковна, К. И. (2024). On intimate care in men: A review. *Consilium Medicum*, 26(8), 505–509. <https://doi.org/10.26442/20751753.2024.8.202792>
- Rahmawati, I., & Murtaqib, M. (2024). Efforts to Deal with the Impact of Adolescent Pregnancy through a Holistic Approach: A Literature Review. *Nursing and Health Sciences Journal (NHSJ)*, 4(1), 83–90.

<https://doi.org/10.53713/NHSJ.V4I1.329>

- Salina, S., Arlina, A., & Khairat, N. U. (2025). Risk Factors for Vaginal Discharge in Adolescent Girls. *Advances in Healthcare Research*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.60079/AHR.V3I1.388>
- Santhya, K. G., & Jejeebhoy, S. J. (2015). Sexual and reproductive health and rights of adolescent girls: Evidence from low- and middle-income countries. *Global Public Health*, 10(2), 189–221. <https://doi.org/10.1080/17441692.2014.986169>
- Suprpti, E., Hadju, V., Ibrahim, E., Indriasari, R., Erika, K. A., & Balqis, B. (2025). Anemia: Etiology, Pathophysiology, Impact, and Prevention: A Review. *Iranian Journal of Public Health*, 54(3), 509–520. <https://doi.org/10.18502/IJPH.V54I3.18244>
- Umami, A., Paulik, E., Molnár, R., & Murti, B. (2022). The relationship between genital hygiene behaviors and genital infections among women: A systematic review. *Jurnal Ners*, 17(1), 89–101. <https://doi.org/10.20473/JN.V17I1.34402>

Glosarium

Istilah	Pengertian
Adrenarche	Tahap peningkatan aktivitas kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon androgen pada awal pubertas.
Anemia	Kondisi kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal sehingga pengangkutan oksigen terganggu.
Anteversi	Posisi rahim yang condong ke depan.
Bacterial vaginosis (BV)	Infeksi atau ketidakseimbangan bakteri normal pada vagina yang menyebabkan keputihan abnormal.
Balanitis	Peradangan pada kepala penis akibat infeksi atau kebersihan yang kurang baik.
Bubble bath	Produk pembersih tubuh berbusa yang digunakan saat mandi berendam.
Corpus cavernosum	Jaringan erektile utama pada penis yang berisi darah saat ereksi.
Corpus spongiosum	Jaringan erektile yang mengelilingi uretra pada penis.
DHEA (Dehydroepiandrosterone)	Hormon androgen yang diproduksi oleh kelenjar adrenal.
DHEAS (Dehydroepiandrosterone sulfate)	Bentuk hormon DHEA yang beredar dalam darah.
Douching	Tindakan membersihkan bagian dalam vagina menggunakan cairan tertentu.
Endometrium	Lapisan terdalam rahim yang menebal selama siklus menstruasi.
Estrogen	Hormon reproduksi utama pada perempuan yang berperan dalam perkembangan seksual.
Fertilisasi	Proses pembuahan sel telur oleh sperma.
Flora normal vagina	Mikroorganisme baik yang secara alami hidup di vagina dan menjaga keseimbangan pH.

GnRH (Gonadotropin- Releasing Hormone)		Hormon dari hipotalamus yang merangsang pelepasan hormon reproduksi.
Gonadarche		Tahap aktivasi ovarium dan testis pada masa pubertas.
HIV/AIDS		Penyakit akibat infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
HPG (Hypothalamic- Pituitary-Gonadal axis)	axis	Sistem hormonal yang mengatur pubertas dan fungsi reproduksi.
Implantasi		Proses menempelnya embrio pada dinding rahim.
Infeksi Seksual (IMS)	Menular	Penyakit infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual.
Infeksi Reproduksi (ISR)	Saluran	Infeksi yang terjadi pada organ reproduksi perempuan.
Kandidiasis		Infeksi jamur pada area genital, biasanya disebabkan oleh Candida.
Kehamilan ektopik		Kehamilan yang terjadi di luar rahim.
Klamidia		Infeksi menular seksual akibat bakteri Chlamydia trachomatis.
Kondom		Alat kontrasepsi penghalang yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan IMS.
Kutil genital		Benjolan pada area genital akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV).
Menarche		Menstruasi pertama pada perempuan.
Menstruasi		Proses keluarnya darah dari rahim secara periodik akibat peluruhan endometrium.
Nocturnal emission		Pengeluaran sperma secara tidak sadar saat tidur atau mimpi basah.

Patologis	Keadaan yang berhubungan dengan penyakit atau kelainan.
Personal hygiene	Upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri.
Phimosis	Kondisi kulup penis tidak dapat ditarik ke belakang.
Pituitari/Hipofisis	Kelenjar endokrin yang mengatur berbagai hormon tubuh.
Plak gigi	Lapisan lengket pada gigi yang mengandung bakteri.
Progesteron	Hormon reproduksi perempuan yang membantu mengatur siklus menstruasi dan kehamilan.
Pubertas	Masa peralihan dari anak menuju dewasa yang ditandai kematangan seksual.
Serviks	Bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina.
Shower gel	Sabun cair untuk membersihkan tubuh saat mandi.
Simfisis pubis	Sendi penghubung tulang pubis kanan dan kiri.
Sirkumsisi	Tindakan pemotongan kulup penis atau sunat.
Stunting	Gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.
Testosteron	Hormon reproduksi utama pada laki-laki.
Thelarche	Awal perkembangan payudara pada perempuan saat pubertas.
Trikomoniasis	Infeksi menular seksual akibat parasit <i>Trichomonas vaginalis</i> .
Vaginal douching	Proses membasir bagian dalam vagina menggunakan cairan tertentu.
Vaginosis bakterialis	Ketidakseimbangan bakteri normal vagina yang menyebabkan infeksi dan keputihan.



CHAPTER 6



PERAN BIDAN, KELUARGA, DAN SEKOLAH DALAM PENDAMPINGAN REMAJA PUTRI

Cynthia Puspariny, S.S.T., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan

Remaja putri merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dari anak-anak menuju dewasa dengan berbagai perubahan biologis, psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Masa remaja ditandai dengan terjadinya pubertas, menstruasi, perubahan hormonal, perkembangan identitas diri, serta peningkatan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Perubahan tersebut menjadikan remaja putri sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan reproduksi, psikososial, perilaku berisiko, anemia, gangguan nutrisi, hingga masalah kesehatan mental apabila tidak mendapatkan pendampingan yang optimal. Menurut World Health Organization, remaja membutuhkan dukungan lingkungan yang sehat dan suportif untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal (WHO, 2022).

Pendampingan terhadap remaja putri tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan institusi pendidikan. Dalam hal ini, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, konseling, promotif, preventif, serta deteksi dini masalah kesehatan remaja. Bidan tidak hanya berfokus pada pelayanan maternal dan neonatal, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan kesehatan remaja melalui pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan, mampu meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat remaja putri secara signifikan (Sari & Handayani, 2021).

Selain bidan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter serta perilaku remaja putri. Orang tua, terutama ibu, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, pengawasan, pendidikan moral, serta komunikasi terbuka mengenai kesehatan reproduksi dan perkembangan psikologis remaja. Keharmonisan keluarga dan pola komunikasi yang baik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri remaja serta mencegah

perilaku menyimpang pada masa pubertas. Penelitian oleh Fitriani et al. (2023) menjelaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendampingan remaja memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan remaja menghadapi perubahan fisik dan emosional selama masa pubertas.

Sekolah juga menjadi komponen penting dalam mendukung tumbuh kembang remaja putri karena sebagian besar aktivitas remaja berlangsung di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku sehat dan karakter positif. Guru, konselor, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta program pendidikan kesehatan reproduksi memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan remaja. Lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan suportif mampu membantu remaja putri memahami kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan diri, meningkatkan kesehatan mental, serta mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Studi terbaru menyebutkan bahwa program pendidikan kesehatan berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan perilaku hidup sehat pada remaja putri (Nurhayati & Rahmawati, 2022).

Kolaborasi antara bidan, keluarga, dan sekolah menjadi pendekatan holistik yang sangat diperlukan dalam pendampingan remaja putri di era modern. Tantangan perkembangan teknologi, media sosial, perubahan gaya hidup, serta derasnya arus informasi menuntut adanya pengawasan dan edukasi yang berkesinambungan agar remaja mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dan masa depannya. Sinergi ketiga elemen tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi remaja putri yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga dapat menjadi perempuan yang berkualitas dan berdaya saing di masa mendatang.

B. Konsep Pendampingan Remaja Putri

1. Definisi Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu proses pemberian bantuan, bimbingan, dukungan, pengawasan, dan fasilitasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada individu atau kelompok agar mampu mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, serta mencapai kondisi yang lebih baik secara mandiri. Dalam konteks remaja putri, pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial, emosional, dan reproduksi. Pendampingan remaja putri dilakukan melalui proses edukasi, komunikasi, konseling, dan pembinaan yang bertujuan membantu remaja

menghadapi perubahan selama masa pubertas dan perkembangan menuju dewasa (Permatasari et al., 2022).

Pendampingan remaja putri menjadi penting karena masa remaja merupakan periode rentan yang ditandai dengan rasa ingin tahu tinggi, ketidakstabilan emosi, dan pengaruh lingkungan yang kuat. Kurangnya pendampingan dapat menyebabkan remaja mengalami berbagai masalah seperti rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, anemia, perilaku seksual berisiko, gangguan kesehatan mental, hingga rendahnya kepercayaan diri. Oleh sebab itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar remaja mampu memahami dirinya serta mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab (Sholichah, 2022).

2. Tujuan Pendampingan Remaja

Tujuan utama pendampingan remaja putri adalah membantu remaja mencapai tumbuh kembang yang optimal secara fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi. Pendampingan bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, pubertas, personal hygiene, gizi, kesehatan mental, serta pencegahan perilaku berisiko. Melalui pendampingan, remaja diharapkan mampu memiliki perilaku hidup sehat, meningkatkan rasa percaya diri, serta mampu menghadapi perubahan selama masa pubertas secara positif (Suwarsih et al., 2022).

Selain itu, pendampingan juga bertujuan membentuk kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Remaja putri perlu memiliki life skills seperti kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, pemecahan masalah, dan kemampuan menolak pengaruh negatif lingkungan. Pendampingan yang efektif dapat membantu remaja mengembangkan karakter positif dan meningkatkan kesiapan menghadapi kehidupan dewasa, termasuk kesiapan kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan (Simbolon et al., 2022).

Pendampingan juga bertujuan mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan remaja seperti anemia, pernikahan dini, kekerasan seksual, penyalahgunaan media sosial, serta gangguan psikososial. Dengan adanya pendampingan yang baik, remaja putri dapat memperoleh informasi yang benar, dukungan emosional, serta lingkungan yang aman untuk berkembang secara sehat (Djuwitaningsih et al., 2022).

3. Prinsip Pendampingan Remaja Putri

Pendampingan remaja putri harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan karakteristik perkembangan remaja. Salah satu prinsip utama adalah prinsip empati dan non-judgmental, yaitu pendamping harus mampu

memahami kondisi remaja tanpa menghakimi. Remaja cenderung lebih terbuka apabila merasa diterima dan dihargai. Oleh karena itu, komunikasi yang hangat, suportif, dan terbuka menjadi kunci keberhasilan dalam pendampingan remaja putri (Yani et al., 2022).

Prinsip lainnya adalah kerahasiaan (confidentiality). Remaja sering merasa takut atau malu untuk menyampaikan masalah yang dialaminya, terutama terkait kesehatan reproduksi dan psikologis. Pendamping harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi agar tercipta rasa aman dan kepercayaan dari remaja. Selain itu, prinsip partisipatif juga penting, yaitu melibatkan remaja secara aktif dalam proses pendampingan sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan kehidupannya (Permatasari et al., 2022).

Pendampingan remaja juga harus bersifat edukatif dan berkelanjutan. Informasi yang diberikan perlu disesuaikan dengan usia, tingkat pemahaman, kebutuhan, dan perkembangan psikologis remaja. Pendampingan tidak dapat dilakukan hanya satu kali, tetapi membutuhkan proses yang konsisten agar perubahan perilaku sehat dapat terbentuk secara optimal (Nurvitasari et al., 2022).

4. Pendekatan Holistik dalam Pendampingan

Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang memandang remaja sebagai individu utuh yang memiliki kebutuhan fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Dalam pendampingan remaja putri, pendekatan holistik diperlukan karena permasalahan remaja tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, budaya, dan perkembangan teknologi (Anggraini et al., 2021).

Pendekatan holistik melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan teman sebaya dalam proses pendampingan. Keluarga berperan sebagai sumber dukungan emosional dan pendidikan pertama bagi remaja. Sekolah berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter dan edukasi kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan berperan memberikan informasi, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi perkembangan remaja putri (Sholichah, 2022).

Dalam era digital, pendekatan holistik juga mulai memanfaatkan teknologi melalui media edukasi kesehatan berbasis digital, aplikasi kesehatan, dan konseling online. Pendekatan ini dinilai efektif karena sesuai dengan karakteristik generasi remaja yang dekat dengan teknologi dan media sosial. Namun, pendampingan tetap memerlukan pengawasan agar remaja mampu memilah

informasi yang benar dan terhindar dari pengaruh negatif media digital (Djuwitaningsih et al., 2022). Dengan pendekatan holistik, pendampingan remaja putri diharapkan mampu membentuk remaja yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan reproduksi, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi perempuan yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.

C. Peran Bidan dalam Pendampingan Remaja Putri

Bidan memiliki peran strategis dalam pendampingan remaja putri karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan berfokus pada kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupan. Dalam pelayanan kesehatan remaja, bidan tidak hanya berperan dalam aspek kuratif, tetapi juga promotif, preventif, edukatif, dan suportif. Pendampingan yang dilakukan bidan bertujuan membantu remaja putri mencapai kesehatan fisik, reproduksi, mental, dan sosial secara optimal sehingga mampu menjalani masa remaja dengan sehat dan percaya diri (Kasmara, 2023).

1. Bidan sebagai Edukator

Sebagai edukator, bidan memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan kepada remaja putri mengenai kesehatan reproduksi, pubertas, menstruasi, personal hygiene, gizi, anemia, serta pencegahan perilaku berisiko. Edukasi yang diberikan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja agar mampu menjaga kesehatan dirinya secara mandiri.

Penelitian Kasmara (2023) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara peran bidan dalam promosi kesehatan dengan peningkatan pengetahuan remaja putri tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) ($p\text{-value} = 0,005$). Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa edukasi yang dilakukan bidan dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap deteksi dini masalah kesehatan reproduksi.

Selain itu, penelitian Sartika et al. (2024) menemukan bahwa rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi berhubungan dengan buruknya perilaku kesehatan reproduksi remaja putri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang tepat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku sehat pada remaja. Bidan juga perlu menggunakan metode edukasi yang sesuai dengan karakteristik remaja, seperti diskusi interaktif, peer education, media audiovisual, maupun media digital agar pesan kesehatan lebih mudah dipahami dan diterima oleh remaja putri.

2. Bidan sebagai Konselor

Selain sebagai edukator, bidan juga berperan sebagai konselor bagi remaja putri. Masa remaja sering kali diwarnai berbagai permasalahan emosional dan psikososial seperti kecemasan, perubahan suasana hati, body shaming, konflik keluarga, hingga rasa takut menghadapi pubertas dan menstruasi. Dalam kondisi tersebut, bidan memberikan konseling untuk membantu remaja memahami masalah yang dialami serta menemukan solusi yang tepat.

Konseling dilakukan dengan pendekatan empati, komunikasi terapeutik, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghakimi. Pendekatan yang ramah remaja sangat penting agar remaja merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan keluhan maupun permasalahan yang dialami. Konseling yang efektif dapat meningkatkan kemampuan remaja dalam mengelola emosi, mengambil keputusan sehat, dan membangun konsep diri positif (Ramadhaniati et al., 2024).

3. Bidan sebagai Fasilitator Pelayanan Kesehatan Remaja

Bidan juga berperan sebagai fasilitator dalam pelayanan kesehatan remaja dengan menyediakan akses pelayanan yang ramah, aman, dan mudah dijangkau oleh remaja putri. Pelayanan kesehatan remaja meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan reproduksi, pemantauan status gizi, pelayanan anemia, serta rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan tertentu.

Bidan dapat bekerja sama dengan sekolah, puskesmas, dan posyandu remaja dalam menyelenggarakan program kesehatan remaja. Pelayanan yang ramah remaja bertujuan menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang nyaman sehingga remaja tidak merasa takut atau malu saat berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi maupun masalah pribadi lainnya (Anggraini et al., 2021). Bidan juga berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang mudah diakses, aman, nyaman, dan ramah remaja. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan reproduksi, pemantauan status gizi, pelayanan anemia, hingga rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan tertentu.

Pelayanan kesehatan remaja berbasis komunitas seperti posyandu remaja, UKS, dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) menjadi bentuk nyata peran bidan dalam memfasilitasi kesehatan remaja. Bidan juga bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan kader kesehatan dalam menciptakan sistem pendampingan yang berkelanjutan.

Penelitian Wardhani (2025) di komunitas pedesaan menunjukkan bahwa strategi kolaboratif bidan melalui pendekatan edukatif dan komunitas mampu meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi remaja secara signifikan.

4. Promosi Kesehatan Reproduksi

Promosi kesehatan reproduksi menjadi salah satu tugas utama bidan dalam pendampingan remaja putri. Kegiatan promosi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Materi promosi meliputi anatomi dan fisiologi reproduksi, pubertas, menstruasi sehat, personal hygiene, pencegahan kekerasan seksual, hingga perilaku seksual yang bertanggung jawab. Promosi kesehatan reproduksi dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, peer education, media audiovisual, dan media sosial edukatif. Pendekatan yang komunikatif dan sesuai usia remaja terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan perilaku sehat pada remaja putri (Wardhani et al., 2024).

Promosi kesehatan reproduksi merupakan salah satu peran utama bidan dalam pendampingan remaja putri. Promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga organ reproduksi, memahami pubertas, mencegah infeksi saluran reproduksi, dan menghindari perilaku seksual berisiko. Penelitian Reza (2021) menunjukkan bahwa peran bidan dalam edukasi kesehatan reproduksi memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku personal hygiene menstruasi dan pencegahan keputihan pada remaja putri ($p\text{-value} = 0,001$). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan bidan mampu meningkatkan perilaku kesehatan reproduksi remaja.

Selain itu, penelitian Rahayu (2025) menjelaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan bidan efektif dalam mencegah infeksi saluran reproduksi melalui edukasi kebersihan diri, perilaku hidup sehat, dan deteksi dini gangguan reproduksi.

5. Pencegahan Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Anemia pada remaja putri masih menjadi masalah kesehatan yang cukup tinggi akibat kehilangan darah saat menstruasi dan kurangnya asupan zat besi. Dampak anemia meliputi kelelahan, gangguan konsentrasi belajar, penurunan daya tahan tubuh, hingga risiko komplikasi reproduksi di masa depan. Bidan memiliki peran penting dalam pencegahan anemia melalui edukasi gizi seimbang, pemantauan status kesehatan, serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD). Bidan juga memberikan edukasi mengenai cara konsumsi TTD yang benar agar kepatuhan remaja meningkat.

Penelitian Ristanti et al. (2023) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara peran bidan dan kepatuhan konsumsi Tablet Fe pada remaja putri ($p\text{-value} = 0,004$). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa edukasi dan motivasi dari bidan sangat memengaruhi keberhasilan program pencegahan anemia pada remaja. Bidan melakukan edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan

bergizi seimbang, sumber zat besi, pola hidup sehat, serta kepatuhan mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Selain itu, bidan juga melakukan pemantauan konsumsi TTD melalui program kesehatan sekolah maupun posyandu remaja. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan status kesehatan dan kesiapan reproduksi remaja putri (Simbolon et al., 2022).

6. Edukasi Pubertas dan Menstruasi

Pubertas merupakan fase penting dalam perkembangan remaja putri yang ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal. Banyak remaja mengalami kecemasan dan kebingungan ketika menghadapi menstruasi pertama akibat kurangnya informasi yang benar. Dalam hal ini, bidan berperan memberikan edukasi mengenai proses pubertas, perubahan tubuh, siklus menstruasi, kebersihan menstruasi, serta cara mengatasi keluhan saat menstruasi.

Dalam hal ini, bidan berperan memberikan edukasi mengenai perubahan tubuh selama pubertas, siklus menstruasi, kebersihan menstruasi, serta cara mengatasi keluhan menstruasi seperti dismenore dan keputihan. Edukasi pubertas membantu remaja memahami bahwa perubahan tersebut merupakan proses normal dalam perkembangan tubuh perempuan.

Penelitian kesehatan reproduksi remaja menunjukkan bahwa edukasi pubertas yang diberikan tenaga kesehatan mampu meningkatkan kesiapan psikologis remaja dalam menghadapi menstruasi dan meningkatkan praktik personal hygiene menstruasi (Suwarsih et al., 2022).

7. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Reproduksi

Masa remaja sering kali diwarnai perubahan emosional, kecemasan, konflik identitas, serta rasa malu terhadap perubahan tubuh. Oleh sebab itu, bidan berperan sebagai konselor yang membantu remaja memahami kondisi yang dialami dan memberikan dukungan psikologis dasar. Konseling dilakukan dengan prinsip komunikasi terapeutik, empati, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghakimi. Remaja memerlukan ruang aman untuk menyampaikan pertanyaan maupun masalah terkait kesehatan reproduksi, menstruasi, hubungan sosial, maupun kesehatan mental.

Penelitian mengenai pelayanan kesehatan remaja menunjukkan bahwa pendekatan konseling yang ramah remaja dapat meningkatkan keterbukaan remaja dalam berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi dan masalah psikososial (Anggraini et al., 2021). Selain itu, pendekatan konseling yang suportif terbukti membantu remaja meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan coping stress. Bidan memiliki peran penting dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan reproduksi pada remaja putri seperti gangguan menstruasi,

keputihan patologis, infeksi saluran reproduksi, anemia, hingga kelainan payudara.

Deteksi dini dilakukan melalui wawancara kesehatan, observasi, edukasi SADARI, pemeriksaan sederhana, dan konseling kesehatan reproduksi. Apabila ditemukan tanda atau gejala tertentu, bidan dapat memberikan penanganan awal maupun melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Penelitian Kasmara (2023) menunjukkan bahwa promosi kesehatan mengenai SADARI oleh bidan mampu meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara sejak usia muda.

8. Pendampingan Kesehatan Mental Remaja

Selain kesehatan fisik dan reproduksi, bidan juga berperan dalam pendampingan kesehatan mental remaja putri. Masa remaja sering diwarnai tekanan akademik, konflik sosial, perubahan emosional, body image negatif, serta pengaruh media sosial yang dapat memengaruhi kesehatan psikologis remaja. Kondisi tersebut dapat menyebabkan stres, kecemasan, rendah diri, bahkan depresi apabila tidak ditangani dengan baik.

Bidan membantu remaja mengenali kondisi emosionalnya, memberikan dukungan psikologis dasar, serta melakukan konseling sederhana terkait pengelolaan stres dan peningkatan self-esteem. Selain itu, bidan juga bekerja sama dengan keluarga, guru, dan tenaga profesional lainnya apabila ditemukan masalah psikologis yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pendampingan kesehatan mental yang optimal dapat membantu remaja putri tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman (Ramadhaniati et al., 2024).

D. Peran Keluarga dalam Pendampingan Remaja Putri

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang remaja putri. Sebelum memperoleh pendidikan dari sekolah maupun lingkungan sosial, remaja terlebih dahulu belajar dari pola asuh, perilaku, komunikasi, dan nilai-nilai yang diterapkan di dalam keluarga. Pada masa remaja, peran keluarga menjadi sangat penting karena remaja mengalami perubahan biologis, emosional, sosial, dan psikologis yang memerlukan arahan serta dukungan yang tepat. Pendampingan keluarga yang optimal dapat membantu remaja putri tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, memiliki kontrol diri yang baik, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman (Fitriani et al., 2023).

1. Keluarga sebagai Lingkungan Pertama Pendidikan

Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama bagi anak, termasuk dalam pembentukan perilaku kesehatan, karakter, dan kemampuan sosial remaja putri. Orang tua menjadi role model utama yang memengaruhi cara berpikir, sikap, dan kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang diberikan keluarga tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mencakup pendidikan moral, kesehatan, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, keluarga berperan mengenalkan remaja terhadap perubahan tubuh, kebersihan diri, pola hidup sehat, serta nilai-nilai menjaga kehormatan diri sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa remaja putri yang memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi dari keluarga cenderung memiliki pengetahuan dan perilaku kesehatan yang lebih baik dibandingkan remaja yang kurang mendapatkan pendampingan keluarga (Reza, 2021).

Selain itu, lingkungan keluarga yang harmonis dapat membantu remaja mengembangkan rasa aman dan nyaman dalam menghadapi masa pubertas. Sebaliknya, kurangnya perhatian dan pendidikan dalam keluarga dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang, rendahnya self-esteem, dan masalah psikososial pada remaja putri (Nurfadilah et al., 2022).

2. Peran Ibu dan Ayah dalam Komunikasi Kesehatan Reproduksi

Komunikasi kesehatan reproduksi dalam keluarga menjadi aspek penting dalam pendampingan remaja putri. Ibu umumnya memiliki peran dominan dalam memberikan informasi mengenai menstruasi, pubertas, personal hygiene, dan kesehatan reproduksi karena dianggap lebih memahami pengalaman biologis perempuan. Kedekatan emosional ibu dan anak perempuan juga mempermudah proses komunikasi terkait perubahan tubuh dan masalah pribadi remaja.

Namun demikian, peran ayah juga sangat penting dalam membangun rasa aman, perlindungan, serta pembentukan konsep diri remaja putri. Ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan dapat meningkatkan rasa percaya diri anak perempuan dan membantu membentuk perilaku sosial yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kedua orang tua dalam komunikasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan keterbukaan remaja dan mengurangi perilaku berisiko pada masa remaja (Sari & Handayani, 2021).

Komunikasi kesehatan reproduksi yang baik harus dilakukan secara terbuka, santai, tidak menghakimi, dan sesuai usia perkembangan remaja. Orang tua perlu menciptakan suasana yang nyaman agar remaja tidak merasa malu atau takut saat bertanya mengenai perubahan tubuh maupun masalah reproduksi yang dialami. Kurangnya komunikasi dalam keluarga sering menyebabkan remaja

mencari informasi dari sumber yang tidak tepat, termasuk media sosial yang belum tentu valid (Rahmawati et al., 2023).

3. Dukungan Emosional Keluarga

Dukungan emosional keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis remaja putri. Masa remaja merupakan periode yang penuh perubahan emosi akibat pengaruh hormonal dan tekanan sosial. Remaja putri sering mengalami kecemasan, perubahan suasana hati, body image negatif, hingga tekanan akademik dan sosial yang dapat memengaruhi kondisi mental mereka. Keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang, penghargaan, dan dukungan emosional mampu membantu remaja mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan mengelola stres. Dukungan emosional juga membantu remaja merasa diterima dan dihargai sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi kepada orang tua (Fitriani et al., 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa remaja yang mendapatkan dukungan emosional keluarga memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan kemampuan coping stress yang lebih baik dibandingkan remaja dengan dukungan keluarga rendah (Lestari et al., 2022). Oleh karena itu, keluarga perlu membangun hubungan emosional yang hangat agar remaja memiliki ketahanan mental yang baik.

4. Pengawasan Pergaulan dan Penggunaan Media Sosial

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan dampak besar terhadap kehidupan remaja putri. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan komunikasi, tetapi juga berpotensi memberikan pengaruh negatif seperti cyberbullying, paparan pornografi, body shaming, perilaku konsumtif, hingga pergaulan bebas apabila tidak diawasi dengan baik. Keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi pola pergaulan dan penggunaan media sosial remaja. Pengawasan bukan berarti membatasi secara berlebihan, melainkan memberikan arahan, edukasi, dan kontrol yang bijaksana agar remaja mampu menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Orang tua perlu memahami perkembangan digital agar dapat mendampingi remaja menghadapi tantangan dunia maya (Putri et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pengawasan media sosial dapat menurunkan risiko perilaku menyimpang dan meningkatkan kemampuan remaja dalam menyaring informasi digital yang diterima (Rahmawati et al., 2023). Oleh karena itu, literasi digital keluarga menjadi bagian penting dalam pendampingan remaja putri di era modern.

5. Pembentukan Karakter dan Nilai Moral

Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai moral remaja putri. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, sopan santun, empati, kejujuran, dan penghargaan terhadap diri sendiri mulai ditanamkan melalui pola asuh dalam keluarga. Karakter yang baik akan membantu remaja mampu mengambil keputusan yang sehat dan menghindari perilaku berisiko.

Pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Remaja cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua perlu menjadi contoh yang baik dalam komunikasi, pengendalian emosi, perilaku sosial, dan penggunaan media digital (Nurfadilah et al., 2022). Sedangkan penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan pola asuh demokratis cenderung menghasilkan remaja yang memiliki kontrol diri lebih baik, rasa percaya diri tinggi, dan kemampuan sosial yang positif dibandingkan pola asuh otoriter maupun permisif (Lestari et al., 2022).

6. Pola Komunikasi Efektif dengan Remaja

Komunikasi efektif menjadi kunci utama keberhasilan pendampingan remaja putri dalam keluarga. Pada masa remaja, anak mulai mencari identitas diri dan cenderung ingin didengar serta dihargai pendapatnya. Oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga harus dilakukan secara dua arah, terbuka, penuh empati, dan tidak menghakimi. Pola komunikasi efektif dapat dilakukan dengan mendengarkan aktif, memberikan respon positif, menghindari kritik berlebihan, serta menghargai privasi remaja. Orang tua juga perlu memilih waktu yang tepat dalam berdiskusi agar remaja merasa nyaman untuk berbicara mengenai masalah yang dihadapi (Sari & Handayani, 2021).

Komunikasi yang baik terbukti dapat meningkatkan kedekatan emosional antara orang tua dan remaja serta membantu mencegah berbagai masalah perilaku pada remaja putri. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan remaja merasa tidak dipahami sehingga lebih memilih mencari dukungan dari lingkungan luar yang belum tentu memberikan pengaruh positif (Rahmawati et al., 2023). Dengan demikian, keluarga memiliki peran sentral dalam pendampingan remaja putri melalui pendidikan, komunikasi, dukungan emosional, pengawasan, dan pembentukan karakter. Pendampingan keluarga yang optimal akan membantu remaja putri tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan moral.

E. Peran Sekolah dalam Pendampingan Remaja Putri

Sekolah merupakan salah satu lingkungan terpenting dalam proses tumbuh kembang remaja putri karena sebagian besar waktu remaja dihabiskan di lingkungan pendidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, peningkatan kesehatan mental, serta pembinaan perilaku hidup sehat. Dalam konteks pendampingan remaja putri, sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, serta membantu remaja menghadapi berbagai tantangan perkembangan fisik, emosional, dan sosial (Afrila et al., 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif memiliki hubungan erat dengan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan perilaku sehat pada remaja putri. Sekolah yang mampu menyediakan dukungan pendidikan, psikologis, dan sosial dapat membantu remaja meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan adaptasi, serta mencegah berbagai perilaku berisiko selama masa remaja (Zulfatunnisa et al., 2025).

1. Sekolah sebagai Lingkungan Pendukung Perkembangan Remaja

Sekolah berfungsi sebagai lingkungan sosial kedua setelah keluarga yang berpengaruh besar terhadap perkembangan remaja putri. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan suportif mampu membantu remaja mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik secara optimal. Interaksi dengan guru, teman sebaya, dan tenaga kependidikan membentuk kemampuan komunikasi, rasa percaya diri, serta keterampilan sosial remaja. Penelitian Zulfatunnisa et al. (2025) menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang baik berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis remaja putri. Penelitian tersebut menemukan bahwa kondisi sekolah yang kondusif mampu mendukung kesehatan mental dan kesehatan reproduksi remaja. Lingkungan sekolah yang positif juga membantu remaja mengurangi perilaku menyimpang dan meningkatkan perilaku hidup sehat.

Selain itu, sekolah menjadi tempat penting dalam proses pembentukan identitas diri remaja. Dukungan sekolah yang baik akan membantu remaja putri lebih mudah menghadapi perubahan pubertas, tekanan sosial, dan tantangan perkembangan pada masa remaja.

2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah merupakan upaya penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan tubuh dan reproduksi. Pendidikan ini mencakup materi pubertas, menstruasi,

personal hygiene, kesehatan seksual, pencegahan penyakit menular seksual, anemia, serta perilaku hidup sehat. Penelitian Kamila et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan siswa mengenai kesehatan reproduksi dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran sekolah dapat membantu remaja memahami kesehatan reproduksi secara lebih baik.

Penelitian Ropitasari (2024) juga menjelaskan bahwa program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi serta membantu mencegah kehamilan usia dini. Keberhasilan program dipengaruhi oleh metode pembelajaran, keterlibatan guru, serta dukungan sekolah dan keluarga. Selain pembelajaran di kelas, pendidikan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui seminar kesehatan, penyuluhan, peer education, dan media digital interaktif yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi remaja saat ini.

3. Peran Guru dan Konselor

Guru dan konselor memiliki peran penting dalam pendampingan remaja putri di sekolah. Guru tidak hanya bertugas mengajar materi akademik, tetapi juga menjadi pembimbing, motivator, dan role model bagi siswa. Guru dapat membantu remaja memahami nilai-nilai moral, perilaku hidup sehat, serta memberikan dukungan ketika remaja menghadapi masalah akademik maupun sosial. Konselor sekolah berperan dalam membantu remaja mengatasi masalah psikologis, emosional, maupun sosial seperti kecemasan, konflik pertemanan, bullying, body shaming, dan stres akademik. Pendekatan konseling yang ramah remaja dapat membantu siswa merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan masalah yang dihadapi.

Afrila et al. (2024) menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan guru mengenai kesehatan reproduksi menjadi langkah penting dalam keberhasilan pendidikan kesehatan di sekolah. Guru yang memahami kesehatan reproduksi mampu memberikan informasi yang benar dan membantu siswa membangun perilaku sehat. Guru dan konselor juga memiliki peran dalam mendeteksi perubahan perilaku siswa yang dapat menjadi tanda masalah psikologis atau kesehatan reproduksi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini.

4. Fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Unit Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan sarana pelayanan kesehatan di sekolah yang bertujuan meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. UKS memiliki fungsi promotif, preventif, dan kuratif sederhana melalui pendidikan

kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dalam pendampingan remaja putri, UKS berperan memberikan edukasi mengenai pubertas, menstruasi, personal hygiene, anemia, gizi seimbang, dan kesehatan reproduksi. UKS juga menjadi tempat konsultasi awal bagi siswa yang mengalami keluhan kesehatan ringan maupun masalah psikologis sederhana.

Program UKS yang aktif dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. UKS juga berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dengan tenaga kesehatan seperti bidan dan puskesmas dalam pelaksanaan program kesehatan remaja. Penelitian Kamila et al. (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki program kesehatan reproduksi terstruktur dan fasilitas pendukung kesehatan yang baik cenderung menghasilkan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa.

5. Program Kesehatan Remaja di Sekolah

Program kesehatan remaja di sekolah bertujuan meningkatkan kesehatan fisik, reproduksi, mental, dan sosial siswa melalui kegiatan promotif dan preventif. Program tersebut meliputi edukasi kesehatan reproduksi, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pemeriksaan kesehatan berkala, konseling remaja, pendidikan gizi, serta pembentukan kader kesehatan remaja. Penelitian Sambow et al. (2021) menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi melalui media elektronik internet mampu meningkatkan pengetahuan remaja putri secara signifikan setelah intervensi edukasi diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi program kesehatan berbasis digital dapat menjadi strategi efektif dalam pendidikan kesehatan remaja di sekolah. Program kesehatan sekolah juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan organisasi kesehatan remaja sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih komprehensif dan mudah diakses oleh siswa.

6. Pencegahan Bullying dan Kekerasan Seksual

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah serius yang dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental dan perkembangan remaja putri. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying yang menyebabkan remaja mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, bahkan trauma psikologis. Penelitian Nuraisyah dan Kusumawati (2025) menunjukkan bahwa bullying memiliki hubungan erat dengan gangguan kesehatan mental pada remaja seperti stres, kecemasan, dan depresi. Korban bullying cenderung mengalami penurunan harga diri dan kesulitan dalam interaksi sosial. Sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan melalui penerapan kebijakan anti-bullying, edukasi kekerasan seksual, pengawasan lingkungan sekolah, serta layanan konseling bagi korban. Guru dan

konselor perlu melakukan deteksi dini terhadap siswa yang mengalami bullying agar dampak psikologis dapat dicegah sedini mungkin.

Di era digital, cyberbullying juga menjadi ancaman baru bagi remaja putri. Penelitian Ratnayaka et al. (2020) menjelaskan bahwa cyberbullying berdampak negatif terhadap kesehatan psikologis korban dan memerlukan pengawasan serta edukasi literasi digital di lingkungan sekolah.

7. Pembinaan Kesehatan Mental dan Karakter

Sekolah memiliki peran besar dalam pembinaan kesehatan mental dan karakter remaja putri. Masa remaja merupakan fase rentan terhadap tekanan akademik, konflik sosial, perubahan emosional, serta pengaruh media sosial yang dapat memengaruhi kondisi psikologis siswa. Penelitian Mulyati dan Novita (2024) menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan reproduksi remaja putri. Remaja dengan gangguan psikologis cenderung mengalami gangguan menstruasi, nyeri haid, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

Sekolah dapat melakukan pembinaan kesehatan mental melalui layanan konseling, kegiatan pengembangan diri, pendidikan karakter, program anti-stres akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan psikososial siswa. Pembinaan karakter bertujuan membentuk remaja yang disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, empati, serta mampu mengambil keputusan yang sehat. Selain itu, sekolah perlu membangun budaya positif yang menghargai keberagaman, menghormati hak individu, dan menciptakan hubungan sosial yang sehat antar siswa maupun antara siswa dan guru. Lingkungan sekolah yang suportif terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja putri dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

F. Kolaborasi Bidan, Keluarga, dan Sekolah dalam Pendampingan Remaja Putri

Pendampingan remaja putri memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena permasalahan yang dihadapi remaja tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, moral, dan perkembangan lingkungan digital. Oleh sebab itu, kolaborasi antara bidan, keluarga, dan sekolah menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung tumbuh kembang remaja putri agar mampu berkembang secara sehat, mandiri, dan berdaya saing (Anggraini et al., 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan perilaku hidup sehat pada remaja dibandingkan pendekatan yang dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor memungkinkan remaja memperoleh dukungan yang konsisten baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan pelayanan kesehatan (Djuwitaningsih et al., 2022).

1. Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Sinergi lintas sektor merupakan bentuk kerja sama antara tenaga kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan perkembangan remaja. Kolaborasi ini penting karena permasalahan remaja bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Remaja putri membutuhkan dukungan yang konsisten agar mampu memahami perubahan tubuh, mengelola emosi, menghindari perilaku berisiko, serta membangun karakter positif.

Bidan memiliki peran dalam edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berfungsi sebagai support system utama, sedangkan sekolah menjadi lingkungan pendidikan dan pembinaan karakter remaja. Ketika ketiga sektor bekerja secara terintegrasi, proses pendampingan menjadi lebih efektif karena pesan kesehatan dan nilai-nilai positif yang diterima remaja menjadi lebih konsisten.

Penelitian Anggraini et al. (2021) tentang model Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIN SENJA) menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja secara signifikan. Program kolaboratif tersebut membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan remaja dalam membahas masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan lintas sektor mampu meningkatkan akses remaja terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang ramah remaja.

Penelitian Simbolon et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kolaborasi tenaga kesehatan, peer group, dan keluarga efektif meningkatkan kepatuhan remaja putri dalam konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebagai upaya pencegahan anemia dan stunting. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan sekolah memperkuat keberhasilan program kesehatan remaja yang dijalankan oleh tenaga kesehatan.

2. Model Kerja Sama Pendampingan Remaja

Model kerja sama pendampingan remaja merupakan bentuk integrasi peran berbagai pihak dalam membantu remaja mencapai kesehatan fisik, mental, dan sosial secara optimal. Pendekatan kerja sama dapat dilakukan melalui program

sekolah sehat, posyandu remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), peer education, maupun layanan kesehatan remaja berbasis komunitas. Dalam model ini, bidan berperan memberikan edukasi kesehatan reproduksi, konseling, deteksi dini masalah kesehatan, dan pelayanan kesehatan dasar. Sekolah mendukung melalui pendidikan kesehatan, layanan konseling, UKS, dan pembentukan lingkungan yang aman bagi remaja. Sementara itu, keluarga berperan memberikan dukungan emosional, pengawasan, dan pendidikan moral di rumah.

Penelitian Djuwitaningsih et al. (2022) menunjukkan bahwa model edukasi dan konseling berbasis m-health yang melibatkan tenaga kesehatan dan sekolah efektif meningkatkan kemampuan remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksi. Penggunaan teknologi digital mempermudah remaja memperoleh informasi kesehatan yang cepat dan sesuai kebutuhan generasi saat ini.

Selain itu, penelitian Mayasari et al. (2023) mengenai pembentukan kader kesehatan remaja menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah dan tenaga kesehatan dalam pembinaan kader mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi. Kader kesehatan remaja berfungsi sebagai agen edukasi sebaya yang membantu penyebaran informasi kesehatan secara lebih efektif di lingkungan sekolah. Model kerja sama lainnya adalah pendekatan peer counseling atau konseling sebaya. Penelitian Ramadhaniati et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan konseling sebaya mampu meningkatkan keterbukaan remaja dalam membahas masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan mental karena remaja merasa lebih nyaman berdiskusi dengan teman seusia.

3. Program Kesehatan Remaja Berbasis Komunitas

Program kesehatan remaja berbasis komunitas merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan remaja melalui kegiatan promotif dan preventif. Program ini melibatkan sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, kader kesehatan, organisasi remaja, dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk program berbasis komunitas adalah posyandu remaja yang menyediakan layanan edukasi kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan sederhana, konseling, serta pembinaan kesehatan mental remaja. Posyandu remaja menjadi sarana penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi remaja secara lebih dekat dan ramah.

Penelitian Wardhani et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan kesehatan reproduksi berbasis komunitas di daerah pedesaan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja putri mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat. Program berbasis komunitas

dinilai efektif karena melibatkan lingkungan sosial remaja secara langsung sehingga edukasi lebih mudah diterima.

Selain itu, penelitian Hayu et al. (2024) tentang program GIAT RESAKESPRO (Gerakan Remaja Putri Sadar Kesehatan Reproduksi) menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman remaja mengenai pubertas, menstruasi, dan personal hygiene secara signifikan. Program tersebut juga membantu meningkatkan partisipasi keluarga dan sekolah dalam pendampingan remaja putri. Program berbasis komunitas juga dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi kesehatan remaja. Pemanfaatan media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform edukasi online menjadi inovasi yang efektif dalam menjangkau remaja di era digital.

4. Pendampingan Terpadu untuk Kesehatan Reproduksi dan Mental Remaja

Pendampingan terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan reproduksi, kesehatan mental, pendidikan, dan dukungan sosial dalam satu sistem pelayanan remaja. Pendekatan ini penting karena kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, serta perkembangan sosial. Remaja putri yang mengalami tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, bullying, dan body shaming cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti gangguan menstruasi, dismenore, dan perilaku kesehatan yang buruk. Oleh sebab itu, pendampingan tidak cukup hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi mental dan emosional remaja.

Penelitian Mulyati dan Novita (2024) menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan reproduksi pada remaja putri. Remaja dengan tingkat stres tinggi lebih banyak mengalami gangguan menstruasi dan masalah psikologis lainnya. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya terpadu dalam pendampingan remaja. Pendampingan terpadu dapat dilakukan melalui kerja sama bidan, guru Bimbingan Konseling (BK), konselor, psikolog, keluarga, dan kader kesehatan remaja. Bidan berperan memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan dasar, sementara konselor dan keluarga membantu mendukung kesehatan mental serta perkembangan emosional remaja. Penelitian Benavides et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis digital dan komunitas mampu meningkatkan perilaku hidup sehat serta kesehatan mental remaja secara signifikan. Pendekatan ini efektif karena mengintegrasikan edukasi kesehatan, dukungan psikologis, dan partisipasi aktif remaja dalam proses pendampingan.

Dengan demikian, kolaborasi bidan, keluarga, dan sekolah menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pendampingan remaja putri yang komprehensif. Pendekatan kolaboratif dan terpadu terbukti mampu meningkatkan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kualitas hidup remaja sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi perempuan yang sehat, mandiri, dan berkualitas.

G. Simpulan

Pendampingan remaja putri merupakan proses penting dalam mendukung tumbuh kembang remaja agar sehat secara fisik, reproduksi, mental, sosial, dan spiritual. Masa remaja adalah periode transisi yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial sehingga remaja membutuhkan bimbingan serta dukungan yang tepat dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peran bidan, keluarga, dan sekolah menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan edukatif bagi remaja putri.

Bidan berperan sebagai edukator, konselor, dan fasilitator pelayanan kesehatan remaja melalui pemberian edukasi kesehatan reproduksi, pubertas, menstruasi, pencegahan anemia, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), serta deteksi dini masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Pendampingan yang dilakukan bidan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku hidup sehat pada remaja putri.

Keluarga sebagai lingkungan pertama pendidikan memiliki peran besar dalam pembentukan karakter, komunikasi, nilai moral, dan dukungan emosional remaja. Pola komunikasi yang terbuka dan dukungan keluarga yang baik membantu remaja lebih percaya diri, mampu mengelola emosi, serta terhindar dari perilaku berisiko. Selain itu, sekolah juga memiliki peran strategis melalui pendidikan kesehatan reproduksi, layanan bimbingan konseling, UKS, program kesehatan remaja, serta pencegahan bullying dan kekerasan seksual.

Kolaborasi antara bidan, keluarga, dan sekolah menjadi kunci utama dalam pendampingan remaja putri secara holistik dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor memungkinkan terciptanya program kesehatan remaja yang lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta kualitas hidup remaja. Dengan pendampingan yang optimal, diharapkan remaja putri mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, mandiri, berakarakter, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman secara bijaksana.

Referensi

- Afrila, S., Aisyaroh, N., & Rahmawati, M. (2024). Peran sekolah dalam promosi kesehatan reproduksi pada remaja. *Action Research Literate*, 8(3), 210–218.
- Anggraini, D. I., Warganegara, E., Apriliana, E., Carolia, N., Sari, M. I., & Imantika, E. (2021). Model “PIN SENJA” (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 9(1), 45–52.
- Benavides, C., Benítez-Andrades, J. A., Marqués-Sánchez, P., & Arias, N. (2024). eHealth intervention to improve health habits in the adolescent population: Mixed methods study.
- Djuwitaningsih, S., Syafdewiyani, S., Desmarnita, U., & Lestari, P. H. (2022). Penerapan edukasi dan konseling berbasis m-health dalam meningkatkan kemampuan remaja putri untuk menjaga kesehatan reproduksi pada era adaptasi baru. *Prosiding Seminar Nasional Hilirisasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 85–92.
- Fitriani, D., Rahman, A., & Putri, S. (2023). Family support and adolescent girls' readiness facing puberty. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Remaja*, 8(2), 115–123.
- Hayu, R., Amir, A. Y., Jesica, F., & Pebrina, M. (2024). Edukasi GIAT RESAKESPRO (Remaja Putri Sadar Kesehatan Reproduksi). *Jurnal Abdimas Saintika*, 6(1), 12–18.
- Kasmara, D. P. (2023). Peran bidan dalam memberikan promosi kesehatan terhadap SADARI pada remaja putri di UPT Puskesmas Sigumpar. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*, 2(2), 34–40.
- Kamila, A., Handayani, F., & Nurhayati, N. (2021). Analisis penerapan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi berbasis program. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(4), 245–253.
- Lestari, R., Wulandari, D., & Hidayati, N. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan kesehatan mental remaja putri. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 10(1), 45–53.
- Nurhayati, E., & Rahmawati, I. (2022). School-based reproductive health education and healthy behavior among adolescent girls. *Indonesian Journal of Public Health*, 17(1), 45–53.
- Nurfadilah, N., Hasanah, U., & Kurniawati, D. (2022). Pola asuh keluarga dalam pembentukan karakter remaja putri di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 4(2), 88–97.

- Nurvitasari, R. D., Utami, E. S., Qutsiah, S. M., & Khatijah, S. (2022). Upaya peningkatan pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi melalui peer group education. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Qodiri*, 1(3), 55–63.
- Mayasari, S. I., Jayanti, N. D., & Amalia, W. (2023). Pembentukan kader kesehatan remaja (KKR) dan pendampingan pendidikan kesehatan pada remaja putri. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 6(1), 1010–1018.
- Mulyati, I., & Novita, L. (2024). Analisis kesehatan mental dan kesehatan reproduksi pada remaja putri di salah satu sekolah menengah tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 115–123.
- Nuraisyah, A., & Kusumawati, H. (2025). Bullying dan masalah kesehatan mental pada remaja. *Medical Nurse Journal*, 2(2), 41–52.
- Sari, M., & Handayani, L. (2021). The role of midwives in reproductive health education among adolescent girls. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(3), 210–218.
- Permatasari, D., Suprayitno, E., Rasyidah, R., Damayanti, C. N., & Wahid, A. (2022). Pendampingan remaja putri dalam edukasi kesehatan reproduksi di Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan. *JABB: Jurnal Abdimas Bhakti Bangsa*, 3(1), 166–172.
- Putri, A. N., Safitri, E., & Amelia, R. (2024). Peran keluarga dalam pengawasan penggunaan media sosial pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 21–30.
- Rahayu, P. P. (2025). Peran bidan dalam pencegahan infeksi saluran reproduksi melalui pendekatan promotif dan preventif. *Health & Medical Sciences*, 3(2), 120–128.
- Rahmawati, I., Nurhayati, E., & Sari, M. (2023). Komunikasi orang tua dan literasi digital remaja putri dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 14(2), 102–111.
- Ramadhaniati, F., Kurniati, N., Yulyani, L., & Novianti, N. (2024). Pendampingan konseling sebaya remaja peduli kesehatan reproduksi. *LINK*, 21(1), 45–53.
- Ratnayaka, G., Atapattu, T., Herath, M., Zhang, G., & Falkner, K. (2020). Enhancing the identification of cyberbullying through participant roles.
- Reza, C. R. (2021). Peran ibu dalam pendidikan kesehatan reproduksi, peran bidan, personal hygiene menstruasi terhadap kejadian keputihan pada remaja putri. *Indonesian Scholar Journal of Nursing and Midwifery Science*, 1(1), 27–35.
- Reza, C. R. (2021). Peran ibu dalam pendidikan kesehatan reproduksi terhadap perilaku personal hygiene menstruasi remaja putri. *Indonesian Scholar Journal of Nursing and Midwifery Science*, 1(1), 27–35.

- Ristanti, Y. E., Fatimah, J., & KD, M. (2023). Hubungan peran serta kader, peran bidan dan motivasi dengan kepatuhan konsumsi tablet Fe untuk persiapan reproduksi remaja putri di Desa Ciherang Tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1649–1662.
- Ropitasari, R. (2024). Evaluasi program pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja di sekolah-sekolah menengah dalam mengurangi angka kehamilan usia dini. *Jurnal Ners*, 8(2), 1360–1365.
- Sambow, R. M., Kundre, R. M., & Meo, M. L. N. (2021). Pengaruh pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi melalui media elektronik internet terhadap tingkat pengetahuan remaja putri di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 85–93.
- Sari, M., & Handayani, L. (2021). Peran orang tua dalam komunikasi kesehatan reproduksi pada remaja putri. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(3), 210–218.
- Sartika, D., Fauziah, F., & Azhara, S. (2024). Analisis determinan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja putri di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 112–120.
- Sholichah, N. (2022). Penyuluhan TRIAD KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja). *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 1113–1118.
- Simbolon, D., Batbual, B., & Ludji, I. D. R. (2022). Pembinaan perilaku remaja putri dalam perencanaan keluarga dan pencegahan anemia melalui pemberdayaan peer group sebagai upaya pencegahan stunting. *Media Karya Kesehatan*, 5(2), 211–220.
- Suwarsih, S., Windayanti, H., & Aulia, P. L. (2022). Pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi. *Prosiding Seminar Nasional dan CFP Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 1(1), 55–61.
- Yani, E. R., Hardjito, K., & Suwoyo, S. (2022). Pendampingan siswa oleh kader “GEMPI KESPRO” generasi muda peduli kesehatan reproduksi di SMPIT Bina Insani Kota Kediri. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1), 33–40.
- World Health Organization. (2022). *Adolescent health*. [World Health Organization](https://www.who.int/health-topics/adolescent-health)
- Wardhani, P. C. (2025). Strategi bidan dalam memberdayakan kesehatan reproduksi remaja di komunitas pedesaan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(4), 221–230.
- Zhao, N., Yang, S., Zhang, Q., Wang, J., Xie, W., Tan, Y., & Zhou, T. (2023). School bullying results in poor psychological conditions: Evidence from a survey of 95,545 subjects.

Glosarium

BK	= Bimbingan Konseling
PIN SENJA	= Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PIK-R	= Pusat Informasi Konseling Remaja
UKS	= Unit Kesehatan Sekolah
SADARI	= Pemeriksaan Payudara Sendiri
TTD	= Tablet Tambah Darah



CHAPTER 7



EVALUASI PROGRAM EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi pada remaja merujuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada individu berusia 10-19 tahun. Masa remaja merupakan periode peralihan yang ditandai oleh perubahan biologis (pubertas), psikologis, dan sosial yang besar, yang membuat individu mulai mengalami perkembangan organ reproduksi serta minat dalam hubungan interpersonal dan seksual. Sayangnya, perkembangan ini sering kali tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, mengakibatkan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan. Untuk itu, edukasi kesehatan reproduksi menjadi aspek yang krusial dalam membentuk perilaku sehat dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat bagi remaja (*Suwarno, 2026*).

Secara internasional, isu kesehatan reproduksi di kalangan remaja tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Menurut data dari WHO, kelompok remaja mencakup sekitar 1,3 miliar populasi di seluruh dunia, yang memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang rumit dan beragam. Setiap tahunnya, sekitar 12 juta perempuan remaja berusia antara 15-19 tahun melahirkan, sedangkan sekitar 3,9 juta lainnya mengalami aborsi yang tidak aman. Di samping itu, remaja berusia 15-24 tahun menyumbang sekitar 25% dari total infeksi baru untuk penyakit menular seksual (IMS) secara global, termasuk infeksi HIV. Angka yang tinggi ini mengindikasikan bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap isu kesehatan reproduksi, terutama di negara-negara berkembang di mana akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas (*Tresnayanti et al., 2025*).

Di level nasional, Indonesia juga berhadapan dengan masalah serius terkait kesehatan reproduksi remaja. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 19% remaja yang berusia 14-19 tahun pernah mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan ada peningkatan jumlah kasus infeksi menular seksual di kelompok usia 15-24 tahun. Selain itu, laporan dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan terjadinya kenaikan kasus IMS pada remaja di rentang usia 15-19 tahun mencapai 42,4% dalam setahun

terakhir. Situasi ini mencerminkan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta minimnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang sesuai untuk remaja (*Pratiwi Dewi, 2025*).

Kesehatan reproduksi pada remaja dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terhubung, baik dari sisi individu maupun lingkungan. Faktor-faktor ini mencakup aspek biologis seperti perubahan hormon dan kematangan alat reproduksi, psikologis yang terdiri dari emosi, kemampuan mengontrol diri, serta perkembangan identitas. Selain itu, faktor sosial dan budaya termasuk norma, nilai, dan dampak dari lingkungan juga memainkan peran penting, ditambah dengan akses terhadap informasi serta layanan kesehatan. Sebagai tambahan, kemajuan teknologi dan media sosial berkontribusi dalam membangun pemahaman dan perilaku remaja, baik dengan efek positif maupun negatif. Minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan paparan informasi yang salah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku seksual yang berisiko di kalangan remaja (*Agustin et al., 2026*).

Berbagai isu terkait kesehatan reproduksi di kalangan remaja yang sering muncul antara lain kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi yang ditularkan secara seksual, perilaku seksual yang berisiko, aborsi yang tidak aman, serta rendahnya penggunaan alat kontrasepsi. Di samping itu, masalah lain seperti kekerasan seksual, akses terhadap pornografi, dan terbatasnya fasilitas layanan kesehatan reproduksi juga semakin memperburuk situasi yang dialami oleh remaja. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial, serta dapat berpengaruh pada kualitas hidup remaja di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya menyeluruh melalui program-program edukasi yang efektif mengenai kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam merawat kesehatan reproduksi mereka (*Kusumawardani Arine et al., 2026*).

B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi di kalangan remaja tidak hanya terkait dengan masalah medis yang menandakan tidak adanya penyakit pada organ-organ penting, tetapi juga melibatkan kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan penjelasan WHO, definisi ini sangat komprehensif dan mencakup hak remaja untuk menerima pendidikan, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan dilindungi dari tindakan kekerasan yang berhubungan dengan gender. Ini menuntut remaja untuk memiliki pemahaman dan tanggung jawab

penuh terhadap tubuh mereka sehingga mereka dapat mengelola kesehatan reproduksi dengan baik secara mandiri (*Astuti et al., 2023*).

Perempuan memiliki peran penting sebagai pusat dalam layanan kesehatan reproduksi karena mereka adalah pengguna utama dari layanan ini. Kesehatan reproduksi yang ideal dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana semua fungsi dan proses reproduksi berlangsung dengan baik tanpa adanya hambatan, cacat, atau masalah kesehatan. Selain itu, setiap orang, khususnya perempuan, berhak untuk menikmati kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta memiliki kendali penuh dalam merencanakan kehamilan dan membentuk keluarga (*Saleha et al., 2024*).

Secara biologis, masa remaja ditandai oleh peralihan besar ke arah kematangan reproduksi yang diaktifkan oleh pekerjaan sistem Hipotalamus-Pituitari-Gonadal (HPG). Lonjakan hormon gonadotropin memicu munculnya karakteristik seksual sekunder, seperti pengembangan payudara bagi perempuan dan peningkatan ukuran testis pada laki-laki. Kematangan ini diawasi secara medis melalui Skala Tanner dan mencapai puncaknya saat menarke atau ejakulasi, yang menunjukkan bahwa sistem reproduksi secara fungsional telah siap (*Sholikhah et al., 2025*).

Namun, kemajuan fisik ini tidak selalu sejalan dengan kematangan sistem saraf, di mana terdapat perbedaan antara sistem limbik dan bagian depan otak. Karena sistem limbik yang berkaitan dengan emosi tumbuh lebih cepat dibandingkan area yang mengatur logika, anak muda sering memperlihatkan perilaku yang reaktif serta impulsif. Fenomena egosentrisme pada remaja, di mana mereka merasa istimewa dan kebal terhadap bahaya, seringkali menjadi kendala besar dalam membuat keputusan yang rasional terkait dengan perilaku kesehatan yang mereka jalani sehari-hari (*Rohmawati, 2023*).

Dalam aspek sosial, anak muda memasuki tahap penemuan identitas di mana perhatian interaksi beralih dari rumah ke kelompok sebaya. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial menyebabkan adanya tekanan kuat untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Jika proses individuasi ini tidak didukung oleh komunikasi yang baik antara generasi, maka akan muncul potensi untuk konflik dan tensi dalam hubungan saat remaja berusaha mencari kemandirian (*Sholikhah et al., 2025*).

Keberhasilan dalam kesehatan reproduksi sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan, sikap, dan kondisi ekonomi. Remaja yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Di sisi lain, keterbatasan

dalam aspek ekonomi sering kali menjadi penghalang bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat, yang pada gilirannya dapat membuat mereka terjerumus dalam pandangan dan tindakan seksual yang berisiko tinggi. (*Citrawati, 2022*).

elemen pendukung serta pendorong dari lingkungan eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku remaja. Tersedianya layanan kesehatan yang terjangkau dan akses ke informasi digital berfungsi sebagai sarana pendukung, sedangkan dukungan langsung dari orang tua dan adanya layanan medis yang "sahabat remaja" berperan sebagai pendorong utama. Tanpa adanya pengaturan informasi dan komunikasi yang terbuka, pengaruh negatif dari teman sebaya atau norma sosial yang memberikan kebebasan terhadap perilaku seksual dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan serta risiko infeksi menular seksual.

Selain elemen lingkungan, hak kesehatan reproduksi juga mencakup perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan yang berbasis gender, yang sering kali menjadi target remaja perempuan. Ini sangat penting karena tanpa adanya keamanan yang melindungi secara hukum dan sosial, pengetahuan yang diperoleh remaja tidak akan dapat diterapkan secara optimal. Layanan kesehatan yang menyeluruh harus memastikan bahwa setiap remaja menerima perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, sehingga mereka merasa memiliki kekuatan untuk melaporkan ancaman terhadap kesehatan atau kekerasan yang mereka hadapi

Kematangan biologis yang ditandai oleh menarke atau ejakulasi juga menciptakan akibat klinis yang membutuhkan pengawasan jangka panjang. Skala Tahapan Tanner digunakan tidak hanya untuk mengukur pertumbuhan fisik, tetapi juga berfungsi sebagai indikator awal jika ada masalah hormonal yang bisa menghalangi fungsi reproduksi di kemudian hari. Ketidaksesuaian antara usia kronologis dan kematangan biologis sering kali memerlukan tindakan medis yang tepat agar transisi menuju kedewasaan tidak terhambat oleh masalah kesehatan fisik yang bersifat permanen (*Sholikhah et al., 2025*).

Di sisi lain, salah satu hambatan utama pada perilaku anak muda adalah fenomena "mitos pribadi" di mana mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan terkena dampak negatif. Ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh dominasi sistem limbik membuat remaja kesulitan untuk membandingkan keuntungan jangka panjang dengan kepuasan yang segera. Oleh karena itu, strategi kesehatan reproduksi seharusnya tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi medis, melainkan juga perlu mencakup pelatihan keterampilan hidup agar mereka dapat mengendalikan dorongan impulsif serta menolak pengaruh negatif dari sekitarnya.

Peran teknologi serta media digital pada faktor pendukung saat ini telah mengubah cara kita mencari informasi tentang kesehatan. Media digital dapat berfungsi sebagai alat edukasi yang luas dan cepat, tetapi tanpa keterampilan literasi kesehatan yang baik, remaja menjadi lebih rentan terhadap konten yang dapat menormalisasi perilaku seksual yang berisiko. Pengendalian informasi dari lingkungan sekitar tidak dimaksudkan untuk menghalangi akses, tetapi untuk membantu remaja dalam menyaring informasi yang benar dan berbasis ilmiah di tengah banyaknya informasi palsu.

Sinergi antara faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong menjadi elemen krusial dalam mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan serta penyebaran infeksi menular seksual (IMS). Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi perlu dianggap sebagai investasi yang berjangka panjang yang melibatkan keterlibatan aktif dari sekolah, orang tua, dan penyedia layanan kesehatan. Dengan membangun ekosistem yang mendorong komunikasi yang terbuka, remaja akan memiliki dasar yang kokoh untuk mengambil keputusan yang bijak mengenai tubuh dan masa depan mereka sendiri (*Citrawati, 2022*).

C. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Edukasi tentang kesehatan reproduksi untuk remaja adalah suatu proses yang melibatkan penyampaian informasi, proses belajar, serta pembentukan sikap pada remaja mengenai kesehatan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, perilaku seksual yang sehat, dan langkah-langkah pencegahan terhadap masalah reproduksi. Proses pendidikan ini tidak hanya memperhatikan aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, moral, dan spiritual yang berkaitan dengan perkembangan diri remaja. Periode remaja adalah fase perubahan yang ditandai oleh rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga remaja membutuhkan informasi yang akurat dan menyeluruh agar mampu membuat keputusan yang baik mengenai reproduksi mereka. Pentingnya edukasi kesehatan reproduksi menjadi lebih jelas oleh karena pemahaman remaja yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan perilaku seksual yang berisiko, kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, dan juga kekerasan seksual (*Rukmady Gaffar et al., 2022*).

Kesehatan reproduksi pada kalangan remaja secara umum berfokus pada keadaan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan erat dengan sistem reproduksi. Dengan demikian, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi tidak dapat hanya dianggap sebagai penyampaian informasi mengenai organ reproduksi, tetapi juga sebagai upaya untuk memberdayakan remaja agar dapat lebih mengenal tubuh mereka, menjaga kebersihan organ reproduksi, memiliki rasa menghargai diri, dan

mengembangkan sikap yang bertanggung jawab. Edukasi yang baik dapat membantu remaja untuk memahami perubahan yang terjadi selama pubertas, menjaga kesehatan menstruasi mereka, menghindari perilaku seksual yang berisiko, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan dunia digital (*Nanda et al., 2025*).

Tujuan utama dari edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja ialah untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk pandangan positif, serta mendorong perilaku yang sehat pada kalangan remaja. Edukasi ini bertujuan agar remaja memiliki pemahaman yang tepat tentang fungsi reproduksi, masa pubertas, siklus menstruasi, mimpi basah, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, serta potensi bahaya dari perilaku seksual yang bebas. Selain itu, edukasi kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam membuat keputusan yang bijaksana, mengasah keterampilan komunikasi interpersonal, dan menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi sejak usia muda. Program edukasi yang efektif dapat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan hidup sehingga mereka dapat menghindari perilaku berisiko dan membangun pola hidup yang sehat (*Chapsah et al., 2022*).

Selain dari tujuan pencegahan, edukasi kesehatan reproduksi juga memiliki fokus pada aspek promosi dan perkembangan. Dalam konteks promosi, edukasi ini berkontribusi pada peningkatan mutu kesehatan remaja dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri, pola makan yang baik, kesehatan mental, dan menjalin hubungan sosial yang positif. Di sisi perkembangan, edukasi ini membantu remaja untuk mengenali identitas diri, memahami perkembangan emosi, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, edukasi kesehatan reproduksi tidak hanya ditujukan untuk menghindari penyakit atau perilaku seksual yang tidak semestinya, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan remaja secara menyeluruh menuju kehidupan dewasa yang sehat dan produktif (*Fatmawati Yuli et al., 2024*).

Pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi untuk remaja perlu mempertimbangkan dasar-dasar pendidikan yang sesuai dengan karakteristik perkembangan mereka. Salah satu dasar penting adalah kesesuaian usia, di mana materi yang disampaikan harus selaras dengan tahap perkembangan fisik, emosional, dan kognitif remaja. Pada tahap remaja awal, fokus materi sebaiknya pada pubertas, kebersihan pribadi, dan perubahan fisik, sedangkan untuk remaja yang lebih tua, topik dapat mencakup hubungan antarpribadi, perilaku seksual yang sehat, serta tanggung jawab dalam reproduksi. Dasar lainnya adalah keterbukaan serta akurasi informasi, di mana edukasi harus diberikan dengan bahasa yang jelas,

berbasis ilmiah, dan tidak menyesatkan agar remaja dapat memahami dengan tepat (*Rukmady Gaffar et al., 2022*).

Prinsip edukasi kesehatan reproduksi seharusnya mencakup partisipasi aktif dan fokus pada remaja. Dalam kegiatan belajar, penting bagi remaja untuk mempunyai ruang guna mengajukan pertanyaan, melakukan diskusi, dan menyampaikan pendapat mereka secara proaktif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan bernilai. Aspek kerahasiaan serta penghormatan terhadap hak-hak remaja merupakan hal yang sangat krusial agar mereka merasa nyaman ketika menerima maupun membicarakan informasi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Lebih jauh, edukasi harus memperhatikan nilai-nilai budaya, keyakinan agama, dan norma sosial yang ada di lingkungan sekitar sehingga bahan ajar dapat diterima dengan baik tanpa menciptakan penolakan dari masyarakat (*Chapsah et al., 2022*).

Dalam implementasinya, metode pembelajaran yang diterapkan dalam edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja harus sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik generasi muda saat ini. Salah satu metode yang sering dipakai adalah student centered learning, yang menjadikan remaja sebagai individu aktif dalam proses pendidikan. Metode ini memberikan kesempatan bagi remaja untuk mencari informasi, berdiskusi, serta menyelesaikan masalah baik secara individu maupun dalam kelompok. Metode partisipatif dianggap lebih efektif dibandingkan dengan cara ceramah tradisional, karena dapat meningkatkan keterlibatan emosional dan pemahaman remaja terhadap materi yang diajarkan (*Chapsah et al., 2022*).

Pendekatan pendidikan sebaya atau peer education merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam program kesehatan reproduksi remaja. Dalam pendekatan ini, para remaja berperan sebagai pendidik untuk memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya. Remaja biasanya lebih merasa nyaman untuk berdiskusi dengan sesama remaja karena mereka memiliki pengalaman dan cara berkomunikasi yang serupa. Metode ini berpotensi meningkatkan penerimaan informasi, membangun rasa percaya diri, serta memperkuat dukungan sosial antara remaja dalam menjalani perilaku yang sehat. Di samping itu, pendekatan yang menggunakan teknologi digital juga semakin maju dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi pembelajaran, video animasi, dan platform pendidikan daring yang lebih menarik bagi generasi digital saat ini (*Rohman et al., 2025*).

Metode edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja sangat bervariasi dan bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik audiens. Metode ceramah masih banyak diterapkan karena mudah untuk digunakan pada kelompok besar dan efektif dalam menyampaikan informasi dasar. Namun, pendekatan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, brainstorming, simulasi, bermain

peran, dan studi kasus dianggap lebih efisien dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan berpikir kritis pada remaja. Metode yang melibatkan partisipasi membolehkan remaja lebih terlibat dalam memahami isu kesehatan reproduksi dan melatih kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang baik (*Yusnia et al., 2022*).

Selain metode edukasi, sarana edukasi juga memiliki peran yang sangat berarti dalam suksesnya program kesehatan reproduksi bagi remaja. Sarana yang dipakai bisa berupa brosur, buku kecil, spanduk, presentasi powerpoint, video edukasi, animasi, multimedia interaktif, atau aplikasi berbasis digital. Penggunaan media audio visual telah terbukti lebih berhasil dalam meningkatkan pengetahuan serta sikap remaja jika dibandingkan dengan media cetak tradisional, karena merangsang kedua indera, yaitu penglihatan dan pendengaran, secara bersamaan. Video dan animasi memiliki kemampuan untuk menarik perhatian remaja, meningkatkan keinginan untuk belajar, dan membantu dalam menyampaikan informasi yang rumit sehingga menjadi lebih mudah dimengerti (*Wahyuni & Arisani, 2022*).

Pengembangan media edukasi tentang kesehatan reproduksi yang kreatif sangat krusial untuk menyesuaikan dengan sifat generasi digital yang ada saat ini. Alat interaktif yang berbasis multimedia memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik melalui perpaduan teks, gambar, suara, video, dan animasi. Selain mampu meningkatkan pengetahuan, alat pembelajaran yang inovatif juga dapat mendorong partisipasi remaja dalam proses pendidikan dan mempermudah evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan cara dan alat edukasi yang sesuai menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja (*Rohman et al., 2025*).

D. Konsep Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Masa remaja merupakan fase transisi biologis, psikologis, dan sosial yang ditandai dengan berkembangnya fungsi reproduksi dan pencarian jati diri, sehingga remaja sangat rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi. Di berbagai negara, tingginya rasa ingin tahu seksual yang tidak disertai informasi akurat berkontribusi pada perilaku seksual berisiko, kehamilan remaja, kekerasan dan eksploitasi seksual, aborsi tidak aman, serta meningkatnya kasus IMS dan HIV/AIDS. WHO melaporkan bahwa satu dari lima remaja aktif secara seksual sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 21 juta remaja putri berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya pengetahuan, sikap permisif terhadap perilaku seksual, serta keterbatasan akses terhadap edukasi reproduksi yang kredibel. Situasi

serupa juga terjadi di Indonesia, di mana data SDKI menunjukkan peningkatan perilaku seksual pranikah yang berdampak pada kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah, aborsi remaja, serta kontribusi signifikan terhadap kasus IMS dan HIV/AIDS (Pratiwi & Lismayanti, 2026).

Kesehatan reproduksi remaja merupakan isu yang multidimensional karena mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. WHO (2021) mendefinisikan kesehatan reproduksi remaja sebagai kondisi sehat secara utuh, baik fisik, mental, maupun sosial, yang memungkinkan remaja menjalani kehidupan seksual yang aman, bertanggung jawab, serta terbebas dari diskriminasi maupun kekerasan. Pada remaja putri, permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan pengetahuan tentang pubertas, praktik kebersihan menstruasi yang tidak memadai, tingginya kerentanan terhadap kehamilan dini, hingga risiko tertular infeksi menular seksual. Di Indonesia, problem ini semakin kompleks karena masih tingginya angka pernikahan usia muda dan kehamilan remaja. SDKI (2017) dan Kemenkes RI (2021) mencatat bahwa sekitar 7% remaja perempuan berusia 15–19 tahun sudah pernah hamil, sementara pernikahan dini masih marak di berbagai wilayah (Agma, 2025).

Tujuan utama dari konsep program edukasi kesehatan reproduksi yang dipaparkan dalam jurnal tersebut adalah untuk melakukan transformasi pengetahuan dan perilaku remaja melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini berupaya memutus rantai ketidaktahuan serta stigma negatif seputar kesehatan reproduksi dengan cara mengintegrasikan literasi kesehatan mental dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagai satu kesatuan materi yang krusial bagi tumbuh kembang siswa. Dengan sasaran utama pada penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di lingkungan sekolah, program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang selama ini dianggap tabu.

Selain aspek kognitif, program ini memiliki tujuan strategis untuk memberdayakan remaja sebagai subjek aktif melalui pelatihan keterampilan teknis dalam penggunaan media digital, seperti platform Canva. Hal ini dilakukan agar siswa mampu memproduksi materi edukasi visual secara mandiri yang kemudian disebarkan kepada teman sebaya mereka. Melalui pembentukan "Duta PROTEKSI", program ini bertujuan membangun sistem pendidik sebaya (*peer educator*) yang efektif, di mana informasi mengenai anatomi tubuh, risiko Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, hingga konsep persetujuan (*consent*) dan perencanaan masa depan dapat dikomunikasikan dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh sesama remaja. Pada akhirnya, tujuan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja secara signifikan, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan skor pengetahuan pasca-pelatihan,

serta mendorong kesiapan mereka dalam menjalankan fungsi keluarga yang sehat di masa depan (*Yunus et al., 2025*).

Prinsip edukasi kesehatan reproduksi berbasis digital bagi generasi muda usia produktif disusun dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses terhadap informasi yang akurat, menyeluruh, dan selaras dengan nilai budaya pada era Revolusi Industri. Upaya ini ditujukan untuk menjawab berbagai hambatan pada layanan konvensional, misalnya keterbatasan jangkauan wilayah dan rendahnya literasi kesehatan, yang berkontribusi pada meningkatnya risiko pernikahan dini serta kehamilan yang tidak direncanakan. Secara konseptual dan teknis, intervensi ini memanfaatkan pendekatan yang berpusat pada pengguna (*user-centered design*) serta teori perilaku, seperti *Health Belief Model* (HBM) dan *Social Cognitive Theory* (SCT), untuk memperkuat efikasi diri (*self-efficacy*) dan keterampilan komunikasi individu dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Dengan dukungan berbagai sarana seperti aplikasi *mobile*, permainan edukatif (*gamification*), *chatbot* AI, serta media sosial, edukasi digital dapat membantu menjaga anonimitas pengguna sekaligus menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan lebih personal.

Walaupun Prinsip digital terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan (domain kognitif) dan sikap (domain afektif), prinsip utamanya menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya penentu. Perubahan perilaku jangka panjang membutuhkan dukungan ekosistem pada berbagai level. Oleh karena itu, program digital perlu diintegrasikan dengan layanan kesehatan primer, serta didukung oleh keterlibatan keluarga, sekolah, dan pembuat kebijakan agar intervensi dapat berkelanjutan. Di samping itu, perlindungan privasi serta etika digital merupakan elemen penting, khususnya karena remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap misinformasi. Secara keseluruhan, edukasi kesehatan reproduksi digital dipandang bukan hanya sebagai kanal penyampaian informasi, tetapi sebagai instrumen transformasi yang menggabungkan dasar ilmiah dengan fleksibilitas teknologi untuk menghasilkan dampak kesehatan yang lebih luas, adaptif, dan relevan bagi generasi muda (*Handayani Kasmini Woro et al., 2019*).

Pelaksanaan kegiatan edukasi kesehatan reproduksi remaja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yang memadukan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi personal. Kegiatan ini diikuti oleh remaja berusia 13–18 tahun yang menjadi siswa program penyuluhan kesehatan di SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta. Materi yang disampaikan difokuskan pada pemahaman dasar kesehatan reproduksi, dinamika perubahan pada masa pubertas, tantangan sosial yang dihadapi remaja, serta strategi perlindungan diri.

- a. Sesi pertama memaparkan definisi kesehatan reproduksi yang mencakup dimensi fisik, mental, dan sosial.
- b. Materi pada sesi kedua mencakup perubahan fisik (misalnya menstruasi, mimpi basah, perubahan suara, dan pertumbuhan fisik), perubahan emosional (fluktuasi emosi, peningkatan ketertarikan terhadap lawan jenis), serta perubahan sosial (dinamika hubungan dengan teman sebaya dan keluarga). Diskusi kelompok dilakukan dengan pemisahan siswa berdasarkan jenis kelamin untuk menjaga kenyamanan. Setiap kelompok mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan yang mereka alami, kemudian mempresentasikannya di forum besar.
- c. Pada sesi ketiga ini membahas tiga isu utama, yaitu paparan informasi palsu (hoaks) di media sosial, fenomena perundungan (bullying) baik secara langsung maupun daring, serta risiko pergaulan bebas. Diskusi diakhiri dengan klarifikasi materi oleh pemateri untuk memastikan pemahaman yang benar.
- d. Materi terakhir sesi keempat difokuskan pada penguatan konsep menghargai diri sendiri (self-respect) sebagai dasar pembentukan perilaku positif, serta teknik komunikasi sehat dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Simulasi role play digunakan untuk melatih keterampilan asertif, khususnya dalam menolak ajakan yang berisiko tanpa merusak hubungan sosial. Pada akhir kegiatan, siswa melakukan refleksi personal dengan menuliskan hal-hal baru yang mereka pelajari serta rencana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi penutup diisi dengan tanya jawab. Sebagai tindak lanjut, siswa menerima leaflet edukasi yang memuat ringkasan materi utama (*Rhamadianto & Shalihah, 2025*).

Media edukasi yang digunakan dalam konsep program pendidikan kesehatan reproduksi wanita menurut jurnal tersebut adalah media visual yang atraktif berupa *PowerPoint*. Media ini dirancang secara khusus dengan tampilan slide yang kekinian dan tidak monoton agar sesuai dengan karakteristik remaja masa kini. Penggunaan media visual ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan informasi kesehatan reproduksi yang sering dianggap tabu, terutama di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren. Selain materi dalam bentuk slide, program edukasi ini juga mengintegrasikan elemen interaktif seperti permainan (*games*) atraktif, sesi *ice breaking* yang seru, serta diskusi tanya jawab dua arah. Kombinasi antara teknologi visual yang menarik dengan metode penyampaian yang menyenangkan terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme responden, membantu mereka mengingat konsep ilmiah dengan lebih baik, serta mampu meluruskan berbagai mitos kesehatan reproduksi yang masih beredar di Masyarakat (*Suryani et al., 2025*).

E. Desain dan Implementasi Program Edukasi

1. Perencanaan Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Perencanaan program kesehatan reproduksi remaja merupakan proses sistematis dalam menyusun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi. Perencanaan ini sangat penting karena remaja berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti pergaulan bebas, penyakit menular seksual, dan pernikahan dini (*Popyanti & Samosir, 2025*).

Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja merupakan tujuan yang penting dalam upaya mendorong kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi generasi muda. Berbagai upaya dapat dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan ini, dengan mempertimbangkan tantangan sosial dan peluang yang ada. Berikut ini adalah beberapa pendekatan terkini yang dapat dilakukan (*Rukmawati et al., 2024*):

a. Pendidikan Seks Komprehensif di Sekolah

Puspita Ningrum, Kusbaryanto (2021), Mendukung implementasi kurikulum pendidikan seks yang komprehensif di sekolah adalah langkah krusial. Kurikulum ini seharusnya mencakup informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anatomi tubuh, fungsi reproduksi, kontrasepsi, serta perlindungan dari penyakit menular seksual (PMS).

b. Akses yang Memadai terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi

Memastikan remaja memiliki akses yang mudah dan aman terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja sangat penting. Ini mencakup akses terhadap pelayanan konseling, pengujian PMS, dan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inisiatif seperti klinik kesehatan remaja atau layanan daring yang dapat diakses dengan privasi tinggi juga mendukung peningkatan akses ini (Getachew Assefa Zenebe, Temesgen Muche Ewunie, Moges Mareg Belay, Abinet Meno Abose ,2023,

c. Kesehatan Melalui Media Sosial dan Teknologi

Memanfaatkan media sosial dan teknologi sebagai platform untuk kampanye edukasi kesehatan reproduksi dapat mencapai remaja secara luas. Konten yang informatif, kreatif, dan relevan dapat disebarkan melalui aplikasi mobile, jejaring sosial, dan situs web untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang aman.

d. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Emosional

Mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum pendidikan dan program di luar sekolah dapat membantu

remaja dalam mengelola tekanan sosial, membangun hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan perilaku seksual. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan pemecahan masalah (Baiba Martinsone et al, 2022),

e. Partisipasi Remaja dalam Perencanaan Program

Mariam Mandoh, Seema Miharshahi, Hoi Lun Cheng, Julie Redfern, Stephanie R. Partridge (2020), Melibatkan remaja dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan reproduksi dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas intervensi. Mendengarkan suara mereka, memahami kebutuhan serta perspektif mereka, dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan dapat meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan program-program tersebut.

f. Advokasi untuk Kebijakan Publik Pro-Kesehatan Reproduksi Remaja

U. Asogwa, (2022) Mendukung advokasi untuk kebijakan publik yang mendukung kesehatan reproduksi remaja, termasuk perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan pendidikan seks yang inklusif, merupakan upaya penting. Ini melibatkan kerja sama dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk memastikan lingkungan hukum dan sosial yang mendukung kesehatan reproduksi remaja.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini secara holistik dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka dengan baik. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Materi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Pengembangan materi edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja harus dirancang sebagai sebuah *life skill* (keterampilan hidup) yang dapat digunakan dalam keseharian untuk menjaga kesejahteraan siklus hidup, khususnya bagi remaja putri. Materi ini sangat penting dikembangkan karena masa remaja merupakan periode transisi sensitif yang penuh rasa ingin tahu, kecenderungan mengambil risiko, dan tantangan perkembangan secara fisiologis maupun psikologis (Widiawati & Selvi, 2022)

fokus pengembangan materi edukasi mencakup beberapa poin utama:

a. Identifikasi Masalah Utama: Materi diarahkan untuk menjawab masalah yang sering dialami remaja, yaitu terkait siklus menstruasi dan proses terjadinya kehamilan.

- b. Komponen Pengetahuan Komprehensif: Edukasi harus memuat informasi mengenai risiko, masalah kesehatan reproduksi, serta cara pencegahannya agar remaja memiliki bekal yang tepat dalam merawat organ reproduksinya.
 - c. Pencegahan Perilaku Berisiko: Materi dikembangkan untuk meminimalisir perilaku menyimpang, seperti seks bebas, pernikahan usia dini, kehamilan di luar nikah, kekerasan seksual, penyalahgunaan NAPZA, hingga pencegahan HIV-AIDS.
 - d. Pemanfaatan Berbagai Media: Pengembangan edukasi tidak lagi hanya terpaku pada metode ceramah, melainkan memanfaatkan berbagai media yang dekat dengan gaya hidup remaja, antara lain:
 - 1) Media Visual & Audio Visual: Penggunaan video edukasi, video AVA, film (seperti film "Dua Garis Biru"), serta media leaflet.
 - 2) Teknologi Digital: Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan, penggunaan Google Meet untuk edukasi daring, hingga pengembangan aplikasi berbasis Android
 - e. Integrasi Institusi: Pengembangan materi dilakukan melalui sinergi antara sekolah (melalui guru biologi atau Unit Kesehatan Sekolah/UKS), peran aktif orang tua dalam keluarga, serta dukungan tenaga kesehatan melalui program posyandu remaja atau *peer educator*.
3. Strategi Implementasi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Untuk menerapkan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga adaptif terhadap karakteristik perkembangan mereka. Remaja berada pada fase yang sangat dinamis, di mana perubahan fisik, emosional, dan cara berpikir terjadi secara bersamaan. Karena itu, penyampaian edukasi harus dirancang secara sistematis, menarik, serta mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan mereka.

Salah satu pendekatan yang penting adalah pemanfaatan media berbasis teknologi dan visual. Di era digital saat ini, remaja cenderung lebih mudah menerima informasi melalui media yang interaktif dan menarik secara visual. Penggunaan video edukasi seperti media audio-visual terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional karena mampu meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Selain itu, aplikasi berbasis Android dan platform pembelajaran daring seperti Google Meet memberikan fleksibilitas bagi remaja untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Media sosial juga memiliki peran besar karena dapat membentuk pola pikir dan gaya hidup, sehingga jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan kesehatan reproduksi.

Di sisi lain, institusi pendidikan memiliki peran strategis karena menjadi lingkungan utama tempat remaja berinteraksi. Sekolah dapat menjadi wadah

yang efektif untuk mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi secara terstruktur. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dapat difungsikan secara optimal sebagai pusat layanan informasi dan skrining kesehatan. Selain itu, materi kesehatan reproduksi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, khususnya dalam pembelajaran biologi, sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Program pendukung seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian suplemen penambah darah terutama bagi remaja perempuan, serta pembentukan kader kesehatan melalui pendidik sebaya dan kegiatan Posyandu Remaja juga sangat penting untuk memperkuat implementasi di sekolah.

Pendekatan berikutnya adalah melalui keluarga dan komunitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk sikap dan perilaku remaja, sehingga peran orang tua sangat krusial dalam memberikan pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi. Komunikasi yang terbuka dapat membantu menghilangkan anggapan bahwa topik ini adalah sesuatu yang tabu, sehingga remaja merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Selain itu, keterlibatan komunitas seperti Karang Taruna juga dapat memperluas jangkauan edukasi melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok remaja, sehingga pesan kesehatan dapat diterima secara lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, materi edukasi kesehatan reproduksi sebaiknya tidak hanya berfokus padapengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup. Remaja perlu dibekali kemampuan untuk mengelola kesehatan diri, termasuk memahami siklus menstruasi dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Mereka juga perlu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menghindari perilaku berisiko seperti seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual, serta penularan penyakit seperti HIV/AIDS. Selain itu, edukasi gizi juga menjadi bagian penting, terutama untuk meningkatkan kesadaran mengenai anemia yang sering dialami remaja perempuan, sehingga mereka dapat menjaga kondisi kesehatan secara menyeluruh.

Dengan menggabungkan pendekatan teknologi, pendidikan formal, peran keluarga, serta penguatan keterampilan hidup, edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dapat dilakukan secara lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan (*Bahar et al., 2025*).

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Tema-tema utama dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja dapat dipahami melalui dua sisi besar, yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Keduanya saling memengaruhi dalam menentukan sejauh mana edukasi dapat diterima dan diterapkan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor pendukung pada dasarnya berkaitan dengan segala hal yang mampu meningkatkan literasi, pengetahuan, serta cara pandang remaja terhadap kesehatan reproduksi. Salah satu unsur penting adalah penggunaan media edukasi yang tepat. Media visual seperti leaflet memberikan kemudahan karena informasi dapat dibaca berulang kali, sehingga cocok bagi remaja yang memiliki keterbatasan waktu atau konsentrasi. Sementara itu, media audio-visual seperti video atau film pendek cenderung lebih menarik karena mengandung unsur cerita dan emosi yang membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat. Selain itu, keberadaan modul yang terstruktur juga membantu remaja untuk belajar secara mandiri, terutama dalam memahami aspek biologis dan risiko perilaku yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Peran keluarga juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang benar dan mengurangi kesalahpahaman. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik dan bersikap terbuka dapat menjadi pelindung utama bagi remaja dari berbagai risiko. Pola asuh yang suportif turut membantu membentuk sikap tanggung jawab pada remaja, termasuk dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi, serta dapat menekan risiko terjadinya pernikahan dini.

Selain itu, integrasi kearifan lokal menjadi kekuatan tersendiri dalam penyampaian edukasi. Ketika pesan kesehatan dikemas dengan nilai-nilai budaya yang sudah dikenal, seperti norma menjaga kehormatan atau makna ritual pubertas, maka penerimaannya menjadi lebih mudah. Pemanfaatan media sosial yang disesuaikan dengan konteks budaya juga dapat memperluas jangkauan edukasi. Bahkan, media berbasis budaya seperti film pendek dengan muatan lokal terbukti efektif dalam menjembatani perbedaan antara norma sosial dan informasi medis yang seringkali dianggap sensitif.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang membuat remaja lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan informasi dan pengetahuan. Rendahnya literasi, khususnya di daerah tertentu, menyebabkan remaja kesulitan memperoleh informasi yang akurat. Di lingkungan sekolah, materi yang disampaikan seringkali hanya berfokus pada aspek biologis, tanpa membahas dimensi psikososial maupun hak reproduksi secara menyeluruh, sehingga pemahaman remaja menjadi tidak utuh.

Hambatan sosial dan komunikasi juga berperan besar. Anggapan bahwa topik seksualitas adalah sesuatu yang tabu membuat diskusi terbuka menjadi sulit dilakukan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Akibatnya, remaja cenderung mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu dapat

dipercaya. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya ruang dialog yang aman dan terbuka bagi remaja untuk bertanya atau mengungkapkan kebingungannya.

Selain itu, pengaruh lingkungan turut menjadi tantangan yang signifikan. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong remaja untuk mengikuti perilaku yang berisiko, terutama jika kelompok tersebut memiliki pemahaman yang keliru tentang kesehatan reproduksi. Di era digital, paparan media yang tidak terkontrol juga menjadi masalah serius, karena konten yang tidak edukatif dapat membentuk persepsi yang salah mengenai seksualitas dan hubungan interpersonal.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan kesehatan reproduksi remaja sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memaksimalkan faktor pendukung sekaligus meminimalkan berbagai hambatan yang ada. Pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan media, keluarga, sekolah, budaya, serta lingkungan sosial, menjadi kunci agar edukasi yang diberikan tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan remaja (*Dwi et al., 2025*).

F. Model dan Pendekatan Evaluasi Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Model evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam pendekatan *peer education*, menekankan pentingnya melihat keterlibatan peserta secara menyeluruh. Evaluasi partisipasi tidak hanya terbatas pada kehadiran peserta dalam setiap sesi, tetapi juga mencakup bagaimana mereka berperilaku selama kegiatan berlangsung. Pengamatan langsung menjadi cara yang efektif untuk menilai apakah peserta benar-benar terlibat secara aktif atau hanya hadir secara fisik. Selain itu, keterlibatan juga dilihat dari kontribusi peserta dalam diskusi, kemampuan mereka bekerja dalam kelompok, serta peran mereka dalam membantu teman sebaya memahami materi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, metode kualitatif seperti wawancara atau refleksi peserta sering digunakan, karena mampu mengungkap motivasi, persepsi manfaat program, hingga hambatan yang mereka alami. Evaluasi ini tidak bersifat sekali selesai, melainkan dilakukan secara berkelanjutan agar penyelenggara dapat segera merespons kendala yang muncul dan meningkatkan kualitas program secara bertahap.

Salah satu pendekatan evaluasi yang banyak digunakan adalah model Kirkpatrick, yang menilai efektivitas program melalui empat tahapan. Pada tahap awal, evaluasi difokuskan pada reaksi peserta terhadap program, seperti tingkat kepuasan mereka terhadap materi, metode penyampaian, dan suasana

pembelajaran. Tahap berikutnya menilai pembelajaran, yaitu sejauh mana peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, yang biasanya diukur melalui tes atau penilaian pemahaman. Setelah itu, evaluasi berlanjut pada perubahan perilaku, yaitu apakah peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tahap terakhir menilai hasil jangka panjang, seperti perubahan sikap, peningkatan kualitas hidup, atau dampak sosial yang lebih luas. Melalui tahapan ini, program dapat dinilai secara komprehensif, mulai dari respons awal hingga dampak yang berkelanjutan.

Selain itu, Logic Model juga menjadi kerangka yang penting dalam merancang sekaligus mengevaluasi program edukasi kesehatan reproduksi. Model ini membantu menggambarkan keterkaitan antara sumber daya yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, serta hasil yang ingin dicapai. Program diawali dengan identifikasi input seperti tenaga pelaksana, anggaran, dan materi edukasi. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan, seperti pelatihan atau diskusi kelompok, dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaannya. Dari aktivitas tersebut dihasilkan output berupa peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta. Lebih lanjut, hasil yang ingin dicapai mencakup perubahan sikap dan perilaku remaja dalam jangka menengah. Pada akhirnya, dampak yang diharapkan adalah perubahan jangka panjang, baik pada individu maupun masyarakat, seperti meningkatnya kesehatan reproduksi dan menurunnya perilaku berisiko. Dengan memahami alur ini, program dapat dirancang lebih sistematis dan terarah.

Dalam praktiknya, evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi juga memanfaatkan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan keduanya. Pendekatan kuantitatif umumnya digunakan untuk mengukur perubahan yang dapat dihitung, seperti peningkatan pengetahuan atau perubahan sikap melalui kuesioner sebelum dan sesudah intervensi. Sementara itu, pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui wawancara atau diskusi, sehingga dapat menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi peserta. Kombinasi keduanya, yang dikenal sebagai *mixed methods*, kini banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program, baik dari sisi angka maupun pengalaman nyata peserta. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menunjukkan apakah program berhasil, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa program tersebut memberikan dampak (Yumni et al., 2025).

G. Kesimpulan

Kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh serta menyeluruh terkait sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada individu berusia 10 hingga 19 tahun, yang bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga mencakup kemampuan menjalani kehidupan yang aman, bertanggung jawab, dan terbebas dari diskriminasi serta kekerasan; mengingat masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai perubahan besar secara biologis, psikologis, dan sosial, serta rasa ingin tahu yang tinggi namun sering kali tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai, kelompok ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi, sebagaimana tercermin dari data global yang menunjukkan tingginya angka kehamilan remaja, aborsi tidak aman, dan penularan infeksi menular seksual serta HIV/AIDS, serta kondisi di Indonesia yang mencatat peningkatan kasus infeksi menular seksual hingga 42,4% dan sekitar 19% remaja mengalami kehamilan tidak direncanakan, di mana permasalahan ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor mulai dari aspek biologis, pengetahuan, sikap, nilai budaya, norma sosial, hingga akses terhadap informasi dan layanan kesehatan serta pengaruh media sosial yang bisa bersifat positif maupun negatif. Berangkat dari kondisi tersebut, edukasi kesehatan reproduksi menjadi upaya strategis dan krusial yang bertujuan tidak hanya untuk mencegah terjadinya perilaku berisiko, namun juga untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, menanamkan rasa menghargai diri, serta mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan remaja dalam mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, dengan materi yang disusun secara komprehensif mencakup pemahaman pubertas, kebersihan diri, fungsi reproduksi, pencegahan penyakit, hingga kemampuan komunikasi dan perlindungan diri, serta disampaikan berdasarkan prinsip kesesuaian usia, akurasi informasi, keterbukaan, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap nilai budaya serta agama yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, program edukasi ini menuntut penerapan metode yang bervariasi, partisipatif, dan sesuai karakteristik remaja masa kini, mulai dari pendekatan pendidikan sebaya, diskusi kelompok, simulasi, hingga pemanfaatan beragam sarana edukasi berbasis visual, audio visual, dan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi, serta konten interaktif yang terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian dan mempermudah pemahaman, di samping itu program ini juga harus direncanakan secara sistematis, dikembangkan materi yang relevan dengan kebutuhan remaja, serta diimplementasikan melalui strategi multidimensi yang mengintegrasikan peran sekolah, keluarga, dan komunitas agar pesan kesehatan dapat diterima dan

diterapkan dengan baik. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung seperti dukungan keluarga, penggunaan media yang tepat, serta kesesuaian dengan nilai budaya, namun juga harus berupaya mengatasi berbagai hambatan yang ada, antara lain anggapan masyarakat yang menganggap topik ini tabu, rendahnya literasi kesehatan, serta pengaruh negatif lingkungan dan informasi yang tidak benar; untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan pula evaluasi yang menyeluruh dan berkesinambungan menggunakan berbagai model seperti model partisipasi, Kirkpatrick, Logic Model, maupun gabungan metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar perbaikan program demi tercapainya tujuan akhir, yaitu perlindungan remaja dari risiko kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas kesehatan secara menyeluruh, serta pembentukan generasi muda yang sehat, mandiri, bertanggung jawab, dan siap menjalani kehidupan dewasa serta membangun keluarga yang sehat di masa depan.

Referensi

- Agma, A. R. (2025). Efektivitas Edukasi Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan Remaja Putri. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 01(01), 23–29.
- Agustin, A., Puswati, D., Dyna, F., & Febriyeni, C. (2026). Hubungan Akses Informasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Sosial dengan Pengetahuan Remaja Putri tentang Kesehatan Reproduksi di SMA Negeri 5 Pekanbaru. 5(1), 4641–4648.
- Astuti. (2023). *Buku Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia*.
- Bahar, H., Amalia, N. R., Indriyani, N., Gauzalia, P. G., Rahayu, S., Gala, S. T., & Sartika, W. (2025). Efektivitas Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Siswa Siswi di MTSN 01 Kendari. *The Journal General Health and Pharmaceutical Sciences Research*, 3(2), 134–145.
- Chapsah, U., Syamsiyah, R. M., Salsabilla, L., & Hidayati, N. (2022). Edukasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan risiko reproduksi remaja. 1, 82–87.
- Citrawati. (2022). Faktor Determinan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan. 2, 316–322.
- Dwi, D., Ambali, W., Uly, N., & Alim, A. (2025). Pendidikan dan Komunikasi dalam Kesehatan Reproduksi Remaja: Systematic Literatur Review terhadap Faktor Risiko dan Strategi Intervensi. 8(4), 819–831.
- Fatmawati Yuli, T., Perwitasari, T., Astuti Puji, H., Suharmi, Tiwi Sanilpa, L., & Nurfitriani. (2024). *Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- Handayani Kasmini Woro, O., Wiranti, I., Raharjo Budi, B., & Nugroho, E. (2019). *The Reproduction Health Behavior of High School Teenagers in Semarang , Indonesia*. 309–314. <https://doi.org/10.2174/1874944501912010309>
- Kusumawardani Arine, D., Alwi Akbar, M., Rizana Afrita, N., Eliyana, Y., Widodo Maedji Tjahjono, H., Rukmini, Muchlisa, N., Rakhmah, D., Rezkiyani, S., & Sari Maya, N. (2026). *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Di Era Globalisasi*.
- Nanda, S., Tarigan, R., Nurwita, A., Rini, A. S., Windiany, E., Rizyana, N. P., Yulika, I., & Yulianti, N. (2025). *Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- Popyanti, D., & Samosir, H. E. (2025). Perencanaan Pengurus Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 327–340. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2907>
- Pratiwi Dewi, R. (2025). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif*
- Pratiwi, R. A., & Lismayanti, L. (2026). *Remaja (Literature Riview)*. 4(1), 94–100.
- Rhamadianto, M. I., & Shalihah, N. M. (2025). Edukasi Kesehatan Reproduksi sebagai Upaya Preventif Permasalahan Remaja. *Room of Civil Society*

Development, 4(5), 769–778. <https://doi.org/10.59110/rcsd.750>

- Rohman, A. A., Aniroh, U., Waluyo, U. N., Diinginkan, K. T., & Reproduksi, K. (2025). *Strategi Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Edukasi Menggunakan Media Video Animasi*. 7(1), 215–223.
- Rohmawati. (2023). *Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi remaja*. 5, 2632–2640.
- Rukmady Gaffar, A., Purnamasari, N., Mallapiang, F., & Sadarang Insani Aulia, R. (2022). *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health Service) Evaluasi Program Edukasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Remaja Abdul*. 2(1), 60–66.
- Rukmawati, S., Susanti, R., Rahma, K., Isfentiani, D., Wildayani, D., Nurfiti, N. R., Oktaviana, M. N., Arfiani, Kusumawati, D. D., Wahyunita, V. D., Dwihestie, L. K., Milindasari, P., Handayani, R., Imeldawati, R., & Sasanti, S. D. (2024). *Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Permasalahannya*.
- Saleha, S. (2024). *Buku ajar perempuan dan kesehatan keluarga*.
- Sholikhah, M., Hidayatullah, A. S., & Abidin, Z. (2025). *Perkembangan Pubertas Pada Remaja : Kajian Literatur Komprehensif*. 9, 5820–5828.
- Suryani, S., Septiyani Putri, K., & Aliyah, N. (2025). *Jurnal Kebidanan Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Attractive Media Visual Pendahuluan Kesehatan reproduksi memainkan peran penting dalam kesehatan secara keseluruhan dan berfungsi sebagai indikator utama berharga yang akan memikul tang*. XVII(02), 148–159.
- Suwarno, S. S. (2026). *Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap pada remaja siswa sma*. 03(01), 46–54.
- Tresnayanti, N., Nengsih, Y., Herawati, Y., Inayah Tri, N., Syafitri Athiyyah, N., Devi, D., Ikrimah, R., & Isnasari, F. (2025). *Reproduksi Pada Remaja Putri Di Smk Alwahyu Tahun*.
- Wahyuni, S., & Arisani, G. (2022). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 11(30), 426–432.
- Widiawati, S., & Selvi, S. (2022). Edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30644/jphi.v4i1.631>
- Yumni, H., Nurcahyanti, F. D., Martilova, D., Aminah, S., Yuhandini, D. S., Pramuwidya, A., & Margiyanti, N. J. (2025). *Buku Referensi Peran Bidan Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- Yunus, M., Amelia, D., Suprobo, N. R., Devi, T., Athallah, R. F., Andi, M., Billah, A., & Aurellia, R. (2025). *PROMOTIF: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PROTEKSI: Program edukasi dan konseling terintegrasi untuk remaja sebaya tentang kesehatan reproduksi PROTEKSI: An integrated*

education and counseling program for adolescents on reproductive health. 5, 150–162.

Yusnia, N., Nashwa, R., Handayani, D., Melati, D., & Nabila, F. (2022). *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Mengenai Bahaya Seks Bebas*. 114–123.

PROFIL PENULIS



Vivin Indrianita, S.S.T., M.Psi.

Lahir di Probolinggo, 20 Juli 1989. Beragama Islam. Lulus D4 Kebidanan STIKES Insan Unggul Surabaya pada tahun 2011. Pada tahun 2015 melanjutkan Studi Magister Psikologi Di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap di Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Surabaya sebagai Ketua LPPM, sekaligus sebagai mahasiswa aktif di Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang serta aktif di berbagai penelitian, pelatihan dan seminar kebidanan.



Lusiana Ambarsari, S.Tr.Keb., M.Keb.

lahir di Klaten, 14 November 1996. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di STIKes Mitra Husada Karanganyar pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Terapan (D4) Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2020. Pendidikan magister ditempuh pada Program Studi Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan diselesaikan pada tahun 2022. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Klaten. Dalam menjalankan tugas akademik, penulis mengampu beberapa mata kuliah, seperti Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas, Komunikasi dalam Kebidanan, Etika dan Hukum Kesehatan, serta Anatomi Fisiologi. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan karya ilmiah, publikasi ilmiah, seminar akademik, serta pengembangan bahan ajar di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi.

Sejak masa studi, penulis memiliki ketertarikan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kebidanan komunitas, serta kesehatan mental remaja. Melalui karya tulis ini, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur kebidanan, khususnya terkait pendampingan kesehatan reproduksi remaja putri. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, akademisi, dan pembaca umum. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lusianaambarsari96@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Meriem Meisyaroh Syamson, S.Kep., M.Kes.

Penulis merupakan tenaga pengajar (dosen) di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis Kelahiran Rappang, 23 Mei 1990 ini terbelang berpengalaman mengajar di bidang Ilmu Keperawatan. Penulis menempuh jenjang akademik S1 Keperawatan dan Profesi Ners di STIKES Nani Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 2014. Penulis Kemudian menamatkan pendidikan Magister pada jurusan Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Promosi Kesehatan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan lulus tahun 2017 dan saat ini telah melaksanakan proses studi Pendidikan Doktor (S3). Karir mengajar dengan menjadi dosen di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap mulai pada tahun 2017, Penulis tersertifikasi tahun 2020. Mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan, Keperawatan Maternitas dan Keperawatan dan Kesehatan Reproduksi, merupakan mata kuliah penulis. Penulis aktif menulis pada Buku berISBN penulis aktif melakukan Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal International bereputasi, saat ini Jabatan fungsional penulis yaitu Lektor Kepala, Email Penulis: meriemmeisyaroh90@gmail.com dan meriem.itkesmu@gmail.com



Dr. Dita Humaeroh, S.SiT., Bdn., M.K.M.

Lahir di Karawang, 20 November 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program kebidanan, STIKes Mitra RIA Husada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2017, Pendidikan Profesi di Program Studi Pendidikan profesi Bidan di Politeknik Bhakti Asih Purwakarta Tahun 2024, dan Pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Tahun 2025. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Bhakti Asih Purwakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ditahumaeroh@polbap.ac.id
Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

lahir di Klaten, 12 April 1994. Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang kebidanan yang memiliki minat pada kesehatan maternal, kesehatan reproduksi remaja, dan komplementer. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Studi Kebidanan jenjang Diploma IV di Stikes Karya Husada Semarang dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada bidang Ilmu Kebidanan dan menyelesaikan studi pada tahun 2019. Dalam perjalanan karier akademik, penulis aktif sebagai dosen dan terlibat dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif dalam penyusunan bahan ajar, publikasi ilmiah, seminar nasional, penelitian hibah, serta pengembangan media edukasi kesehatan khususnya pada bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Saat ini penulis mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Klaten dan mengampu beberapa mata kuliah di bidang kebidanan, metodologi penelitian, kesehatan reproduksi, neonatus, serta kebidanan komunitas. Selain kegiatan akademik, penulis juga aktif mendampingi mahasiswa dalam penelitian dan kegiatan ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: amrinanurrohmah12@gmail.com

Motto: ***"A strong woman is built by resilience, rising through every challenge, growing through every struggle, and shining through every storm"***

PROFIL PENULIS



Cynthia Puspariny, S.S.T., Bdn., M.Kes.

Penulis lahir di Bandar Lampung, 25 September 1985. Ia merupakan dosen dan praktisi kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu pada Program Studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

Menempuh pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali, DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Surakarta, serta Magister Kesehatan Masyarakat konsentrasi Kesehatan Reproduksi di Universitas Malahayati lalu Aktif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja, kesehatan perempuan, konseling kebidanan, serta terapi komplementer. Beberapa karya ilmiah dan publikasinya terindeks.

Selain mengajar, penulis juga aktif menyusun buku ajar dan melakukan edukasi kesehatan reproduksi berbasis promotif dan preventif untuk remaja dan masyarakat.



Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes.

lahir di Malino Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Perawat Banta-bantaeng Makassar pada tahun 1994, Gelar Magister Kesehatan di peroleh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004 pada peminatan Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi. Tahun 2016 sampai 2021 melanjutkan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin Makassar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Karier dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Perawat Kesehatan Palopo, lalu pada tahun 1998 – 2000 di Akademi Perawat Jiwa Makassar serta pada tahun 2000 – 2008 di Politeknik Kesehatan Tidung dan sekarang di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menjabat sebagai sekretaris Jurusan Keperawatan pada tahun 2019 – 2023. Menjabat sebagai ketua program studi profesi ners tahun 2023 sampai dengan 2025. Ketua Progam studi Magister Keperawatan Pascasarjana UIN Alauddin tahun 2025 sampai sekarang. Terpilih sebagai ketua Ikatan Perawat Maternitas Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 – 2027, Sejak memulai karier sampai sekarang mengampuh mata kuliah keperawatan maternitas. E-mail: hasnah.nur@uin-alauddin.ac.id;

Google scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=jDDw31cAAAAJ&hl=id>

Sinopsis

Bunga rampai *Pendampingan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri* disusun sebagai rujukan komprehensif bagi tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta pihak sekolah dalam mendampingi remaja putri melewati masa transisi menuju dewasa dengan sehat, aman, dan bermartabat. Masa remaja merupakan periode krusial yang ditandai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat. Tanpa pendampingan dan informasi yang tepat, remaja putri berisiko menghadapi berbagai permasalahan seperti gangguan menstruasi, anemia, malnutrisi, hingga perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang.

Bab pertama menguraikan konsep dasar kesehatan reproduksi remaja putri sebagai landasan pemahaman, meliputi hak kesehatan reproduksi, aspek anatomi-fisiologi, serta prinsip pendampingan yang ramah remaja. Bab kedua membahas perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja, termasuk dinamika emosi, pembentukan identitas, pengaruh teman sebaya, dan tantangan lingkungan yang perlu dikenali oleh pendamping. Bab ketiga memfokuskan pada menstruasi sehat serta penanganan masalah menstruasi yang sering dialami remaja, dengan penekanan pada edukasi, deteksi dini, dan langkah penatalaksanaan sederhana yang dapat dilakukan bersama tenaga kesehatan.

Selanjutnya, bab keempat menekankan strategi pencegahan anemia, malnutrisi, dan perilaku berisiko melalui pendekatan promotif dan preventif yang aplikatif, termasuk pola makan bergizi, aktivitas fisik, serta penguatan ketahanan diri remaja. Bab kelima menguraikan edukasi personal hygiene dan praktik menjaga kesehatan reproduksi yang benar, sebagai upaya membangun kebiasaan sehat sejak dini dan mencegah masalah kesehatan yang umum terjadi pada remaja putri. Bab keenam menegaskan pentingnya kolaborasi bidan, keluarga, dan sekolah sebagai lingkungan pendukung utama, termasuk strategi komunikasi, konseling, dan pembentukan sistem rujukan yang responsif terhadap kebutuhan remaja.

Sebagai penutup, bab ketujuh membahas evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk memastikan kegiatan pendampingan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan memadukan konsep, praktik pendampingan, serta pendekatan lintas sektor, bunga rampai ini diharapkan menjadi panduan yang relevan dan mudah diterapkan dalam berbagai konteks pelayanan dan pendidikan, sehingga remaja putri dapat tumbuh dengan pengetahuan yang benar, perilaku sehat, serta kesiapan menghadapi masa depannya secara optimal.

Bunga rampai Pendampingan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri disusun sebagai rujukan komprehensif bagi tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta pihak sekolah dalam mendampingi remaja putri melewati masa transisi menuju dewasa dengan sehat, aman, dan bermartabat. Masa remaja merupakan periode krusial yang ditandai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat. Tanpa pendampingan dan informasi yang tepat, remaja putri berisiko menghadapi berbagai permasalahan seperti gangguan menstruasi, anemia, malnutrisi, hingga perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang.

Bab pertama menguraikan konsep dasar kesehatan reproduksi remaja putri sebagai landasan pemahaman, meliputi hak kesehatan reproduksi, aspek anatomi-fisiologi, serta prinsip pendampingan yang ramah remaja. Bab kedua membahas perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja, termasuk dinamika emosi, pembentukan identitas, pengaruh teman sebaya, dan tantangan lingkungan yang perlu dikenali oleh pendamping. Bab ketiga memfokuskan pada menstruasi sehat serta penanganan masalah menstruasi yang sering dialami remaja, dengan penekanan pada edukasi, deteksi dini, dan langkah penatalaksanaan sederhana yang dapat dilakukan bersama tenaga kesehatan.

Selanjutnya, bab keempat menekankan strategi pencegahan anemia, malnutrisi, dan perilaku berisiko melalui pendekatan promotif dan preventif yang aplikatif, termasuk pola makan bergizi, aktivitas fisik, serta penguatan ketahanan diri remaja. Bab kelima menguraikan edukasi personal hygiene dan praktik menjaga kesehatan reproduksi yang benar, sebagai upaya membangun kebiasaan sehat sejak dini dan mencegah masalah kesehatan yang umum terjadi pada remaja putri. Bab keenam menegaskan pentingnya kolaborasi bidan, keluarga, dan sekolah sebagai lingkungan pendukung utama, termasuk strategi komunikasi, konseling, dan pembentukan sistem rujukan yang responsif terhadap kebutuhan remaja.

Sebagai penutup, bab ketujuh membahas evaluasi program edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk memastikan kegiatan pendampingan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan memadukan konsep, praktik pendampingan, serta pendekatan lintas sektor, bunga rampai ini diharapkan menjadi panduan yang relevan dan mudah diterapkan dalam berbagai konteks pelayanan dan pendidikan, sehingga remaja putri dapat tumbuh dengan pengetahuan yang benar, perilaku sehat, serta kesiapan menghadapi masa depannya secara optimal.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-23-7 (PDF)



9

786347

756237